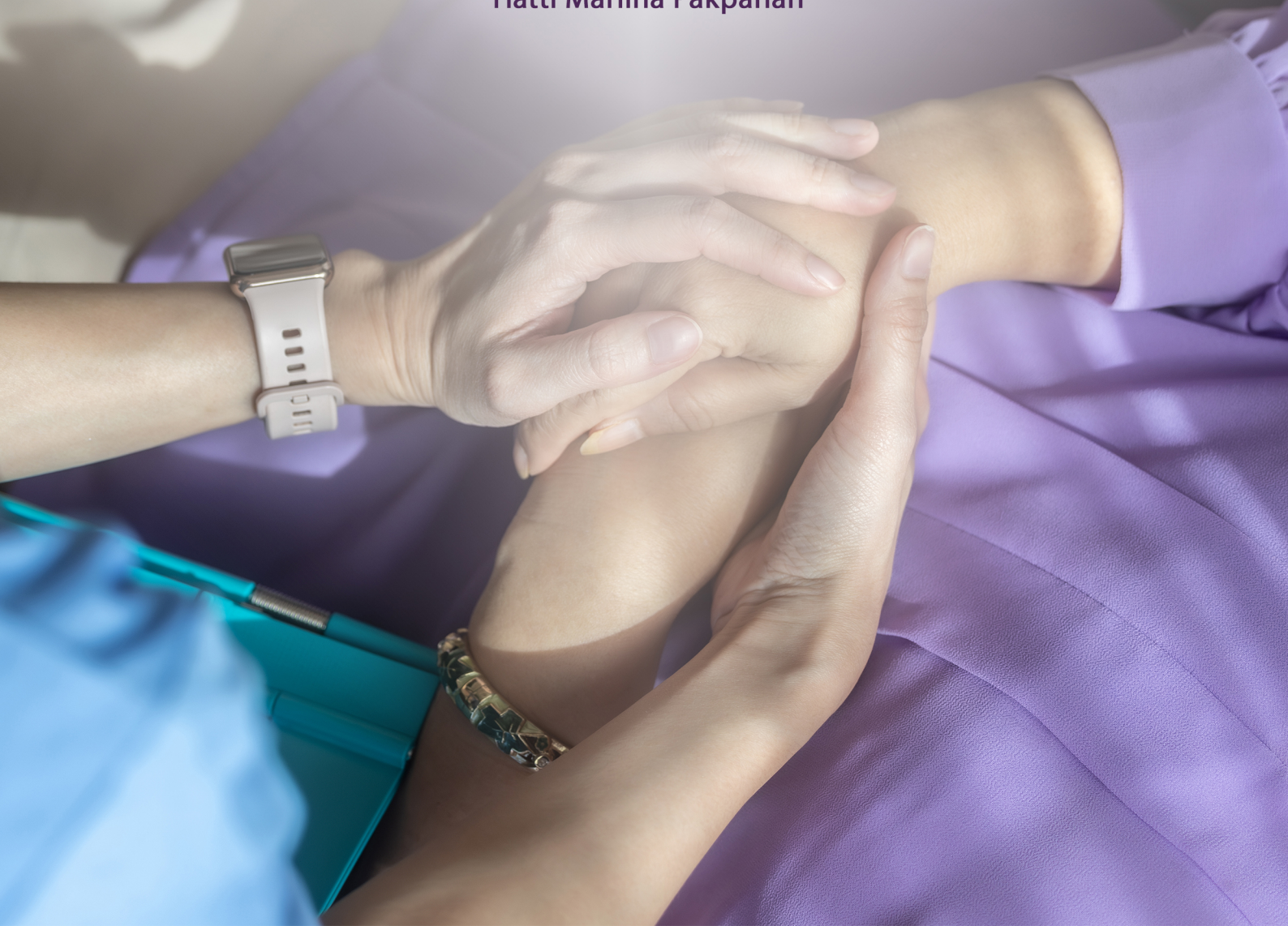


Buku Ajar **KEPERAWATAN PALIATIF**

Dewi Nur Sukma Purqoti • Dwi Prihatin Era • Christina Yeni Kustanti
Ana Fadilah • Syafrina Arbaani Djuria • Sri Hartini
Hatti Marlina Pakpahan



BUKU AJAR KEPERAWATAN PALIATIF

Penulis:

Dewi Nur Sukma Purqoti, S.Kep.,Ners., M.Kep.

Dr. Dwi Prihatin Era, S.Kp., M.Kep., SpMB.

Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Nur., M.Pall.C., Ph.D.

Ana Fadilah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ns. Syafrina Arbaani Djuria, S.Kep., M.Kep.

Sri Hartini, S.Kep., Ns., M.Kes.

Hatti Marlina Pakpahan, S.KM., S.Kep., NS., M.Kep.



BUKU AJAR KEPERAWATAN PALIATIF

Penulis: Dewi Nur Sukma Purqoti, S.Kep.,Ners., M.Kep.
Dr. Dwi Prihatin Era, S.Kp., M.Kep., SpMB.
Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Nur., M.Pall.C., Ph.D.
Ana Fadilah, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Syafrina Arbaani Djuria, S.Kep., M.Kep.
Sri Hartini, S.Kep., Ns., M.Kes.
Hatti Marlina Pakpahan, S.KM., S.Kep., NS., M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-623-89992-3-1

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku ajar ini yang berjudul "Buku Ajar Keperawatan Paliatif." Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi terhadap upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa keperawatan maupun tenaga kesehatan dalam memahami dan memberikan perawatan paliatif yang holistik dan humanis. Berbagai aspek mulai dari perspektif dan prinsip dasar, komunikasi terapeutik, hingga aspek spiritual dan manajemen nyeri dipaparkan secara komprehensif agar mudah diaplikasikan dalam praktik klinis.

Buku ini mencakup materi yang disusun secara sistematis dalam tujuh bab, dimulai dari perspektif umum keperawatan paliatif, konsep dasar perawatan paliatif, prinsip komunikasi terapeutik dalam merawat pasien dan keluarga, hingga manajemen spiritual dan nyeri yang integral dalam perawatan pasien terminal. Selain itu, pembaca juga akan dibimbing memahami patofisiologi berbagai penyakit kronik dan terminal serta pengkajian fisik dan psikologis secara mendalam, yang esensial untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dalam konteks perawatan paliatif.

Harapan kami, buku ini tidak hanya menjadi bahan referensi teoritis, tetapi juga mampu mendorong praktisi keperawatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan keluarga yang menghadapi situasi paliatif. Masukan dan kritik konstruktif dari para pembaca sangat kami nantikan demi peningkatan kualitas edisi mendatang. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dalam mendukung pelayanan keperawatan yang penuh empati, profesional, dan menghargai martabat manusia di akhir kehidupannya.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

BAB 1 PERSPEKTIF DAN PENDEKATAN PALIATIF DALAM KEPERAWATAN..... 1

A. Perawatan Paliatif dan Kualitas Hidup.....	5
B. Prinsip Dasar Keperawatan Paliatif.....	6
C. Manajemen Gejala dalam Keperawatan Paliatif	7
D. Aspek Psikososial dan Spiritual dalam Perawatan Paliatif	8
E. Etika dan Isu Hukum dalam Keperawatan Paliatif	10
F. Latihan Soal	11
G. Rangkuman Materi	11
H. Glosarium	12
I. Daftar Pustaka	14

BAB 2 KONSEP PERAWATAN PALIATIF 17

A. Pengertian Paliatif Care	19
B. Tujuan Perawatan paliatif.....	20
C. Lingkup Perawatan paliatif meliputi:	21
D. Konsep Pendampingan Pasien Terminal	21
E. Model/Tempat Perawatan Paliatif Care	22
F. Peran Perawat pada Asuhan Keperawatan Paliatif	22
G. Latihan	22
H. Rangkuman Materi	23
I. Glosarium	24
J. Daftar Pustaka	24

BAB 3 PRINSIP KOMUNIKASI DALAM PERAWATAN PALIATIF 27

A. Konsep Dasar Komunikasi di Perawatan Paliatif.....	29
B. Prinsip-prinsip Komunikasi dengan Pasien dan keluarganya	30
C. Teknik-teknik Komunikasi <i>Breaking Bad News</i>	34
D. Pertimbangan Etik dan Budaya dalam Komunikasi.....	40
E. Komunikasi Interdisipliner dan Kolaborasi Tim.....	42

F. Latihan	44
G. Rangkuman Materi	46
H. Glosarium	46
I. Daftar Pustaka	49

BAB 4 TINJAUAN SPIRITUAL TENTANG PERAWATAN PALIATIF53

A. Konsep Spiritualitas dalam Perawatan Paliatif	56
B. Hubungan antara Kebutuhan Spiritual dan Kualitas Hidup Pasien	57
C. Pengkajian Kebutuhan Spiritual Pasien.....	58
D. Diagnosa Keperawatan Berbasis Spiritual.....	60
E. Perencanaan dan Intervensi Berbasis Spiritual.....	61
F. Implementasi dan Evaluasi Intervensi Spiritual.....	62
G. Dokumentasi Intervensi Spiritual.....	64
H. Latihan	66
I. Rangkuman Materi.....	74
J. Glosarium	77
K. Daftar Pustaka	78

BAB 5 MANAJEMEN NYERI.....81

A. Definisi Nyeri.....	83
B. Klasifikasi Nyeri	83
C. Pengkajian Nyeri.....	84
D. Manajemen Farmakologi Nyeri	86
E. Manajemen Non Farmakologi Nyeri	87
F. Latihan	88
G. Rangkuman Materi.....	89
H. Glosarium	89
I. Daftar Pustaka	89

BAB 6 PATOFISIOLOGI BERBAGAI PENYAKIT KRONIK DAN TERMINAL91

A. Konsep Dasar Penyakit Kronik dan Terminal	93
B. Mekanisme Patofisiologi Umum pada Penyakit Kronik.....	95
C. Patofisiologi Penyakit Kronik Sistem Kardiovaskular dan Respirasi	98
D. Patofisiologi Penyakit Terminal (Fokus Kanker Stadium Lanjut).....	100
E. Pendekatan Manajemen dan Terapi Paliatif pada Penyakit Terminal.....	103

F. Latihan Soal	107
G. Rangkuman Materi	109
H. Glosarium	110
I. Daftar Pustaka	111
 BAB 7 PENGKAJIAN FISIK DAN PSIKOLOGIS.....	113
A. Konsep Dasar Pengkajian Fisik dan Psikologis.....	115
B. Teknik dan Metode dalam Pengkajian Fisik	117
C. Pengkajian Psikologis: Metode dan Implementasi	121
D. Integrasi dan Aplikasi Pengkajian Fisik dan Psikologis dalam Praktik Klinik	124
E. Pengkajian Khusus dan Pertimbangan Etis serta Legal dalam Pengkajian...	127
F. Latihan Soal	130
G. Rangkuman Materi	133
H. Glosarium	134
I. Daftar Pustaka	135
 PROFIL PENULIS	137

BAB 1

PERSPEKTIF DAN PENDEKATAN PALIATIF DALAM KEPERAWATAN

Tujuan Instruksional Umum

1. Memahami konsep dasar keperawatan paliatif dan pentingnya dalam meningkatkan kualitas hidup pasien.
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam praktik keperawatan paliatif.
3. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dengan pasien dan keluarga dalam konteks perawatan paliatif.

Tujuan Instruksional Khusus

1. Menjelaskan konsep dasar keperawatan paliatif dan pentingnya dalam meningkatkan kualitas hidup pasien
2. Mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik keperawatan paliatif.
3. Mengidentifikasi isu-isu etika yang muncul dalam perawatan paliatif.
4. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dengan keluarga pasien dalam konteks perawatan paliatif.

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar keperawatan paliatif.
2. Mahasiswa dapat menganalisis isu-isu etika yang muncul dalam perawatan paliatif.
3. Mahasiswa dapat merancang rencana perawatan yang holistik untuk pasien dengan penyakit terminal.

Pendahuluan

Definisi dan Konsep Dasar Keperawatan Paliatif

Keperawatan paliatif adalah pendekatan perawatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah terkait penyakit serius yang mengancam jiwa. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk mencegah dan meredakan penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang cermat, serta penanganan nyeri dan masalah lainnya, baik fisik, psikososial, maupun spiritual (Bridge, 2008) .

WHO mendefinisikan perawatan paliatif sebagai pendekatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga mereka yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit mengancam jiwa, melalui pencegahan dan penghilang penderitaan dengan identifikasi dini, penilaian yang tepat, dan pengobatan nyeri serta masalah-masalah lain, fisik, psikososial dan spiritual (García-Baquero Merino, 2018).

Perawatan paliatif merupakan pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, fisik, psikososial dan spiritual. Penyakit terminal merupakan penyakit progresif yang menuju kematian dan membutuhkan pendekatan perawatan paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang (WHO, 2023).

Penyakit terminal merupakan kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan dan pada akhirnya akan mengarah pada kematian. Ketika seseorang menerima vonis penyakit terminal, hal ini dapat menimbulkan dampak psikologis yang mendalam dan signifikan. Pasien sering kali mengalami berbagai reaksi emosional yang kompleks, yang dapat mempengaruhi cara mereka menghadapi kenyataan yang sulit ini.

Tahapan Emosi

Salah satu aspek penting dari pengalaman pasien adalah tahapan emosi yang mereka lalui. Model tahapan kesedihan yang dikemukakan oleh Kübler-Ross menjelaskan bahwa pasien dapat mengalami lima tahapan emosi yang berbeda. Tahapan pertama adalah penyangkalan, di mana pasien mungkin menolak untuk menerima diagnosis dan mencari pendapat kedua, berusaha meyakinkan diri bahwa diagnosis tersebut tidak benar. Setelah penyangkalan, pasien sering kali merasakan kemarahan. Kemarahan ini bisa diarahkan kepada diri sendiri, orang lain, atau bahkan kepada Tuhan, karena mereka merasa tidak adil atas penyakit yang menimpa mereka.

Selanjutnya, dalam tahap tawar-menawar, pasien mungkin mencoba untuk 'bernegosiasi' dengan kekuatan yang lebih tinggi, berharap untuk mendapatkan kesembuhan atau setidaknya perpanjangan waktu untuk hidup. Tahapan berikutnya

adalah depresi, di mana pasien merasakan kesedihan yang mendalam, putus asa, dan kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati. Akhirnya, pasien mencapai tahap penerimaan, di mana mereka mulai menerima kenyataan dari diagnosis yang mereka terima dan mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir hidup.

Penting untuk dicatat bahwa tahapan emosi ini tidak selalu terjadi secara berurutan. Pasien dapat mengalami tahapan-tahapan ini dalam urutan yang berbeda atau bahkan kembali ke tahapan sebelumnya, mencerminkan perjalanan emosional yang unik bagi setiap individu (Corr, 2021).

Dampak Psikologis

Pasien dengan penyakit terminal sering kali menghadapi berbagai dampak psikologis yang signifikan. Salah satu aspek yang umum adalah kecemasan yang muncul terkait dengan penyakit itu sendiri, proses pengobatan, dan kematian. Ketakutan akan rasa sakit dan penderitaan dapat menjadi beban yang berat bagi mereka. Selain itu, masalah tidur seperti kesulitan tidur, mimpi buruk, dan insomnia dapat memperburuk kondisi psikologis yang sudah rentan. Perubahan suasana hati yang drastis juga sering terjadi, di mana pasien dapat beralih dari perasaan sedih menjadi marah, atau dari ketenangan menjadi kecemasan. Aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati mungkin kehilangan daya tarik, dan motivasi untuk melakukan hal-hal sehari-hari bisa hilang. Rasa terisolasi dari orang lain, termasuk keluarga dan teman dekat, juga dapat muncul, menambah beban emosional yang mereka rasakan. Selain itu, perubahan fisik yang disebabkan oleh penyakit atau pengobatan dapat memengaruhi citra tubuh pasien, menyebabkan rasa tidak nyaman atau malu.

Dukungan untuk Pasien

Penting bagi pasien dengan penyakit terminal untuk mendapatkan dukungan dari berbagai sumber, termasuk keluarga, teman, dan tenaga kesehatan profesional. Dukungan ini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Pertama, dukungan emosional sangat krusial; mendengarkan, memberikan empati, dan menunjukkan rasa peduli dapat membantu pasien merasa lebih nyaman dan didukung dalam menghadapi kondisi mereka. Selain itu, dukungan praktis juga berperan penting; membantu pasien dengan tugas sehari-hari seperti memasak, membersihkan, atau berbelanja dapat mengurangi beban yang mereka rasakan.

Selanjutnya, konseling dan terapi dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu pasien mengatasi dampak psikologis dari penyakit terminal yang mereka hadapi (Low et al., 2024). Terakhir, dukungan spiritual juga tidak kalah penting; bagi pasien yang memiliki keyakinan agama, dukungan dari pemuka agama atau komunitas keagamaan dapat memberikan kenyamanan dan harapan di tengah tantangan yang mereka alami. Penting untuk diingat bahwa setiap pasien unik dan akan mengalami dampak psikologis yang berbeda. Memberikan dukungan dan pengertian merupakan

hal yang sangat penting bagi pasien yang menghadapi penyakit terminal (Madsen et al., 2023).

Kesimpulan mengenai keperawatan paliatif menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Perawatan paliatif memprioritaskan kenyamanan dan kesejahteraan pasien, mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Salah satu tujuan utama dari perawatan ini adalah pencegahan dan penghilang penderitaan, yang dicapai melalui identifikasi dini dan penanganan yang tepat untuk meminimalkan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang dialami pasien. Selain itu, perawatan paliatif juga memberikan dukungan holistik, tidak hanya kepada pasien tetapi juga kepada keluarga yang menghadapi penyakit dan proses berduka. Keberadaan perawatan paliatif sangat fleksibel, dapat diberikan sejak dini dan bersamaan dengan perawatan kuratif, bahkan sejak diagnosis penyakit serius ditegakkan. Yang menarik, perawatan ini berlaku untuk semua usia, sehingga dapat diakses oleh pasien dari segala kelompok umur, baik anak-anak maupun dewasa.

Pembahasan

1. Prinsip Dasar Keperawatan Paliatif
 - a. Pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.
 - b. Kolaborasi multidisiplin dalam memberikan perawatan yang komprehensif.
2. Manajemen Gejala
 - a. Strategi untuk mengelola nyeri dan gejala fisik lainnya.
 - b. Pendekatan farmakologis dan non-farmakologis dalam manajemen nyeri.
3. Aspek Psikososial dan Spiritual
 - a. Pentingnya dukungan psikologis bagi pasien dan keluarga.
 - b. Integrasi aspek spiritual dalam perawatan paliatif.
4. Etika dan Isu Hukum
 - a. Hak pasien dalam perawatan paliatif dan peran perawat dalam mendukung keputusan akhir hayat.

A. Perawatan Paliatif dan Kualitas Hidup

Perawatan paliatif berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu yang menghadapi penyakit serius. Perawatan ini menangani kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual untuk meringankan penderitaan dan meningkatkan kenyamanan serta kesejahteraan. Penting untuk dicatat bahwa perawatan paliatif sesuai pada setiap tahap penyakit serius, tidak hanya di akhir kehidupan, dan dapat diberikan bersamaan dengan perawatan kuratif.

1. Manfaat untuk Pasien

Perawatan paliatif berfokus pada manajemen gejala yang mengganggu pasien, seperti nyeri, mual, kelelahan, dan sesak napas. Dengan pendekatan ini, kenyamanan fisik pasien meningkat, memungkinkan mereka untuk lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tim perawatan paliatif terdiri dari profesional terlatih yang siap menangani masalah emosional dan spiritual. Mereka memberikan dukungan melalui konseling, kelompok dukungan, dan bimbingan spiritual, membantu pasien mengatasi rasa takut, kecemasan, depresi, serta pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mungkin muncul.

Perawatan paliatif juga memfasilitasi komunikasi yang terbuka antara pasien, keluarga, dan penyedia layanan kesehatan. Hal ini penting agar pasien dapat memahami pilihan perawatan yang tersedia, membuat keputusan yang terinformasi sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka, dan merasa lebih memiliki kendali atas perawatan yang mereka jalani. Selain itu, perawatan paliatif membantu pasien dan keluarga dalam menghadapi tantangan emosional dan praktis yang muncul akibat penyakit serius. Dengan demikian, mereka dapat beradaptasi dengan perubahan, mengembangkan mekanisme koping yang efektif, serta menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka.

2. Manfaat untuk Keluarga

Merawat orang tercinta yang menderita penyakit serius adalah tantangan berat, baik secara fisik maupun emosional. Dalam situasi sulit ini, perawatan paliatif muncul sebagai solusi penting, menawarkan istirahat bagi pengasuh yang sering merasa kelelahan, serta pelatihan dan dukungan emosional yang krusial. Tujuan utamanya adalah membantu keluarga mengelola beban perawatan yang menekan. Tim perawatan paliatif berperan penting dalam meningkatkan komunikasi antara keluarga dan tenaga medis, membantu mereka memahami kondisi pasien dan pilihan perawatan, sehingga keputusan dapat diambil bersama.

Selain itu, perawatan paliatif fokus pada pengurangan stres dan kecemasan keluarga, menyediakan dukungan komprehensif dan konseling duka untuk mengatasi kehilangan. Dengan pendekatan empatik, perawatan paliatif berusaha memberikan kenyamanan dan pengertian kepada keluarga yang menghadapi situasi menantang.

3. Peran Perawat dalam Perawatan Paliatif

Perawat memiliki peran penting sebagai pendamping pasien dan keluarga dalam perawatan paliatif. Mereka tidak hanya memberikan dukungan fisik, tetapi juga emosional, membantu pasien dan keluarga menghadapi tantangan yang muncul selama proses perawatan. Dalam konteks ini, perawat berfungsi sebagai penghubung antara pasien, keluarga, dan tim medis, memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan pasien dipahami dan dihormati.

Tanggung jawab perawat dalam pengelolaan gejala dan komunikasi sangat krusial. Perawat harus mampu mengidentifikasi dan mengelola gejala yang dialami pasien, seperti nyeri, mual, dan kecemasan, dengan pendekatan yang holistik. Selain itu, komunikasi yang efektif dengan pasien dan keluarga adalah kunci untuk memberikan informasi yang jelas dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dengan demikian, perawat berperan sebagai advokat bagi pasien, memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang sesuai dengan nilai dan preferensi mereka.

B. Prinsip Dasar Keperawatan Paliatif

1. Prinsip Holistik: Fisik, Psikologis, Sosial, dan Spiritual

Dalam keperawatan paliatif, pendekatan holistik menjadi landasan utama dalam memberikan perawatan kepada pasien. Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual dari pasien. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perawatan yang mempertimbangkan semua dimensi ini dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi rasa sakit serta kecemasan. Aspek fisik mencakup pengelolaan gejala dan nyeri, sementara aspek psikologis berfokus pada dukungan mental dan emosional. Di sisi sosial, penting untuk melibatkan keluarga dan komunitas dalam proses perawatan, sedangkan aspek spiritual membantu pasien menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka meskipun dalam kondisi yang sulit.

2. Pendekatan Multidisiplin dalam Keperawatan Paliatif

Pendekatan multidisiplin dalam keperawatan paliatif merupakan suatu strategi yang melibatkan kolaborasi antara berbagai profesional kesehatan untuk memberikan perawatan yang komprehensif kepada pasien (Korylchuk et al., 2024). Dalam konteks ini, kolaborasi dengan dokter, psikolog, pekerja sosial, dan

rohaniawan sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek kebutuhan pasien terpenuhi.

Kolaborasi dengan dokter, psikolog, pekerja sosial, dan rohaniawan: Setiap anggota tim memiliki keahlian dan perspektif unik yang berkontribusi pada perawatan pasien. Dokter bertanggung jawab atas diagnosis dan pengobatan medis, sementara psikolog membantu pasien dan keluarga dalam mengatasi masalah emosional. Pekerja sosial berperan dalam mendukung kebutuhan sosial dan praktis, sedangkan rohaniawan memberikan dukungan spiritual yang sering kali sangat dibutuhkan oleh pasien dalam fase akhir kehidupan.

Peran tim dalam memastikan kebutuhan pasien terpenuhi: Tim multidisiplin bekerja sama untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien. Dengan pendekatan ini, perawatan menjadi lebih holistik dan terintegrasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi keluarga mereka.

3. Komunikasi Efektif dengan Pasien dan Keluarga

Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam keperawatan paliatif. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan empatik antara perawat, pasien, dan keluarga dapat meningkatkan pemahaman tentang kondisi kesehatan dan pilihan perawatan. Dalam konteks ini, perawat harus mampu mendengarkan dengan baik, memberikan informasi yang jelas, dan menunjukkan empati (Babaii et al., 2021). Teknik komunikasi yang baik juga mencakup penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari jargon medis yang membingungkan. Dengan membangun hubungan yang kuat dan saling percaya, perawat dapat membantu pasien dan keluarga merasa lebih nyaman dalam menghadapi tantangan yang dihadapi.

C. Manajemen Gejala dalam Keperawatan Paliatif

1. Nyeri dan Manajemen Nyeri

Jenis nyeri dalam perawatan paliatif dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Pertama, terdapat perbedaan antara nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut biasanya bersifat sementara dan seringkali terkait dengan cedera atau prosedur medis. Di sisi lain, nyeri kronis berlangsung lebih lama dan dapat disebabkan oleh penyakit yang mendasari, seperti kanker. Selain itu, nyeri juga dapat dibedakan menjadi nyeri nociceptive dan nyeri neuropatik. Nyeri nociceptive disebabkan oleh kerusakan jaringan dan dapat berupa somatik atau visceral (Kidd et al., 2004), sedangkan nyeri neuropatik disebabkan oleh kerusakan atau disfungsi sistem saraf (Kiguchi et al., 2018).

Pendekatan Farmakologis dan Non-Farmakologis merupakan dua strategi penting dalam mengelola nyeri. Pendekatan Farmakologis melibatkan penggunaan analgesik seperti NSAID, opioid, dan adjuvan, termasuk antidepresan dan antikonvulsan, untuk mengelola nyeri secara efektif. Prinsip penggunaan tangga nyeri WHO juga diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping yang mungkin timbul. Di sisi lain, Pendekatan Non-Farmakologis mencakup teknik relaksasi, seperti pernapasan dalam dan meditasi, yang bertujuan untuk mengurangi persepsi nyeri (Ju et al., 2019). Selain itu, terapi fisik dan okupasi juga berperan penting dalam meningkatkan mobilitas pasien dan mengurangi ketegangan otot.

2. Gejala Fisik: Sesak Napas, Mual, Kelelahan

Sesak napas dapat disebabkan oleh penyakit paru-paru, gagal jantung, atau kanker. Strategi perawatan yang dapat dilakukan meliputi penggunaan oksigen tambahan, posisi tubuh yang tepat, dan teknik pernapasan untuk mengurangi ketidaknyamanan. Mual sering kali disebabkan oleh efek samping obat, gangguan pencernaan, atau penyakit yang mendasari. Untuk mengatasi mual, strategi perawatan yang dapat diterapkan adalah penggunaan antiemetik, modifikasi diet, dan akupresur. Kelelahan dapat disebabkan oleh penyakit kronis, pengobatan, atau kurang tidur. Untuk meningkatkan energi, manajemen energi, aktivitas fisik ringan, dan pola tidur yang teratur sangat dianjurkan.

3. Pendekatan Non-Farmakologis dalam Manajemen Gejala

Terapi relaksasi mencakup teknik-teknik seperti meditasi, yoga, dan visualisasi yang bertujuan untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Pijat terapeutik dilakukan untuk mengurangi ketegangan otot, meningkatkan sirkulasi, dan memberikan kenyamanan (Adrienne Santos-Longhurst, 2023). Aromaterapi melibatkan penggunaan minyak esensial yang dapat meningkatkan relaksasi serta mengurangi gejala seperti mual dan kecemasan. Selain itu, intervensi psikososial memberikan dukungan emosional dan konseling untuk membantu pasien dan keluarga dalam mengatasi stres dan kecemasan yang terkait dengan penyakit.

D. Aspek Psikososial dan Spiritual dalam Perawatan Paliatif

Dalam konteks perawatan paliatif, aspek psikososial dan spiritual memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung pasien dan keluarga mereka. Perawatan paliatif tidak hanya berfokus pada pengobatan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan emosional dan spiritual pasien. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana dukungan psikologis dapat diberikan kepada pasien dan

keluarga mereka, serta bagaimana aspek spiritual dapat diintegrasikan dalam proses perawatan.

1. Dukungan Psikologis bagi Pasien dan Keluarga

Mengelola kecemasan, depresi, dan kesedihan adalah tantangan yang sering dihadapi oleh pasien yang menderita penyakit terminal dan keluarga mereka (Fine, 2001). Kecemasan dapat muncul akibat ketidakpastian mengenai masa depan dan proses penyakit yang dialami. Dalam situasi ini, peran tenaga kesehatan sangat krusial. Mereka perlu memberikan dukungan emosional yang dapat membantu pasien dan keluarga merasa lebih tenang dan terdukung. Salah satu cara untuk mengelola kecemasan adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi kesehatan pasien (Stubbe, 2017). Dengan memahami apa yang terjadi, pasien dan keluarga dapat merasa lebih siap menghadapi situasi yang sulit.

Selain itu, dukungan psikologis juga dapat mencakup konseling individu atau kelompok. Dalam sesi konseling, pasien dan keluarga dapat berbagi perasaan mereka, mengungkapkan ketakutan dan harapan, serta mendapatkan perspektif baru tentang situasi yang mereka hadapi. Hal ini dapat membantu mereka merasa tidak sendirian dalam perjalanan ini dan memberikan ruang untuk proses berduka yang sehat.

2. Aspek Spiritual dalam Keperawatan Paliatif

Spiritualitas sering kali menjadi sumber kekuatan bagi pasien yang menghadapi penyakit terminal. Dalam konteks ini, peran spiritualitas dalam menghadapi penyakit sangatlah signifikan. Banyak pasien dengan penyakit terminal menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka melalui keyakinan spiritual atau agama (Puchalski & O'Donnell, 2005). Oleh karena itu, perawat perlu peka terhadap kebutuhan spiritual pasien dan siap untuk mendukung mereka dalam menemukan makna dalam situasi sulit ini.

Perawat dapat membantu pasien dengan cara mendengarkan cerita hidup mereka, memahami nilai-nilai dan keyakinan yang mereka pegang, serta memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan spiritual mereka. Ini bisa meliputi pengaturan waktu untuk berdoa, menghubungkan pasien dengan pemuka agama, atau hanya sekadar memberikan ruang bagi pasien untuk merenung. Dengan cara ini, perawat tidak hanya merawat tubuh pasien, tetapi juga jiwa mereka, yang sangat penting dalam perawatan paliatif.

3. Pendekatan Empati dan Komunikasi Berbelas Kasih

Teknik komunikasi yang efektif sangat penting dalam menghadapi pasien yang mengalami penderitaan emosional. Pendekatan empati dan komunikasi berbelas kasih dapat membantu menciptakan hubungan yang kuat antara

perawat dan pasien. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, pasien sering kali merasa rentan dan membutuhkan dukungan yang tulus dari tenaga kesehatan.

Perawat harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan empati, dan merespons dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka memahami perasaan pasien. Komunikasi yang baik juga melibatkan kemampuan untuk berbicara dengan jujur tentang kondisi kesehatan pasien, sambil tetap mempertahankan rasa hormat dan kepekaan terhadap perasaan mereka. Dengan membangun komunikasi yang terbuka, pasien akan merasa lebih nyaman untuk berbagi kekhawatiran dan harapan mereka, yang pada gilirannya dapat membantu proses penyembuhan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, aspek psikososial dan spiritual dalam perawatan paliatif sangatlah penting. Dukungan psikologis yang tepat dapat membantu pasien dan keluarga mengatasi tantangan emosional yang mereka hadapi, sementara perhatian terhadap aspek spiritual dapat memberikan makna dan tujuan dalam perjalanan mereka. Melalui pendekatan empati dan komunikasi yang berbelas kasih, perawat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pasien, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup mereka di masa-masa sulit.

E. Etika dan Isu Hukum dalam Keperawatan Paliatif

1. Hak Pasien Dalam Perawatan Paliatif

Mencakup hak untuk memilih perawatan yang mereka inginkan, termasuk keputusan akhir hayat. Hak ini sangat penting karena memberikan pasien kontrol atas proses perawatan mereka, terutama ketika mereka menghadapi kondisi terminal. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran yang krusial dalam mendukung pasien dan keluarga mereka untuk memahami pilihan yang tersedia dan membantu mereka dalam membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan mereka.

2. Keputusan Akhir Hayat Dan Peran Perawat Dalam Proses

Advance care planning (ACP) adalah suatu pendekatan yang memungkinkan pasien untuk merencanakan perawatan mereka di masa depan, termasuk keputusan tentang intervensi medis yang diinginkan atau tidak diinginkan. Perawat berperan sebagai fasilitator dalam proses ini, membantu pasien untuk mengeksplorasi pilihan mereka dan mendiskusikan keinginan mereka dengan keluarga dan tim medis. Dalam situasi yang seringkali emosional dan sulit ini, perawat harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan empati untuk mendukung pasien dan keluarga mereka dalam membuat keputusan yang tepat.

3. Isu-Isu Etika Yang Muncul Dalam Perawatan Paliatif

Dilema etis sering kali muncul ketika perawat harus menyeimbangkan antara menghormati otonomi pasien dan memberikan perawatan yang terbaik untuk mereka. Misalnya, jika seorang pasien memilih untuk menolak perawatan yang dapat memperpanjang hidup mereka, perawat harus menghormati keputusan tersebut sambil juga mempertimbangkan potensi dampak dari keputusan itu terhadap kualitas hidup pasien. Dalam situasi seperti ini, perawat perlu menggunakan penilaian etis yang baik dan bekerja sama dengan tim medis untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk pasien.

Pentingnya pemahaman yang mendalam tentang etika dan isu hukum dalam keperawatan paliatif karena perawat tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan perawatan fisik, tetapi juga untuk mendukung pasien secara emosional dan spiritual dalam menghadapi akhir hayat. Dengan memahami hak pasien, peran mereka dalam keputusan akhir hayat, dan isu-isu etika yang kompleks, perawat dapat memberikan perawatan yang lebih holistik dan berfokus pada pasien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan, tetapi juga membantu pasien dan keluarga mereka merasa lebih diberdayakan dan dihargai dalam proses perawatan.

F. Latihan Soal

1. Diskusikan tantangan yang dihadapi dalam implementasi keperawatan paliatif.
2. Berikan contoh situasi di mana perawat harus menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif dengan pasien dan keluarga.

G. Rangkuman Materi

1. Ringkasan Poin-Poin Penting

Rangkuman singkat dari seluruh bab. Dalam bagian ini, akan dijelaskan poin-poin utama yang telah dibahas sebelumnya, memberikan gambaran menyeluruh tentang keperawatan paliatif dan pentingnya implementasinya dalam praktik.

2. Tantangan dan Peluang dalam Keperawatan Paliatif

Tantangan dalam implementasi keperawatan paliatif. Di sini, dibahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam menerapkan keperawatan paliatif, termasuk kurangnya sumber daya, pelatihan, dan dukungan sistem.

Peluang untuk pengembangan praktik keperawatan paliatif. Selain tantangan, terdapat juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

praktik keperawatan paliatif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan kolaborasi antar profesional kesehatan.

3. Rekomendasi untuk Praktik Keperawatan yang Lebih Baik

Langkah-langkah yang bisa dilakukan perawat untuk meningkatkan pelayanan paliatif. Dalam sub bab ini, diuraikan rekomendasi konkret yang dapat diambil oleh perawat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan paliatif, termasuk pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kebijakan yang mendukung.

Keperawatan paliatif berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien yang menghadapi penyakit serius. Ini melibatkan pengelolaan gejala, dukungan emosional, dan perhatian terhadap aspek spiritual. Perawat memiliki peran penting dalam mendukung pasien dan keluarga, serta dalam mengatasi tantangan etis yang mungkin muncul. Pendekatan holistik dan kolaborasi multidisiplin sangat penting untuk memberikan perawatan yang efektif dan menyeluruh.

Buku ini memberikan panduan yang komprehensif tentang keperawatan paliatif, menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pasien dan keluarga dalam konteks perawatan yang berfokus pada kualitas hidup.

H. Glosarium

Istilah	Definisi
Paliatif	Pendekatan perawatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah terkait penyakit yang mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peredaan penderitaan secara dini dan menyeluruh.
Nyeri	Sensasi tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial, yang dapat bersifat fisik maupun psikologis.
Manajemen Nyeri	Proses pengelolaan nyeri dengan menggunakan berbagai metode, termasuk farmakologis dan non-farmakologis, untuk mengurangi penderitaan pasien.

Simptom	Gejala atau tanda yang dirasakan atau diamati pada pasien sebagai manifestasi dari suatu penyakit atau kondisi.
Kualitas Hidup	Tingkat kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial yang dirasakan oleh individu dalam menjalani kehidupannya.
Perawatan Holistik	Pendekatan perawatan yang mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien secara menyeluruh.
Hospice	Layanan perawatan yang fokus pada pasien dengan penyakit terminal, memberikan kenyamanan dan dukungan hingga akhir hayat.
Psikososial	Aspek yang melibatkan interaksi antara faktor psikologis dan sosial dalam kehidupan seseorang.
Dukungan Keluarga	Bantuan dan peran serta keluarga dalam proses perawatan pasien, baik secara emosional, fisik, maupun sosial.
Perawatan Simptomatik	Perawatan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan gejala penyakit tanpa mengobati penyebab utama.
Etika Paliatif	Prinsip moral dan nilai yang mengatur pelaksanaan perawatan paliatif, termasuk penghormatan terhadap otonomi pasien dan keputusan akhir hidup.
Komunikasi Terapeutik	Teknik komunikasi yang digunakan untuk membangun hubungan yang mendukung dan efektif antara tenaga kesehatan dan pasien.
Konseling	Proses pemberian dukungan psikologis dan informasi kepada pasien dan keluarga untuk membantu menghadapi penyakit dan perawatan.
Perawatan Akhir Hayat	Perawatan yang diberikan pada tahap akhir penyakit untuk memastikan kenyamanan dan martabat pasien.
Farmakoterapi Paliatif	Penggunaan obat-obatan untuk mengelola gejala dan meningkatkan kenyamanan pasien dalam perawatan paliatif.

I. Daftar Pustaka

- Adrienne Santos-Longhurst. (2023, May 4). Is a Deep Tissue Massage What Your Muscles Need? Healthline.
- Babaii, A., Mohammadi, E., & Sadooghiasl, A. (2021). The Meaning of the Empathetic Nurse–Patient Communication: A Qualitative Study. *Journal of Patient Experience*, 8. <https://doi.org/10.1177/23743735211056432>
- Bridge, D. T. (2008). Curing Diseases and Healing Suffering: Inspiration from Developments in Palliative Medicine. *International Journal of Gerontology*, 2(2), 29–32. [https://doi.org/10.1016/S1873-9598\(08\)70007-3](https://doi.org/10.1016/S1873-9598(08)70007-3)
- Corr, C. A. (2021). Elisabeth Kübler-Ross and the “Five Stages” Model in a Sampling of Recent Textbooks Published in 10 Countries Outside the United States. *OMEGA - Journal of Death and Dying*, 83(1), 33–63. <https://doi.org/10.1177/0030222819840476>
- Fine, R. L. (2001). Depression, Anxiety, and Delirium in the Terminally Ill Patient. *Baylor University Medical Center Proceedings*, 14(2), 130–133. <https://doi.org/10.1080/08998280.2001.11927747>
- García-Baquero Merino, M. T. (2018). Palliative Care: Taking the Long View. *Frontiers in Pharmacology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fphar.2018.01140>
- Ju, W., Ren, L., Chen, J., & Du, Y. (2019). Efficacy of relaxation therapy as an effective nursing intervention for post operative pain relief in patients undergoing abdominal surgery: A systematic review and meta analysis. *Experimental and Therapeutic Medicine*. <https://doi.org/10.3892/etm.2019.7915>
- Kidd, B. L., Photiou, A., & Inglis, J. J. (2004). The role of inflammatory mediators on nociception and pain in arthritis. *Novartis Foundation Symposium*, 260, 122–133; discussion 133–8, 277–279.
- Kiguchi, N., Matsuzaki, S., Saika, F., Kobayashi, D., & Kishioka, S. (2018). Epigenetic Regulation of Peripheral Macrophages in Neuropathic Pain. *Epigenetics of Chronic Pain*, 49–67. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814070-3.00002-8>
- Korylchuk, N., Pelykh, V., Nemyrovych, Y., Didyk, N., & Martsyniak, S. (2024). Challenges and Benefits of a Multidisciplinary Approach to Treatment in Clinical Medicine. *Journal of Pioneering Medical Science*, 13(3), 1–9. <https://doi.org/10.61091/jpms202413301>
- Low, N. J. H., Leow, D. G. W., & Klainin-Yobas, P. (2024). Effectiveness of Technology-Based Psychosocial Interventions on Psychological Outcomes Among Adult Cancer Patients and Caregivers: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Seminars in Oncology Nursing*, 40(1), 151533. <https://doi.org/10.1016/J.SONCN.2023.151533>
- Madsen, R., Larsen, P., Fiala Carlsen, A. M., & Marcussen, J. (2023). Nursing care and nurses’ understandings of grief and bereavement among patients and families

during cancer illness and death – A scoping review. *European Journal of Oncology Nursing*, 62, 102260. <https://doi.org/10.1016/J.EJON.2022.102260>

Puchalski, C. M., & O'Donnell, E. (2005). Religious and spiritual beliefs in end of life care: how major religions view death and dying. *Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management*, 9(3), 114–121.

Stubbe, D. E. (2017). Alleviating anxiety: optimizing communication with the anxious patient. *Focus*, 15(2), 182–184.

WHO. (2023). Palliative care. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care#:~:Text=Palliative%20care%20improves%20the%20quality,Of%20caregivers%20improves%20as%20well.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care#:~:text=Palliative%20care%20improves%20the%20quality,of%20caregivers%20improves%20as%20well.>

BAB 2

KONSEP PERAWATAN PALIATIF

Pendahuluan

Perawatan paliatif adalah seluruh aktivitas yang terdiri dari serangkaian penanganan secara fisik, emosional, serta spiritual untuk mendukung kehidupan pasien. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien termasuk juga kontrol terhadap gejala yang sesuai, pendekatan secara personal serta melihat pada pengalaman di masa lalu serta kepedulian serta dukung keluarga dan juga orang terdekatnya. Perawatan paliatif merupakan tugas keluarga bukan semata-mata tugas petugas medis belaka. Asuhan diberikan oleh keluarga kepada pasien semenjak awal terdiagnosa penyakitnya hingga akhir hayatnya (Shatri et al., 2020).

Perawatan paliatif umumnya diterapkan pada kasus-kasus kronik dan terminal, Salah satu contohnya adalah kasus kanker. Menurut World Health Organization (WHO), di tahun 2018 tercatat sebanyak 18,1 juta kasus baru. Sedangkan berdasarkan data American Cancer Society pada tahun 2019 terdapat 17,6 juta kasus baru di Amerika (Sharfina & Indriawati, 2021).

WHO menyatakan bahwa terdapat 40-60 juta orang yang memerlukan perawatan paliatif di dunia pada tahun 2018. Berdasarkan data WHO (2019) ada 40 milyar orang didunia membutuhkan perawatan paliatif, diantaranya adalah mereka yang menderita penyakit kronis seperti penyakit kardiovaskular (38.5%), kanker (34%), penyakit paru kronis (10.3%), AIDS (5.7%), diabetes (4.6%), gagal ginjal, penyakit hati kronis, multiple sclerosis, Parkinson dan penyakit neurologis, reumatoid radang sendi, demensia, kelainan bawaan, dan TBC yang resistan terhadap obat. Hal ini juga sejalan dengan data dari Riskesdas bahwa pada tahun 2018 terdapat beberapa penyakit yang memerlukan perawatan paliatif antara lain stroke yaitu sebanyak 10,9 %, kanker sebanyak 1,8%, diabetes sebanyak 1,8 % dan jantung sebesar 1,5 %. Berdasarkan hal ini maka perawatan paliatif semakin dibutuhkan. Riskesdas, 2018 dalam Desianti et.al., 2020)

Tujuan Intruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Konsep dasar perawatan paliatif

Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi perawatan paliatif
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan perawatan paliatif
3. Mahasiswa mampu menjelaskan lingkup perawatan paliatif
4. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pendampingan pasien terminal
5. Mahasiswa mampu menjelaskan model / tempat perawatan paliatif
6. Mahasiswa mampu menjelaskan peran perawat paliatif

Capaian Pembelajaran

Kognitif:

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait dengan keperawatan paliatif
2. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dan penerapan prinsip-prinsip keperawatan dalam skenario klinis.

Psikomotor:

Mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan yang spesifik dan tepat.

Afektif:

1. Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga, serta dalam tim perawatan Kesehatan
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim Kesehatan lainnya.

A. Pengertian Paliatif Care

Perawatan paliatif berasal dari kata palliate (bahasa Inggris) berarti meringankan, dan "Palliare" (bahasa Latin yang berarti "menyelubungi"-penj), merupakan jenis pelayanan kesehatan yang berfokus untuk meringankan gejala klien, bukan berarti kesembuhan (Lestari, Kep, Antoni, Kep, & Haslinah, 2022). *Palliative care* berarti upaya untuk mengoptimalkan perawatan pasien dan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengantisipasi, mencegah, dan mengobati penderitaan dengan melibatkan aspek fisik, sosial, emosional, dan spiritual pasien serta memfasilitasi otonomi pasien (Shanmugasundaram & Farrell, 2015).

Asuhan keperawatan yang diterapkan pada pasien yang mengalami penyakit terminal adalah "**PALLIATIVE CARE**" yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan perawatan yang baik hingga akhir menuju kematian (Ferrell & Coyle, 2006). Penyakit terminal merupakan penyakit progresif yaitu penyakit yang menuju ke arah kematian, seperti penyakit jantung dan kanker. Pasien dengan penyakit terminal biasanya menginginkan perawatan kesehatan di tempat mereka tinggal yaitu di rumah bukan di rumah sakit (Dhiliwal & Muckaden, 2015). Perlunya kolaborasi multidisiplin ilmu untuk dapat mengimplementasikan dan mengembangkan rencana perawatan yang komprehensif guna meningkatkan kualitas hidup pasien (Maulida, Oktadini, & Purnamasari, 2017). Selain itu, aspek psiko-onkologi sangat penting selama perawatan paliatif (Fitria, 2010).

World Health Organization (WHO) tahun 2002 menjelaskan konsep perawatan paliatif adalah suatu perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam nyawa, perawatan yang diberikan dengan meminimalkan rasa sakit, memfasilitasi rasa nyaman, memberikan dukungan spiritual dan psikososial dari diagnosis sampai akhir kehidupan. Perawatan paliatif berpusat pada pasien dan keluarga yang bersifat komprehensif, holistik, perawatan sedini mungkin, dan kualitas hidup yang baik. Pada tahun 2014, WHO menyerukan perawatan paliatif dapat diintegrasikan sebagai elemen penting dari kontinum perawatan kesehatan (*Continuum of Care*) (Meier et al., 2017).

Kunci perawatan paliatif menurut WHO:

1. Meminimalkan nyeri dan permasalahan lain yang mengakibatkan penderitaan.
2. Menyikapi siklus hidup dan kematian adalah proses yang normal.
3. Tidak mempercepat atau memperlambat kematian.

4. Pendekatan perawatan yang holistik, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pasien.
5. Mendukung kemandirian pasien untuk tetap aktif sampai datangnya kematian.
6. Memberikan dukungan kepada keluarga selama masa sakit dan berduka.
7. Memfasilitasi support system yang lain guna memecahkan masalah pasien dan keluarga.

Berikut ini penjelasan mengenai konsep dasar perawatan paliatif di Indonesia (Lestari et al., 2022):

1. Mengurangi nyeri dan permasalahan fisik yang lain.
2. Memaknai kehidupan dan kematian sebagai suatu proses yang normal.
3. Tidak mempercepat dan memperlambat kematian
4. Perawatan terintegrasi pada semua aspek baik fisik, sosial, psikologis, dan spiritual.
5. Memberikan dukungan dan memfasilitasi aktivitas pasien sebaik mungkin.
6. Memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa berduka.
7. Perawatan dengan interdisiplin ilmu dan tim untuk memenuhi kebutuhan pasien.
8. Mencegah aktivitas yang sia-sia.
9. Sangat subjektif dan personal tergantung kebutuhan masing-masing pasien.

B. Tujuan Perawatan paliatif

Tujuan perawatan paliatif adalah memperbaiki kualitas hidup, mengurangi penderitaan pasien, keluarga, dan pengasuhnya (*care giver*). Harapan yang ingin dicapai dalam melakukan perawatan paliatif adalah kehidupan yang baik (*good life*), kematian yang baik (*good death*), dan berduka yang baik (*good grief*). Penelitian membuktikan ada hubungan antara pemberian perawatan paliatif dengan kualitas hidup pasien kanker (Rabow, 2014). Hal ini membuktikan bahwa perawatan paliatif pada pasien dengan penyakit terminal sangat diperlukan. Hal-hal positif yang dapat dilakukan pada pasien dengan penyakit terminal dengan melibatkan sistem keluarga dan orang yang dianggap berarti dalam hidupnya dapat dirancang sesuai dengan teori keperawatan *peaceful end of life* Ruland & Moore (Alligood, 2014), yaitu:

1. Terbebas dari rasa nyeri

Bebas dari rasa sakit merupakan bagian penting dari pengalaman *end of life* karena nyeri merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan dan mayoritas dirasakan pada pasien dengan penyakit terminal.

2. Memperoleh kenyamanan

Memfasilitasi pasien dan keluarga dalam keadaan menyenangkan dan terbebas dari ketidaknyamanan sesuai dengan teori Kolkaba.

3. Bermartabat dan merasa terhormat
Konsep ini mengintegrasikan prinsip etika dan otonomi pasien bahwa setiap pasien yang mengalami sakit parah juga berhak untuk dihormati dan dihargai.
4. Memiliki perasaan damai
Stress yang dialami pasien dan keluarga akan penyakit yang mengancam nyawa mengakibatkan kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan. Peran professional tenaga kesehatan dapat mengintegrasikan semua aspek baik fisik, sosial, psikologis, dan spiritual untuk menciptakan perasaan damai.
5. Kedekatan dengan orang yang disayang
Support system dari orang-orang terdekat sangat penting untuk memberikan dukungan emosional.

C. Lingkup Perawatan paliatif meliputi:

1. Menyediakan bantuan dari rasa sakit dan gejala menyedihkan lainnya
2. Menegaskan hidup dan mempercepat atau menunda kematian.
3. Mengintegrasikan aspek-aspek psikologis dan spiritual perawatan pasien
4. Tidak mempercepat atau memperlambat kematian
5. Meredakan nyeri dan gejala fisik lain yang mengganggu
6. Menawarkan sistem pendukung untuk membantu keluarga menghadapi penyakit pasien dan kehilangan mereka.

D. Konsep Pendampingan Pasien Terminal

Ada empat langkah untuk melakukan pendampingan pada pasien terminal (Tuamely, 2019), yaitu:

1. Perhatikan orangnya bukan penyakitnya
Pendekatan yang dilakukan oleh *support system* sebagai pendamping dapat dilakukan dengan membantu mempertahankan martabat pasien yaitu dengan memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan bukan pada penyakitnya.
2. Siap mendengarkan
Umumnya, pasien ingin berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan keluarga, sehingga jangan menyembunyikan kebenaran tentang keadaan pasien karena dapat membantu kesiapan mereka menghadapi kenyataan. Mayoritas orang mungkin merasa khawatir dan tidak tahu apa yang akan dikatakan ketika berdekatan dengan pasien-pasien terminal. Selain ucapan sebagai dukungan untuk menghibur, sentuhan dan duduk bersama pasien juga merupakan sikap yang memperlihatkan kepedulian terhadap keterbukaan pasien.
3. Memahami kebutuhan dasar

Kebutuhan dasar yang harus diidentifikasi adalah harapan dari pasien untuk membuat keputusan pribadi. Pasien sebaiknya diikutsertakan dalam memutuskan perawatan medis yang akan dilakukan. Hal ini sangat penting untuk menghargai martabat pasien. Aspek keterbukaan tentang penyakit dan kematian sangat penting dilakukan. Manfaat yang diperoleh pasien bisa saja ingin menyelesaikan perselisihan di masa lalu, menyatakan penyesalan atau meminta maaf.

4. Menyediakan penghiburan pada saat-saat terakhir

Pendampingan saat-saat terakhir pasien merupakan kondisi yang paling berat. Biarkan pasien menyatakan keinginannya yang terakhir dan bantulah pasien untuk mengadakan kontak dengan orang-orang terdekat.

E. Model/Tempat Perawatan Paliatif Care

1. Rumah sakit, (Hospice hospital care), Poliklinik, Rawat singkat, Rawat Inap
2. Rumah (Hospice home care)
3. Hospis (Hospice care)
4. Praktek bersama , Tim/ kelompok perawatan paliatif

F. Peran Perawat pada Asuhan Keperawatan Paliatif

Berikut dijabarkan peran perawat dalam perawatan paliatif:

1. Dapat menerapkan pengetahuan dan ketrampilan dalam memberikan asuhan keperawatan, pemberi asuhan keperawatan, penddikan kesehatan, koordinator, advokasi, kolaborator, fasilitator, modifikasi lingkungan
2. Menetapkan prioritas asuhan keperawatan, mengelola waktu secara efektif dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas hidup.
3. Sebagai nara sumber / konselor bagi pasien, keluarga dan komunitas dalam menghadapi perubahan kesehatan, ketidakmampuan dan kematian.
4. Sebagai komunikator yang terapeutik dan pendengar yang baik dalam memberikan dukungan dan perhatian.
5. Sebagai Pengelola: manajer kasus, konsultan, koordinasi
6. Sebagai Penddik: Di pendidikan / dipelayanan
7. Sebagai Peneliti

G. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan perawatan paliatif?
 - A. Perawatan yang hanya diberikan kepada pasien kanker
 - B. Perawatan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien dengan penyakit serius
 - C. Pengobatan alternatif tanpa intervensi medis

- D. Hanya mencakup terapi obat-obatan
- E. Fokus pada memperpanjang umur pasien dengan cara apa pun
- 2. Manakah yang merupakan salah satu prinsip utama perawatan paliatif?
 - A. Mempercepat proses kematian pasien
 - B. Menghilangkan semua intervensi medis
 - C. Memberikan perawatan yang berfokus pada kenyamanan dan kualitas hidup pasien
 - D. Menghindari komunikasi dengan keluarga pasien
 - E. Menggunakan hanya metode non-medis dalam perawatan
- 3. Perawatan paliatif mencakup aspek berikut, kecuali:
 - A. Fisik
 - B. Psikologis
 - C. Sosial
 - D. Spiritual
 - E. Eksperimental
- 4. Apa yang harus dilakukan jika pasien paliatif mengalami kecemasan berat?
 - A. Mengabaikannya karena pasien sudah dalam kondisi terminal
 - B. Memberikan dukungan psikososial dan terapi jika diperlukan
 - C. Menghentikan semua komunikasi dengan pasien agar tidak memperburuk kecemasan
 - D. Hanya mengandalkan dukungan keluarga tanpa intervensi medis
 - E. Memberikan obat penenang dalam dosis tinggi tanpa konsultasi lebih lanjut
- 5. Siapa saja yang dapat terlibat dalam tim perawatan paliatif?
 - A. Hanya dokter spesialis onkologi
 - B. Hanya dokter dan perawat
 - C. Dokter, perawat, psikolog, pekerja sosial, dan pemuka agama
 - D. Hanya keluarga pasien yang merawatnya di rumah
 - E. Tim rumah sakit tanpa keterlibatan keluarga

Kunci Jawaban

- 1. B
- 2. C
- 3. E
- 4. B
- 5. C

H. Rangkuman Materi

Perawatan paliatif merupakan satu pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan

dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, fisik, psikososial dan spiritual. Perawatan paliatif mencakup dua unsur besar yaitu pada kasus kronik dan terminal. Pelaksanaan pemberian asuhan paliatif dimulai dengan membentuk tim yang terdiri dari multidisiplin ilmu.

I. Glosarium

<i>AIDS</i>	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
<i>Hospice</i>	: Perawatan pada pasien terminal (stadium akhir)
<i>Self-care</i>	: Perawatan diri sendiri
<i>WHO</i>	: <i>World Health Organization</i>

J. Daftar Pustaka

- Alligood, M. (2014). *Nursing theorists and their works*. 8th. *St Louis Missouri: Mosby Elsevier*.
- Desianti, I., Dewi, I. P., & Aisyah, P. S. (2020). Pengaruh psikoedukasi terhadap beban family caregiver dalam merawat anggota keluarga dengan perawatan paliatif. *Prosiding UMY Grace*, 1(1), 392-400.
- Dhiliwal, S. R., & Muckaden, M. (2015). Impact of specialist home-based palliative care services in a tertiary oncology set up: a prospective non-randomized observational study. *Indian Journal of Palliative Care*, 21(1), 28.
- Ferrell, B., & Coyle, N. (2006). *Textbook of palliative nursing*. Oxford University Press, USA.
- Fitria, C. N. (2010). Palliative care pada penderita penyakit terminal. *Gaster*, 7(1), 527–537.
- Lestari, N., Kep, M., Antoni, N. A., Kep, M., & Haslinah, M. K. (2022). *Asuhan Keperawatan Paliatif*. Media Sains Indonesia.
- Maulida, M. N., Oktadini, N. R., & Purnamasari, N. (2017). Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Perawat Mengenai Perawatan Paliatif. In *Proceeding Seminar Nasional Keperawatan* (Vol. 3, pp. 132–136).
- Meier, D. E., Back, A. L., Berman, A., Block, S. D., Corrigan, J. M., & Morrison, R. S. (2017). A national strategy for palliative care. *Health Affairs*, 36(7), 1265–1273.
- Rabow, M. W. (n.d.). Sarah J. Knish (2014). *Quality of Life and Palliative*. *Tekx Book*.
- Shanmugasundaram, S., & Farrell, M. (2015). Challenges in conducting qualitative palliative care research. *Singapore Nursing Journal*, 42(1), 3–7.
- Shatri, H., Faisal, E., Putranto, R., & Sampurna, B. (2020). Advanced directives pada

perawatan paliatif. *Jurnal penyakit dalam indonesia*, 7(2), 125-132.

Sharfina, N. A., & Indriawati, R. (2021). *Hubungan Usia dan Jenis Kelamin dengan Kejadian Kanker di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal of Innovation and Knowledge*, 1(2), 159–166.

Tuamely, J. (2019). Pendampingan Kepada Pasien Terminal. *Tangkoleh Putai*, 16(1), 45–58.

World Health Organization. (2018). WHO Definition of Palliative Care. Retrieved from <https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>.

BAB 3

PRINSIP KOMUNIKASI DALAM PERAWATAN PALIATIF

Pendahuluan

Dalam dunia pelayanan kesehatan, kemampuan berkomunikasi secara efektif merupakan keterampilan yang sangat penting, terutama dalam konteks perawatan paliatif. Bagi mahasiswa Sarjana Keperawatan, memahami dan menguasai prinsip komunikasi dalam bidang khusus ini dapat memberikan dampak besar terhadap pengalaman pasien dan keluarganya. Perawatan paliatif tidak hanya berfokus pada pengelolaan gejala fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan emosional, sosial, dan spiritual bagi pasien yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa (WHO, 2020). Sebagai calon perawat, mahasiswa harus belajar untuk menghadapi percakapan yang dimungkinkan penuh dengan ketidakpastian, harapan, dan terkadang keputusan. Hal tersebut sesuai dengan situasi di area perawatan paliatif, dimana pasien mengalami berbagai penyakit yang mengancam jiwa seperti kanker, gagal ginjal, atau demensia. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan peran komunikasi yang kompleks dalam perawatan paliatif, sehingga dapat mempersiapkan mahasiswa keperawatan agar dapat memberikan pelayanan yang penuh empati dan holistik.

Penjelasan akan dimulai dengan mengeksplorasi elemen dasar komunikasi dalam perawatan paliatif, menyoroti pendekatan yang berfokus pada penyakit menuju pendekatan yang mengutamakan pasien. Dengan membangun hubungan yang terapeutik, perawat dapat menciptakan kepercayaan dan memberikan kenyamanan, sehingga pasien dan keluarganya akan merasa lebih bebas untuk mengungkapkan perasaan serta harapan mereka. Pemahaman terhadap isyarat verbal maupun non-verbal menjadi sangat penting dalam proses interaksi, karena sering kali pengungkapan perasaan atau emosi yang tidak terucapkan, dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan perawatan. Pengetahuan dasar ini menjadi landasan bagi strategi komunikasi yang lebih mendalam.

Seiring dengan kemajuan pembelajaran, mahasiswa akan belajar tentang percakapan yang menantang mengenai prognosis, pilihan pengobatan, perawatan, sampai dengan preferensi akhir hayat. Buku ini menyajikan pendekatan yang terstruktur, seperti protokol SPIKES, untuk membantu calon perawat menangani

diskusi yang sensitif ini dengan percaya diri dan penuh empati. Selain itu, buku ini juga membahas kompleksitas komunikasi dengan keluarga dan pengasuh (*caregiver*), yang mungkin memiliki ketakutan, konflik, atau kesalahpahaman mereka sendiri. Dengan mendorong dialog yang terbuka serta memberikan penjelasan yang jelas dan penuh empati, perawat dapat mendukung keluarga dalam perjalanan emosional mereka, termasuk menghadapi kesedihan yang akan datang dan setelahnya.

Selain komunikasi interpersonal, buku ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antarprofesional dalam tim perawatan paliatif. Komunikasi yang efektif di antara tenaga kesehatan sangat penting untuk menyusun rencana perawatan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pasien yang beragam. Kami juga akan membahas dimensi etika dan budaya dalam komunikasi perawatan paliatif, dengan menyadari bahwa pengalaman setiap pasien dipengaruhi oleh latar belakang dan keyakinan mereka yang unik. Terakhir, kami mengakui beban emosional yang dapat ditimbulkan oleh perawatan paliatif terhadap tenaga kesehatan itu sendiri, sehingga kami menawarkan strategi untuk perawatan diri dan ketahanan emosional agar perawat dapat menjaga kesejahteraan mereka sendiri sambil tetap memberikan pelayanan berkualitas tinggi.

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan konsep dasar komunikasi di perawatan paliatif
- Memaparkan prinsip-prinsip komunikasi dengan pasien dan keluarganya
- Menjelaskan berbagai teknik untuk *breaking bad news*
- Menyampaikan pertimbangan etik dan budaya dalam komunikasi
- Menjelaskan komunikasi interdisipliner dan kolaborasi tim

Tabel 3.1: Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK	
CPL	Mampu melaksanakan edukasi dengan ketrampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah (aspek pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus)
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
CPMK	Bila diberikan pengalaman belajar di kelas, mahasiswa mampu berkomunikasi dengan pasien dan keluarga yang mendapat perawatan paliatif
Sub-CPMK	
Sub-CPMK1	Mempraktikkan kemampuan berkomunikasi dengan pasien dan keluarga yang mendapatkan perawatan paliatif

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa Sarjana Keperawatan dalam memahami prinsip-prinsip komunikasi yang penting dalam perawatan paliatif. Bagian ini mencakup berbagai sub-topik, termasuk membangun hubungan terapeutik dengan pasien dan keluarganya, menyampaikan kabar buruk, mendiskusikan prognosis, rencana perawatan, serta mendukung keluarga dalam pengambilan keputusan di akhir kehidupan. Dengan penekanan kuat pada perawatan yang berpusat pada pasien, bagian ini menyajikan strategi praktis, seperti protokol SPIKES, untuk menangani percakapan sensitif dengan penuh empati dan percaya diri. Selain itu, bagian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antarprofesional kesehatan, pertimbangan etika, serta kompetensi budaya dalam komunikasi perawatan paliatif. Bab ini akan membekali mahasiswa keperawatan dengan keterampilan yang diperlukan untuk berkomunikasi secara efektif, penuh kasih sayang dan empati dalam konteks perawatan paliatif.

A. Konsep Dasar Komunikasi di Perawatan Paliatif

Dua puluh persen dari komunikasi, yang merupakan keterampilan yang dipelajari untuk membangun hubungan antara perawat dan pasien, bersifat verbal, sementara delapan puluh persen bersifat non-verbal (Dahlin & Wittenberg, 2015). Untuk mendukung pendekatan yang berpusat pada pasien dan keluarga, komunikasi yang merupakan seni dalam keperawatan mencakup keterampilan mendengarkan, ketenangan, kehadiran, dan penggunaan diri secara terapeutik. Sesuai dengan kebutuhan khusus dari pasien dan keluarganya, komunikasi keperawatan melibatkan pengumpulan dan penyampaian informasi, serta pemberian dukungan, kenyamanan, dan ketenangan. Dalam menghadapi topik sulit seperti perencanaan perawatan lanjutan, penyampaian kabar buruk, prognosis yang buruk, atau transisi ke perawatan rumah sakit dan paliatif, perawat memainkan peran langsung. Untuk itu, mahasiswa keperawatan sangat perlu untuk mempelajari konsep dasar dari komunikasi, khususnya di area perawatan paliatif.

Dalam perawatan paliatif, komunikasi yang efektif adalah teknik terapeutik yang kuat, yang jika diterapkan dengan benar, dapat memberdayakan pasien, membantu mereka membuat keputusan yang bijak, dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan perawatan (Schofield et al., 2008). Berdasarkan hasil penelitian, individu dengan penyakit yang mengancam jiwa sering mengalami ketidaknyamanan tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional, sehingga membutuhkan dukungan dan edukasi untuk meningkatkan penyesuaian psikososial mereka, serta pengelolaan masalah fisik yang mereka hadapi (Ang, 2019;

Kvåle, 2007). Setidaknya satu dari tiga pasien dewasa dengan kanker stadium lanjut mengalami kecemasan atau depresi (Chong & Poon, 2011). Dengan menyampaikan informasi yang terbuka, jujur, dan akurat, serta menggali kekhawatiran pasien, komunikasi yang efektif dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan yang sangat dibutuhkan (Lloyd-Williams, 2008). Keterampilan komunikasi perawat dapat membantu individu-individu ini untuk menyelesaikan masalah mereka dan mengintegrasikan pengalaman sakit ke dalam kehidupan sehari-hari. Informasi atau edukasi yang tepat dapat membantu pasien dan keluarganya dalam menjawab atau merespon kekhawatiran atau perasaan negatif lainnya yang dirasakan.

B. Prinsip-prinsip Komunikasi dengan Pasien dan Keluarganya

Meskipun komunikasi antara perawat, pasien, dan keluarga sering terjadi dengan penuh kompleksitas dan intensitas yang tinggi, perawat paliatif sering kali menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi, terutama yang menyangkut komunikasi akhir kehidupan. Salah satu model pelatihan komunikasi yang sering dipakai di area perawatan paliatif adalah COMFORT (Fuoto & Turner, 2019; Ragan, 2015).

Tabel 3.2: Model Pelatihan Komunikasi COMFORT

<i>Communication</i> (komunikasi)	Mengenali komunikasi tugas dan komunikasi relasional.
<i>Orientation and opportunity</i> (orientasi & kesempatan)	Menilai pemahaman, literasi kesehatan, dan preferensi budaya.
<i>Mindfulness</i> (relaksasi)	Kesadaran akan emosi, tetap fokus pada masa kini, dan beradaptasi terhadap perubahan.
<i>Family</i> (keluarga)	Mendukung keterlibatan dan pemahaman pengasuh.
<i>Openings</i> (membuka kesempatan diskusi)	Mengidentifikasi peluang untuk diskusi, mengakui "hal yang sulit dibicarakan."
<i>Relating and radically adaptive messaging</i> (penyampaian pesan yang adaptif)	Membangun kepercayaan, mungkin perlu mengulang informasi dan meninjau kembali tujuan.
<i>Team</i> (grup)	Kolaborasi dan komunikasi tim interdisipliner.

COMFORT adalah model holistik yang berpusat pada pasien yang mengakui keluwesan komunikasi, yang mungkin berbeda dengan pendekatan bertahap dari program keterampilan komunikasi lainnya. Model ini mencakup modul didaktik dan

interaktif untuk memungkinkan peserta belajar (mahasiswa keperawatan) mempraktikkan apa yang diajarkan dalam kuliah (Fuoto & Turner, 2019). Model pelatihan COMFORT mencakup komunikasi, orientasi dan kesempatan, kesadaran, keluarga, pembukaan, berhubungan dan penyampaian pesan yang secara radikal adaptif, serta tim.

Setelah itu, mahasiswa keperawatan perlu mengenal prinsip-prinsip komunikasi dalam perawatan paliatif, khususnya sebagai bekal dalam menghadapi pasien dan keluarganya yang mungkin menghadapi berbagai beban fisik, mental, sosial, finansial, dan lain sebagainya. Hal paling utama yang harus dilakukan oleh seorang perawat adalah membimbing pasien dalam mengidentifikasi perasaannya (Kustanti & Nobe, 2024). Selanjutnya, hubungan antara perawat dengan pasien dan keluarganya dapat dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut (Perrin, 2009):

1. Tahap 1: Fase pengenalan

Tugas perawat:

- a. Mengeksplorasi pemahaman pasien/keluarga tentang penyakit
- b. Menentukan kepribadian, gaya mengatasi masalah, dan gaya belajar
- c. Menggali keberadaan perencanaan perawatan lanjutan

Tugas pasien:

Membangun kepercayaan dan pemahaman dengan perawat.

2. Tahap 2: Fase kerja

Tugas perawat:

- a. Memantau respon pasien terhadap penyakit
- b. Memberikan perawatan klinis
- c. Memberikan pengobatan
- d. Menyediakan pendidikan tentang penyakit/pengobatan

Tugas pasien:

- a. Menyusun rencana perawatan bekerja sama dengan tim
- b. Berpartisipasi dalam perawatan
- c. Memberikan informasi tentang respon terhadap terapi

3. Tahap 3: Fase terminasi

Tugas perawat:

- a. Mengucapkan selamat tinggal
- b. Memberitahu pasien apa arti mereka bagi orang tersebut atau apa yang telah mereka ajarkan
- c. Membantu proses transisi

Tugas pasien:

- a. Mengucapkan selamat tinggal
- b. Menunjukkan penghargaan kepada perawat dan staf lainnya

c. Membantu dengan transisi

Dalam rangka memenuhi unsur pertama dari COMFORT model, perawat juga perlu memahami komunikasi tugas, yang dapat merujuk pada *Nurse Communication Tasks Delineated by the National Consensus Project for Quality Palliative Care Clinical Practice Guidelines (Care, 2013)*.

Komunikasi Tugas Perawat di Area Paliatif (Care, 2013):

1. Domain 1: Struktur dan proses

Penekanan pada keterlibatan tim interdisipliner, kolaborasi dengan pasien dan keluarga, serta penilaian yang terkoordinasi dan kelanjutan perawatan di berbagai pengaturan layanan kesehatan.

Tugas perawat:

- a. Berpartisipasi dalam penilaian pasien untuk menentukan kebutuhan dan preferensi yang berkembang dari pasien dan keluarga, dengan pengakuan terhadap prioritas yang kompleks, bersaing, dan berubah dalam tujuan perawatan
- b. Bekerja sama untuk berkontribusi pada rencana perawatan yang berkembang
- c. Berpartisipasi dalam diskusi tim dan meninjau rencana perawatan
- d. Mencari pengembangan keterampilan dalam komunikasi.

2. Domain 2: Aspek fisik

Penilaian kolaboratif dan perawatan gejala fisik, pilihan pengobatan untuk kondisi umum, dalam konteks penghormatan terhadap tujuan perawatan pasien dan keluarga.

Tugas perawat:

- a. Menggunakan instrumen (panduan) penilaian gejala untuk evaluasi yang konsisten
- b. Mengidentifikasi dan menggunakan alat untuk orang dewasa dengan gangguan kognitif serta neonatus, anak-anak, atau remaja ketika diperlukan.

3. Domain 3: Aspek psikologis

Proses penilaian kolaboratif terhadap masalah psikologis dan diagnosis psikiatri, opsi pengobatan untuk kondisi umum, dalam konteks penghormatan terhadap tujuan perawatan pasien dan keluarga.

Tugas perawat:

Menggunakan cara verbal, non-verbal, dan/atau simbolik yang sesuai dengan pasien, dengan perhatian khusus pada pasien dengan gangguan kognitif serta tahap perkembangan dan kapasitas kognitif neonatus, anak-anak, dan remaja.

4. Domain 4: Aspek sosial

Keterlibatan interdisipliner dan kolaborasi dengan pasien dan keluarga untuk mengidentifikasi dan mendukung kekuatan pasien dan keluarga.

Tugas perawat:

Berkomunikasi dalam lingkaran perawatan pasien, keluarga, dan tim kesehatan.

5. Domain 5: Aspek spiritual, eksistensial, dan agama

Eksplorasi interdisipliner, penilaian, dan perhatian terhadap masalah spiritual pasien dan keluarga.

Tugas perawat:

Berkomunikasi dengan pasien dan keluarga secara hormat dengan memperhatikan keyakinan agama dan spiritual, ritual, dan praktik.

6. Domain 6: Aspek budaya

Penilaian budaya sebagai sumber ketahanan dan kekuatan bagi pasien dan keluarga.

Tugas perawat:

- a. Menggali identifikasi budaya, kekuatan, kekhawatiran, dan kebutuhan pasien serta keluarga dengan sensitif
- b. Berkomunikasi dalam bahasa dan cara yang dapat dipahami oleh pasien dan keluarga.

7. Domain 7: Perawatan pasien di akhir kehidupan

Menyampaikan tSaudara dan gejala proses menjelang kematian kepada pasien, keluarga, dan semua penyedia layanan kesehatan yang terlibat, serta memberikan panduan kepada keluarga mengenai apa yang dapat diharapkan dalam proses kematian dan periode pasca kematian.

Tugas perawat:

- a. Mengidentifikasi dan menyampaikan tSaudara dan gejala pasien di akhir kehidupan
- b. Memenuhi kebutuhan fisik, psikososial, spiritual, sosial, dan budaya pasien dan keluarga.

8. Domain 8: Aspek etika dan legal dalam perawatan

Perawat perlu merencanakan diskusi berkelanjutan tentang tujuan perawatan bersama dengan penyelesaian dan dokumentasi perencanaan perawatan lanjutan. Selain itu, perlunya identifikasi dan penyelesaian masalah etika yang sering dihadapi serta masalah hukum dan regulasi kompleks yang muncul dalam perawatan paliatif.

Tugas perawat:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang pilihan perawatan pasien di seluruh area perawatan
- b. Mengungkapkan situasi kompleks dan menyelesaikan masalah bersama tim interdisipliner.

C. Teknik-teknik Komunikasi *Breaking Bad News*

Berita buruk dalam konteks medis biasanya didefinisikan sebagai “setiap informasi yang secara merugikan dan serius memengaruhi pSaudarangan seseorang tentang masa depannya” (Kumar & Sarkhel, 2023). Berbagai situasi dapat dikategorikan sebagai berita buruk, seperti diagnosis, pengobatan, prognosis, rawat inap, atau kematian, dan masing-masing dapat memengaruhi individu dengan cara yang berbeda-beda (Buckman, 1984). Beberapa contoh umum berita buruk dalam lingkungan medis misalnya ketika seseorang diberitahu bahwa ia dinyatakan positif virus HIV, seorang istri diberitahu bahwa suaminya terdiagnosis demensia Alzheimer, atau seorang pasien diberi tahu bahwa benjolan yang dimilikinya adalah kanker (Kumar & Sarkhel, 2023). Dengan demikian, berita buruk adalah pesan yang memiliki konotasi negatif dan berpotensi mengubah harapan, kesejahteraan mental, serta mengganggu gaya hidup penerimanya.

Dilihat dari pengertiannya, proses penyampaian berita buruk merupakan sesuatu hal yang cukup menantang bagi tenaga kesehatan. Hal tersebut dikarenakan tenaga kesehatan mungkin mempunyai suatu konflik antara harus menyampaikan informasi secara jujur, tetapi hal tersebut kemungkinan akan membuat pasien atau keluarganya mengalami kesedihan atau bentuk reaksi emosional lainnya. Tugas yang sulit ini memerlukan kesabaran dan keterampilan komunikasi yang baik, serta harus dilakukan dengan penuh empati terhadap semua pihak yang terlibat. Selain itu, proses pemberian informasi perlu dilakukan dengan cara yang sensitif dan mendukung, karena informasi yang disampaikan kemungkinan besar akan secara drastis mengubah pSaudarangan pasien tentang masa depannya (Cardoso et al., 2024).

Kepala unit atau konsultan senior yang dikenal oleh pasien dan anggota keluarga adalah pihak yang sebaiknya menyampaikan berita buruk. Dalam keadaan darurat tertentu di mana konsultan yang merawat tidak hadir, maka anggota senior staf perawat mungkin akan dipanggil untuk menyampaikan berita buruk (Kumar & Sarkhel, 2023). Terdapat beberapa cara untuk menyampaikan berita buruk kepada pasien secara efektif dengan menggunakan teknik dan metode komunikasi yang berpusat pada pasien.

Tabel 3.3: Berbagai metode untuk *Breaking Bad News*

SPIKES (Baile et al., 2000)	
<i>Setting up the interview</i>	• Atur privasi • Libatkan orang-orang terdekat sesuai dengan pilihan pasien • Duduk

	• Bangun koneksi dengan pasien: jaga kontak mata dan/atau sentuh pasien (jika ia merasa nyaman) • Kelola keterbatasan waktu dan gangguan.
<i>Assess the patient's perception</i>	• Menentukan apa yang pasien ketahui tentang kondisi medisnya atau apa yang ia curigai terjadi pada dirinya • Dengarkan tingkat pemahaman pasien • Identifikasi apakah pasien menyangkal penyakit.
<i>Obtain the patient's invitation</i>	• Tanyakan kepada pasien apakah ia ingin mengetahui detail kondisi medis dan/atau pengobatannya • Terima hak pasien untuk tidak mengetahui • Menawarkan untuk menjawab pertanyaan nantinya ketika mereka menginginkannya.
<i>Give knowledge and information</i>	• Ingatkan pasien bahwa informasi yang akan diberikan merupakan suatu berita buruk; hal ini dapat mengurangi keterkejutan yang mungkin terjadi setelah terungkapnya berita buruk tersebut • Mulailah pada tingkat pemahaman dan kosakata pasien • Gunakan kata-kata non-teknis • Hindari sikap tumpul yang berlebihan • Berikan informasi dalam potongan kecil, dan cek/validasi pemahaman pasien secara berkala • Hindari penggunaan frasa seperti "Tidak ada lagi yang dapat kami lakukan untuk Saudara"
<i>Address the patient's emotions with empathic responses</i>	• Amati emosi pasien • Identifikasi emosi yang dialami pasien dengan menyebutkannya pada dirinya sendiri • Identifikasi alasan terjadinya emosi tersebut • Beri tahu pasien bahwa Saudara memahami emosinya dan menghubungkannya dengan alasan di balik emosi tersebut dengan membuat pernyataan yang menghubungkan.
<i>Strategy and Summary</i>	• Rangkum informasi yang telah Saudara berikan. • Jika pasien sudah siap, diskusikan rencana perawatannya • Berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan • Periksa pemahaman/kesalahpahaman pasien terhadap diskusi.

ABCDE (Rabow & McPhee, 2000)

<i>Advance preparation</i>	• Tanyakan apa yang sudah diketahui dan dipahami oleh pasien • Bagaimana cara pasien menghadapi situasi ini? • Atur kehadiran orang pendukung dan anggota keluarga yang sesuai • Tentukan waktu dan tempat yang bebas dari gangguan (non-aktifkan HP) • Persiapkan diri secara emosional • Tentukan kata-kata dan frasa yang akan digunakan (tuliskan skrip) • Latih cara menyampaikan berita.
<i>Build a therapeutic environment/relationship</i>	• Atur tempat yang privat dan tenang tanpa gangguan • Sediakan tempat duduk yang cukup untuk semua pihak • Duduk cukup dekat untuk menyentuh jika diperlukan dan sesuai • Beri kepastian mengenai rasa sakit, penderitaan, dan ketakutan akan ditinggalkan
<i>Communicate well</i>	• Bersikap langsung ("Saya minta maaf, saya punya berita buruk") • Jangan menggunakan eufemisme, jargon, atau singkatan. Katakan "kanker" atau "kematian" • Beri waktu untuk keheningan • Gunakan sentuhan dengan bijak dan sensitif
<i>Ask the patient to repeat his or her understanding of the news</i>	• Atur pertemuan tambahan • Gunakan pengulangan dan penjelasan tertulis atau pengingat • Tangani reaksi pasien dan keluarga • Evaluasi reaksi pasien: - Respons fisiologis: lari/bertarung, konservasi/penarikan diri - Strategi koping kognitif: penolakan, menyalahkan, intelektualisasi, ketidakpercayaan, penerimaan - Respons afektif: kemarahan/amarah, ketakutan/teror, kecemasan, ketidakberdayaan, keputusasaan, rasa malu, kelegaan, rasa bersalah, kesedihan, duka anticipasi

	• Dengar dengan aktif, jelajahi perasaan, dan tunjukkan empati
<i>Encourage and validate emotions (reflect back emotions)</i>	• Benahi distorsi • Tawarkan untuk memberitahu orang lain atas nama pasien • Evaluasi efek dari berita tersebut • Jelajahi apa arti berita tersebut bagi pasien • Tangani kebutuhan lebih lanjut, tentukan rencana jangka pendek dan jangka panjang pasien, evaluasi potensi bunuh diri • Lakukan rujukan yang sesuai untuk dukungan lebih lanjut • Sediakan materi tertulis • Atur tindak lanjut • Proses perasaan Saudara sendiri
Kaye's 10 step model (Kaye, 1997)	
<i>Prepare</i>	• Ketahui semua data pasien • Pastikan privasi • Cari tahu siapa yang ingin hadir bersama pasien • Perkenalkan diri Saudara
<i>Determine what the patient knows</i>	• Mulailah dengan pertanyaan terbuka (misalnya, "Bagaimana semua ini dimulai?")
<i>Determine if more information is wanted</i>	• Jangan memaksakan informasi kepada pasien (misalnya, "Apakah Saudara ingin saya menjelaskan sedikit lebih lanjut?")
<i>Give warning shots</i>	• Jangan langsung sampaikan informasi begitu saja! (misalnya, "Saya khawatir ini terlihat cukup serius")
<i>Allow patient to refuse information at that time</i>	• Penolakan adalah mekanisme pertahanan dan suatu cara untuk menghadapi kondisi atau situasi • Biarkan pasien mengendalikan jumlah informasi yang diterimanya
<i>Explain if requested</i>	• Lakukan langkah demi langkah • Detail mungkin tidak diingat, tetapi cara Saudara menjelaskannya akan tetap diingat
<i>Listen to concerns</i>	• Tanyakan, "Apa kekhawatiran Saudara saat ini?" • Berikan waktu dan ruang untuk jawaban
<i>Encourage feelings</i>	• Akui perasaan tersebut • Bersikaplah tanpa menghakimi
<i>Summarize</i>	• Tinjau kekhawatiran dan rencana perawatan • Bangun harapan • Tawarkan informasi tertulis jika diminta

<i>Follow-up</i>	• Tawarkan informasi lebih lanjut • Yakinkan pasien bahwa Saudara akan tetap tersedia
BREAKS (Narayanan et al., 2010)	
<i>Background</i>	Pengkajian mendalam mengenai status penyakit pasien, status emosional, keterampilan coping, tingkat pendidikan, dan sistem dukungan perlu dilakukan sebelum mencoba menyampaikan berita buruk.
<i>Rapport</i>	Membangun hubungan yang baik sangat penting. Tenaga kesehatan harus memiliki penghargaan positif tanpa syarat. Kondisi yang ada sebaiknya digali melalui pertanyaan terbuka.
<i>Explore</i>	Selalu lebih baik jika dokter (atau pihak yang akan menyampaikan berita buruk) memulai dengan apa yang pasien ketahui tentang penyakitnya.
<i>Announce</i>	Pemberian peringatan awal sangat diperlukan. Berikan informasi dalam kalimat yang singkat dan mudah dipahami. Selalu lebih baik untuk tidak memberikan lebih dari tiga informasi sekaligus pada waktu yang sama.
<i>Kindling</i>	Berikan ruang yang cukup untuk pengungkapan emosi yang bebas. Pastikan bahwa pasien/kerabat tidak salah memahami beratnya penyakit tersebut.
<i>Summarize</i>	Dokter (atau pihak yang akan menyampaikan berita buruk) harus merangkum sesi tersebut dan membahas rencana perawatan.
PEWTER (Nardi & Keefe-Cooperman, 2006)	
<i>Preparation</i>	Mempersiapkan orang yang akan menyampaikan berita melalui pendidikan dan pelatihan, serta mempersiapkan lingkungan dan pendekatan untuk menyampaikan berita tersebut.
<i>Evaluation</i>	Mengevaluasi apa yang sudah diketahui oleh pasien/keluarga.
<i>Warning</i>	Memberikan peringatan dengan membuat pernyataan singkat diikuti dengan keheningan singkat untuk mempersiapkan pasien/keluarga terhadap berita buruk yang akan datang.
<i>Telling</i>	Menyampaikan berita.

<i>Emotional response</i>	Memberi perhatian dan merespons dengan tepat terhadap respons emosional pasien/keluarga.
<i>Regrouping</i>	Menyusun kembali dengan membantu pasien/keluarga menuju langkah-langkah selanjutnya.
SUNBURN (Velez et al., 2022)	
<i>Setup</i>	Persiapan
<i>Understand perceptions</i>	Memahami persepsi pasien/keluarga terhadap kondisi
<i>Notify</i>	Berikan tanda bahwa informasi yang akan diberikan merupakan berita buruk
<i>Brief narrative and break bad news</i>	Berikan informasi awal, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian berita buruk
<i>Understand emotions</i>	Memahami emosi yang diekspresikan oleh pasien/keluarga
<i>Respond</i>	Bereaksi terhadap emosi atau respon yang ditunjukkan oleh pasien/keluarga
<i>Next steps</i>	Susun atau sepakati rencana lanjutannya.

Seringkali berita buruk juga harus disampaikan kepada pasien atau keluarga yang mengalami masalah atau gangguan mental. Untuk itu, langkah berikut ini dapat dipertimbangkan untuk diaplikasikan pada situasi tersebut (Kumar & Sarkhel, 2023):

1. Persiapan yang cukup. Pastikan bahwa informasi yang cukup telah dikumpulkan untuk mencapai diagnosis sementara setidaknya. Libatkan anggota keluarga dan pengasuh yang signifikan pada tahap ini dalam kasus gangguan mental berat atau gangguan perkembangan neurologi.
2. Pengaturan wawancara dengan privasi yang memadai. Disarankan untuk menghindari pembahasan informasi diagnostik di ruang tunggu poliklinik yang sibuk dan di hadapan individu lain yang tidak terkait. Menjamin privasi dan kerahasiaan yang memadai adalah hal yang sangat penting.
3. Menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman. Meninjau pengetahuan dan pemahaman yang ada diperlukan sebelum penyampaian informasi. Hal ini adalah kesempatan yang tepat untuk membersihkan mitos dan kesalahpahaman.
4. Libatkan orang terdekat dan nilai pengetahuan latar belakang mereka juga. Jika pasien memiliki kapasitas mental yang cukup, pendapatnya harus dicari mengenai anggota keluarga/pengasuh yang sebaiknya dilibatkan.

5. Peringatan awal. Daripada langsung menyampaikan berita buruk, hal itu harus didahului dengan peringatan bahwa informasi yang serius akan disampaikan. Periode keheningan singkat bisa sangat membantu.
6. Informasi mengenai penyakit. Selain membagikan semua informasi relevan tentang diagnosis, ini adalah kesempatan yang tepat untuk memberikan edukasi psikologis. Berbagi informasi harus mencakup penanaman harapan secara realistis.
7. Dorong ekspresi emosi dan tangani reaksi emosional yang muncul. Ini adalah tahap untuk memberikan empati dan mengurangi stigma.
8. Jelaskan semua implikasi yang mungkin sesuai dengan pertanyaan secara rinci. Gunakan kesempatan ini untuk membersihkan mitos dan kesalahpahaman; juga berikan rincian dukungan dan jaringan yang tersedia yang dapat diakses.
9. Ringkas diskusi, atur pertemuan tindak lanjut, dan dokumentasikan semuanya.

D. Pertimbangan Etik dan Budaya dalam Komunikasi

Berbeda dengan perawat di konteks Barat, sebagian besar perawat di Asia cenderung menggunakan pendekatan rutin dan spontan dalam memberikan informasi kepada pasien. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan komunikasi yang diperlukan, sehingga mereka tidak dapat berinteraksi secara efektif dengan pasien kanker lanjut untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebutuhan informasi mereka (Kvåle, 2007). Akibatnya, mereka cenderung memberikan nasihat secara dini sebelum pasien memiliki kesempatan untuk sepenuhnya mengungkapkan kebutuhannya dan mengatasi kesulitan dalam menyampaikan kekhawatiran mereka (Chong & Poon, 2011; Kvåle, 2007). Hal ini dikarenakan perkembangan paliatif di Asia dilakukan jauh setelah di negara-negara Barat, sehingga pendidikan formal untuk perawatan paliatif belum banyak tersedia.

Selain itu, baik perawat di Barat maupun di Asia mengalami kesulitan menahan dorongan untuk segera menyelesaikan masalah pasien setiap kali muncul perasaan negatif, yang merupakan salah satu perilaku yang sering mempengaruhi upaya perawatan (Lobb et al., 2015; Tay et al., 2011). Studi menunjukkan bahwa perawat sering kali memberikan nasihat terlalu dini kepada pasien kanker stadium akhir, yang dapat sangat membatasi kemampuan pasien untuk mengungkapkan lebih banyak tentang perasaan kecemasan atau tekanan emosional lainnya yang mereka alami. Selain itu, informasi yang diberikan perawat mungkin tidak sepenuhnya menjawab kekhawatiran utama pasien (Stajduhar et al., 2010).

Secara keseluruhan, komunikasi yang tidak tepat dapat menyebabkan pasien paliatif dapat membentuk asumsi keliru tentang keengganan perawat untuk terlibat dan menjalin hubungan dengan mereka. Pada akhirnya, hal ini dapat menimbulkan

ketidakpuasan dan menghambat hubungan antara perawat dan pasien (Jasmine, 2009). Selain itu, kegagalan dalam memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan psikososial dan kekhawatiran fisik pasien dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup, serta kemampuan pasien dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai perawatan diri, yang pada akhirnya dapat menyebabkan masalah emosional yang tidak perlu (Thorne et al., 2005).

Aspek hukum dan hak asasi manusia memberikan perlindungan mendasar yang memungkinkan partisipasi yang setara dan keadilan individu dalam suatu masyarakat. Ini berarti bahwa "tidak seorang pun boleh merugikan orang lain dalam hal kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau kepemilikannya" (Peel, 2005). Sebenarnya secara umum, prinsip etika dalam berkomunikasi dengan pasien dan keluarga di area perawatan paliatif adalah sama dengan prinsip komunikasi perawatan pada umumnya. Beberapa prinsip etika yang harus dipegang oleh perawat dalam berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya di area perawatan paliatif adalah sebagai berikut (Mohanti, 2009; Wilkinson, 1991):

1. Menghormati otonomi pasien
 - a. Perawat harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi, prognosis, dan pilihan pengobatan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
 - b. Pasien harus diberi kebebasan untuk mengungkapkan preferensi dan nilai-nilai mereka, serta keputusan mereka harus dihormati, bahkan jika mereka menolak pengobatan atau perawatan.
2. Bertindak demi kepentingan terbaik pasien
 - a. Komunikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan emosional, psikologis, dan spiritual pasien.
 - b. Perawat harus memberikan dukungan, kenyamanan, dan harapan, sambil tetap menjaga kejujuran (secara sensitif) mengenai kondisi pasien.
3. *Non-maleficence* (tidak menyakiti pasien)
 - a. Perawat harus menghindari tekanan emosional yang tidak perlu dengan menyampaikan berita buruk secara sensitif dan empatik.
 - b. Bahasa yang digunakan harus jelas dan penuh kasih, menghindari istilah medis yang dapat membingungkan atau menimbulkan kecemasan bagi pasien dan keluarga mereka.
4. Keadilan (kesetaraan dalam perawatan)
 - a. Semua pasien harus mendapatkan akses yang setara dan adil ke perawatan paliatif berkualitas tinggi, tanpa memSaudarang status sosial ekonomi, latar belakang budaya, atau keyakinan pribadi.

- b. Komunikasi harus disesuaikan dengan bahasa dan tingkat pemahaman pasien untuk memastikan mereka benar-benar memahami informasi yang diberikan.
- 5. Kejujuran dan keterbukaan
 - a. Perawat harus berkomunikasi secara terbuka mengenai kondisi pasien sambil tetap menjaga keseimbangan antara kejujuran dan harapan.
 - b. Memberikan harapan palsu harus dihindari karena dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan kebingungan.
- 6. Kerahasiaan dan privasi
 - a. Informasi kesehatan yang sensitif hanya boleh dibagikan kepada mereka yang terlibat langsung dalam perawatan pasien.
 - b. Diskusi mengenai prognosis, pengobatan, dan keinginan pribadi pasien harus dilakukan dengan menjaga privasi dan penuh penghormatan.
- 7. Sensitivitas budaya dan komunikasi yang dipersonalisasi
 - a. Perawat harus mengenali dan menghormati perbedaan budaya dalam cara pasien dan keluarga memahami serta mendiskusikan penyakit terminal.
 - b. Beberapa budaya mungkin lebih memilih agar keluarga menerima informasi medis terlebih dahulu sebelum pasien. Memahami dan menghormati preferensi ini sangatlah penting untuk diidentifikasi.
- 8. Dukungan emosional dan mendengarkan secara aktif
 - a. Perawat harus melaksanakan keterampilan mendengarkan secara aktif, memberikan kesempatan bagi pasien untuk mengungkapkan ketakutan, kekhawatiran, dan keinginan mereka tanpa interupsi.
 - b. Memvalidasi emosi pasien serta merespons dengan empati dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas perawatan.
- 9. Mendukung keluarga dan pengasuh
 - a. Keluarga harus dilibatkan dalam diskusi untuk memastikan bahwa mereka memahami kondisi pasien dan rencana perawatannya.
 - b. Perawat harus memberikan bimbingan kepada keluarga tentang cara mendukung orang tercinta mereka, serta menghadapi duka dan stres.

E. Komunikasi Interdisipliner dan Kolaborasi Tim

Kolaborasi interprofesional terjadi ketika tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu bekerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan, memecahkan masalah, membuat keputusan bersama tentang cara terbaik untuk melanjutkan, dan mengevaluasi hasil secara kolektif (McDonald & McCallin, 2010). Kolaborasi interprofesional mendukung perawatan yang berfokus pada pasien dan terjadi melalui kerja tim. Interaksi tim, masalah organisasi yang lebih luas, dan struktur lingkungan, seperti masalah keselamatan, kualitas, efisiensi, dan efektivitas

memengaruhi model perawatan ini. Pengaruh kontekstual yang lebih luas ini memengaruhi praktik di mana ada ketegangan antara cita-cita kolaborasi interprofesional dan realitas praktik. Hal ini tampak jelas ketika posisi pasien dan keluarga dalam kolaborasi interprofesional dipertimbangkan.

Kolaborasi dan pembagian kerja membantu memastikan bahwa sumber daya medis, keperawatan, terapi, perawatan sosial, dan sumber daya lainnya digunakan dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan pasien yang mengalami penyakit terminal (Peppiatt, 1998). Tinjauan tentang kontinuitas perawatan dan pengambilan keputusan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas dan kualitas kerja tim multidisipliner. Hal ini termasuk pelatihan, pengalaman, dan keahlian anggota tim, filosofi perawatan tim, dan struktur organisasi (Bliss & While, 2003). Secara khusus, kualitas hubungan antara perawat di komunitas dan dokter umum dapat memengaruhi ketepatan waktu rujukan pasien ke layanan perawatan perawat di pelayanan primer, efektivitas pengendalian gejala, dan kebutuhan untuk rawat inap di rumah sakit (Austin et al., 2000).

Suatu *framework* telah dikembangkan untuk menjamin kolaborasi dan komunikasi antar profesional kesehatan, sebagai berikut (Mahmood-Yousuf et al., 2008):

1. Komunikasi

Menyimpan daftar perawatan suportif untuk pasien yang sedang sakit terminal, pertemuan tim multidisipliner secara berkala, dan catatan yang dipegang oleh pasien.

2. Koordinasi perawatan

Koordinator praktik perlu memastikan kelancaran prosedur perawatan paliatif. Tyiskan dokter dan perawat yang ditunjuk untuk setiap pasien.

3. Manajemen gejala

Perlunya dilakukan pengkajian holistik terhadap gejala. Gunakan instrumen penilaian gejala.

4. Kontinuitas perawatan di luar jam kerja

Mengirimkan rincian pasien yang sedang sakit terminal ke penyedia layanan di luar jam kerja. Menyimpan obat-obatan di rumah yang diperkirakan akan dibutuhkan (misalnya, diamorfin untuk disuntikkan).

5. Pembelajaran berkelanjutan

Audit terhadap pemberian perawatan paliatif, pembelajaran yang berfokus pada praktik/pasien termasuk analisis peristiwa signifikan.

6. Dukungan karir

Mengidentifikasi kebutuhan pengasuh. Menyimpan daftar pengasuh. Menawarkan dukungan praktis, emosional, dan dukungan berduka.

7. Perawatan akhir kehidupan

Penggunaan protokol atau jalur untuk memastikan praktik/pelayanan yang baik.

F. Latihan

1. Seorang perawat merawat pasien laki-laki berusia 68 tahun dengan kanker paru stadium lanjut. Dokternya baru saja memberi tahu bahwa kondisinya tidak lagi merespons pengobatan. Pasien tampak cemas dan bertanya kepada perawat, "Apa artinya ini bagi saya? Apakah saya masih punya pilihan?"
Apa respons yang paling tepat dari perawat?
 - A. "Saya mengerti ini sulit. Apakah Saudara ingin saya duduk bersama Saudara dan membicarakan apa yang dokter sampaikan?"
 - B. "Jangan khawatir, dokter kadang bisa salah. Mungkin masih ada harapan untuk sembuh."
 - C. "Artinya tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Saudara harus menikmati waktu yang tersisa."
 - D. "Saya hanya perawat, Saudara sebaiknya bertanya langsung kepada dokter."
 - E. "Mari kita bahas hal lain yang lebih positif."
2. Seorang pasien laki-laki 75 tahun dengan gagal jantung, bertanya kepada perawatnya, "Berapa lama lagi saya bisa hidup?" Putrinya duduk di sampingnya dengan ekspresi khawatir.
Bagaimana pendekatan terbaik yang dapat dilakukan oleh perawat?
 - A. "Sulit untuk memprediksi secara pasti, tetapi saya dapat membantu Saudara memahami apa yang mungkin terjadi dan mendukung Saudara melalui ini."
 - B. "Sebaiknya Saudara bertanya kepada dokter; saya tidak bisa memberikan informasi seperti itu."
 - C. "Mengapa Saudara memikirkan itu sekarang? Lebih baik fokus untuk sembuh."
 - D. "Sebagian besar orang dengan kondisi ini tidak bertahan lama, tetapi setiap orang berbeda."
 - E. "Saya tidak tahu, mari kita bicarakan hal lain untuk membuat Saudara lebih bersemangat."
3. Seorang perempuan, istri pasien dengan penyakit terminal, bingung apakah harus melanjutkan pengobatan agresif atau beralih ke perawatan paliatif. Dia bertanya kepada perawat, "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jika ini suami Saudara, apa yang akan Saudara lakukan?"
Apa respon yang paling tepat dari perawat?
 - A. "Jika ini suami saya, saya akan menghentikan pengobatan dan memilih perawatan paliatif."

- B. "Itu sepenuhnya keputusan Saudara. Ikuti saja naluri Saudara."
 - C. "Ini adalah keputusan yang sulit. Mari kita bicarakan apa yang paling penting bagi suami dan keluarga Saudara."
 - D. "Dokter akan memutuskan yang terbaik. Saudara tidak perlu khawatir."
 - E. "Saudara harus mencoba semua pengobatan yang tersedia; menyerah bukanlah pilihan."
4. Dalam pertemuan keluarga, seorang anak (laki-laki), yang ibunya berada pada tahap akhir demensia, tiba-tiba meninggikan suara dan berkata, "Saya tidak percaya dokter! Mereka (dokter) menyerah itu!"
Apa yang harus dilakukan oleh perawat?
- A. "Saudara harus tetap tenang. Dokter tahu apa yang mereka lakukan."
 - B. "Saya melihat ini sangat membuat Saudara sedih. Bisakah Saudara menceritakan lebih lanjut apa yang membuat Saudara khawatir?"
 - C. "Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan, dan kita harus menerima kenyataan ini."
 - D. "Tolong jangan berteriak; itu tidak akan membantu situasi."
 - E. "Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai rencana perawatan."
5. Seorang perawat sedang mendiskusikan pilihan perawatan akhir hayat dengan keluarga. Putri pasien berkata, "Dalam budaya kami, kami tidak memberi tahu orang tua tentang penyakit terminal. Kami percaya lebih baik mereka tidak mengetahuinya."
Apa seharusnya respon terbaik dari perawat?
- A. "Saya memahami bahwa kepercayaan budaya sangat penting. Bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menghormati nilai keluarga Saudara sambil memastikan perawatan Ayah/Bapak sesuai dengan keinginannya?"
 - B. "Itu bukan cara kami di sini. Pasien memiliki hak untuk mengetahui diagnosis mereka."
 - C. "Saudara harus mengatakan yang sebenarnya kepadanya; tidak adil menyembunyikan informasi ini."
 - D. "Dokter harus menjelaskan semuanya kepadanya, apakah dia ingin mendengarnya atau tidak."
 - E. "Saya serahkan keputusan ini kepada Saudara; saya tidak akan mengatakan apa pun."

Kunci Jawaban

1. Jawaban yang benar: **A**

Respon ini mengakui emosi pasien dan mengundang percakapan terbuka, menunjukkan empati dan dukungan.

2. Jawaban yang benar: **A**

Respons ini jujur, namun tetap memberikan dukungan dan membantu pasien memahami situasinya.

3. Jawaban yang benar: **C**

Respons ini membantu anggota keluarga fokus pada nilai dan tujuan pasien, bukan memberikan pendapat pribadi.

4. Jawaban yang benar: **B**

Mengakui emosi pasien dan memberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan dapat membantu menenangkan situasi dan membuka diskusi.

5. Jawaban yang benar: **A**

Respons ini menghormati nilai budaya keluarga sambil mencari pendekatan yang menghormati prinsip etis dan komunikasi berpusat pada pasien

G. Rangkuman Materi

Bab ini merupakan panduan komprehensif bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami komunikasi dalam perawatan paliatif. Materi mencakup hubungan terapeutik, penyampaian kabar buruk, diskusi prognosis, perencanaan perawatan, serta dukungan bagi keluarga dalam pengambilan keputusan akhir kehidupan. Dengan pendekatan berpusat pada pasien, bab ini juga menyajikan strategi praktis seperti protokol SPIKES atau PEWTER untuk percakapan sensitif, seperti pada *breaking bad news*. Selain itu, bab ini menekankan pentingnya kolaborasi antarprofesional, aspek etika, dan kompetensi budaya. Mahasiswa akan dibekali keterampilan komunikasi yang efektif, penuh empati, dan berbelas kasih dalam perawatan paliatif.

H. Glosarium

Beban finansial: Kesulitan ekonomi yang dialami pasien dan keluarganya akibat biaya perawatan dan pengobatan jangka panjang.

Beban fisik: Kesulitan yang dialami pasien terkait kondisi kesehatan, seperti nyeri, kelelahan, dan keterbatasan fisik.

Beban mental: Tantangan psikologis yang dihadapi pasien dan keluarga, seperti kecemasan, stres, dan depresi.

Beban sosial: Dampak penyakit terhadap hubungan sosial pasien dan keluarganya, termasuk isolasi dan perubahan peran dalam keluarga.

Berita buruk: Informasi medis yang dapat berdampak negatif dan serius terhadap harapan serta kesejahteraan mental seseorang.

Diagnosis: Penentuan suatu penyakit atau kondisi medis berdasarkan pemeriksaan dan analisis gejala pasien.

Edukasi pasien: Penyampaian informasi yang relevan dan akurat kepada pasien untuk membantu mereka memahami kondisi kesehatan dan pilihan perawatan mereka.

Empati: Kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain serta memberikan respons yang mendukung.

Fase kerja: Tahap di mana perawat memberikan perawatan aktif dan pasien berpartisipasi dalam pengobatan serta perencanaan perawatan.

Fase pengenalan: Tahap awal hubungan antara perawat dan pasien yang berfokus pada membangun kepercayaan dan memahami kondisi pasien.

Fase terminasi: Tahap akhir hubungan perawat-pasien yang melibatkan perpisahan dan transisi ke tahap perawatan berikutnya.

Gaya belajar: Preferensi individu dalam menerima dan memahami informasi, yang dapat mempengaruhi cara pasien menerima edukasi kesehatan.

Hak asasi manusia: Hak fundamental yang dimiliki setiap individu, termasuk hak untuk mendapatkan informasi medis yang jujur dan transparan.

Hubungan perawat-pasien: Interaksi profesional antara perawat dan pasien yang bertujuan memberikan dukungan dan perawatan yang optimal.

Kanker lanjut: Tahap penyakit kanker yang telah menyebar luas dan memiliki kemungkinan pemulihan yang rendah.

Keadilan dalam perawatan: Konsep yang memastikan bahwa semua pasien menerima perlakuan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kesejahteraan mental: Kondisi emosional dan psikologis seseorang yang dapat dipengaruhi oleh berita buruk atau situasi stres lainnya.

Komunikasi non-verbal: Bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan nada suara.

Komunikasi verbal: Bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan dalam interaksi antara perawat dan pasien.

Konflik etis: Dilema yang dialami tenaga kesehatan dalam menyeimbangkan kejujuran dengan kebutuhan emosional pasien dan keluarga.

Konsultan senior: Dokter atau tenaga medis senior yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi penting kepada pasien dan keluarganya.

Kualitas hidup: Tingkat kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial yang dialami pasien dalam menjalani kehidupannya.

Mendengarkan aktif: Teknik komunikasi yang melibatkan perhatian penuh pada pembicara, termasuk mengajukan pertanyaan klarifikasi dan memberikan respons yang sesuai.

Partisipasi setara: Prinsip yang menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil keputusan terkait perawatan kesehatannya.

Pemberdayaan pasien: Proses di mana pasien diberikan informasi dan dukungan untuk membuat keputusan yang bijak terkait perawatan mereka.

Pendekatan berpusat pada keluarga: Konsep dalam perawatan yang melibatkan keluarga pasien dalam pengambilan keputusan dan dukungan emosional.

Pendekatan berpusat pada pasien: Model perawatan yang menekankan pada kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan rutin: Cara komunikasi yang dilakukan secara otomatis dan tanpa banyak pertimbangan individu terhadap kebutuhan pasien.

Pendekatan spontan: Gaya komunikasi yang tidak direncanakan dan dilakukan secara langsung tanpa strategi yang terstruktur.

Pendidikan formal perawatan paliatif: Program pendidikan yang memberikan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan dalam memberikan perawatan paliatif.

Penggunaan diri secara terapeutik: Kemampuan perawat untuk menggunakan kepribadian, sikap, dan pendekatan profesional mereka untuk membantu pasien.

Penyampaian kabar buruk: Proses komunikasi yang sensitif ketika menyampaikan informasi yang tidak diharapkan kepada pasien atau keluarganya.

Penyesuaian psikososial: Proses adaptasi individu terhadap kondisi penyakitnya, termasuk aspek emosional, sosial, dan psikologis.

Perawatan *Hospice Care*: Perawatan khusus bagi pasien dengan penyakit terminal yang bertujuan memberikan kenyamanan dan dukungan di akhir hayat.

Perawatan paliatif: Pendekatan medis yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dengan penyakit serius melalui pengelolaan gejala, nyeri, dan dukungan emosional.

Perencanaan perawatan lanjutan: Diskusi dan keputusan mengenai perawatan medis di masa depan berdasarkan preferensi pasien dan prognosis penyakit.

Perencanaan perawatan lanjutan: Proses diskusi dan perencanaan tentang perawatan medis masa depan pasien berdasarkan preferensi dan kondisi kesehatannya.

Prinsip etika dalam komunikasi: Pedoman moral dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga, terutama dalam konteks perawatan paliatif.

Prinsip komunikasi: Pedoman dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarganya untuk membangun hubungan yang efektif dan empatik dalam perawatan paliatif.

Prognosis: Perkiraan perjalanan penyakit dan kemungkinan hasil kesehatan pasien berdasarkan kondisi medisnya.

Situasi darurat: Keadaan kritis yang memerlukan tindakan cepat, termasuk dalam penyampaian berita buruk ketika dokter yang merawat tidak tersedia.

Staf perawat senior: Perawat dengan pengalaman lebih yang dapat dipercaya untuk menyampaikan informasi medis dalam situasi darurat.

Tekanan emosional: Perasaan cemas, stres, atau beban psikologis yang dialami pasien akibat kondisi penyakitnya.

Teknik terapeutik: Metode yang digunakan dalam interaksi perawatan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan emosional pasien.

I. Daftar Pustaka

- Ang, S. H. M. (2019). Promoting Effective Nurse-Patient Communication in Palliative Care Using the SAGE and THYME Model: Can it be Implemented Cross-Culturally? *The Open Nursing Journal*, 13, 153-155. <https://doi.org/https://doi.org/10.2174/1874434601913010153>
- Austin, L., Luker, K., Caress, A., & Hallett, C. (2000). Palliative care: community nurses' perceptions of quality. *BMJ Quality & Safety*, 9(3), 151-158.
- Baile, W. F., Buckman, R., Lenzi, R., Glober, G., Beale, E. A., & Kudelka, A. P. (2000). SPIKES—a six-step protocol for delivering bad news: application to the patient with cancer. In (Vol. 5, pp. 302-311): Oxford University Press.
- Bliss, J., & While, A. (2003). Decision-making in palliative and continuing care in the community: an analysis of the published literature with reference to the context of UK care provision. *INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES*, 40(8), 881-888.
- Buckman, R. (1984). Breaking bad news: why is it still so difficult? *British medical journal (Clinical research ed.)*, 288(6430), 1597.
- Cardoso, A. F., Rosendo, I., Santiago, L., Neto, J., & Cardoso, D. (2024). Protocols for breaking bad news in health care: a scoping review protocol. *JBIS Evidence Synthesis*, 22(11). https://journals.lww.com/jbisrjr/fulltext/2024/11000/protocols_for_breaking_bad_news_in_health_care_a.13.aspx
- Care, H. (2013). Clinical practice guidelines for quality palliative care. *Third National Consensus Project for Quality Palliative Care*.
- Chong, P., & Poon, W. H. (2011). The lived experience of palliative homecare nurses in Singapore. *Singapore medical journal*, 52(3), 151.
- Dahlin, C. M., & Wittenberg, E. (2015). Communication in palliative care: An essential competency for nurses. In *Oxford Textbook of Palliative Nursing* (pp. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/med/9780199332342.003.0005>

- Fuoto, A., & Turner, K. M. (2019). Palliative Care Nursing Communication: An Evaluation of the COMFORT Model. *JOURNAL OF HOSPICE & PALLIATIVE NURSING*, 21(2). https://journals.lww.com/jhpn/fulltext/2019/04000/palliative_care_nursing_communication_an.5.aspx
- Jasmine, T. (2009). The use of effective therapeutic communication skills in nursing practice. *Singapore nursing journal*, 36(1), 35-40.
- Kaye, P. (1997). Breaking bad news: A 10 step approach (Vol. 1). Northampton: EPL.
- Kumar, V., & Sarkhel, S. (2023). Clinical practice guidelines on breaking bad news. *INDIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY*, 65(2), 238-244.
- Kustanti, C. Y., & Nobe, N. (2024). Palliative care: "It is OK to be not OK". *The Journal of Palembang Nursing Studies*, 3(2), 54-57. <https://doi.org/10.55048/jpns112>
- Kvåle, K. (2007). Do cancer patients always want to talk about difficult emotions? A qualitative study of cancer inpatients communication needs. *EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING*, 11(4), 320-327.
- Lloyd-Williams, M. (2008). Psychosocial issues in palliative care.
- Lobb, E. A., Lacey, J., Kearsley, J., Liauw, W., White, L., & Hosie, A. (2015). Living with advanced cancer and an uncertain disease trajectory: an emerging patient population in palliative care? *BMJ SUPPORTIVE & PALLIATIVE CARE*, 5(4), 352-357.
- Mahmood-Yousuf, K., Munday, D., King, N., & Dale, J. (2008). Interprofessional relationships and communication in primary palliative care: impact of the Gold Standards Framework. *Br J Gen Pract*, 58(549), 256-263. <https://doi.org/10.3399/bjgp08X279760>
- McDonald, C., & McCallin, A. (2010). Interprofessional collaboration in palliative nursing: what is the patient-family role? *International Journal of Palliative Nursing*, 16(6), 286-289. <https://doi.org/10.12968/ijpn.2010.16.6.48832>
- Mohanti, B. K. (2009). Ethics in palliative care. *Indian J Palliat Care*, 15(2), 89-92. <https://doi.org/10.4103/0973-1075.58450>
- Narayanan, V., Bista, B., & Koshy, C. (2010). 'BREAKS' protocol for breaking bad news. *Indian journal of palliative care*, 16(2), 61.
- Nardi, T., & Keefe-Cooperman, K. (2006). Communicating bad news: a model for emergency mental health helpers.
- Peel, M. (2005). Human rights and medical ethics. *J R Soc Med*, 98(4), 171-173. <https://doi.org/10.1177/014107680509800412>
- Peppiatt, R. (1998). Palliative terminal care. *The British Journal of General Practice*, 48(431), 1297.

- Perrin, K. O. (2009). Communicating with Seriously Ill and Dying Patients, Their Families, and Their Health Care Providers. *Palliative care nursing: Quality care to the end of life*, 169.
- Rabow, M. W., & McPhee, S. J. (2000). Beyond breaking bad news: Helping patients who suffer. *BMJ*, 320(Suppl S3).
- Ragan, S. L. (2015). *Textbook of Palliative Care Communication*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/med/9780190201708.001.0001>
- Schofield, N. G., Green, C., & Creed, F. (2008). Communication skills of health-care professionals working in oncology—Can they be improved? *EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING*, 12(1), 4-13.
- Stajduhar, K. I., Thorne, S. E., McGuinness, L., & Kim-Sing, C. (2010). Patient perceptions of helpful communication in the context of advanced cancer. *JOURNAL OF CLINICAL NURSING*, 19(13-14), 2039-2047.
- Tay, L. H., Hegney, D., & Ang, E. (2011). Factors affecting effective communication between registered nurses and adult cancer patients in an inpatient setting: a systematic review. *International Journal of Evidence-Based Healthcare*, 9(2), 151-164.
- Thorne, S. E., Bultz, B. D., & Baile, W. F. (2005). Is there a cost to poor communication in cancer care?: a critical review of the literature. *Psycho-Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer*, 14(10), 875-884.
- Velez, D., Gerberding, A., & Ahmeti, M. (2022). SUNBURN: a protocol for delivering bad news in trauma and acute care surgery. *Trauma Surgery & Acute Care Open*, 7(1), e000851.
- WHO. (2020). *Palliative care*. Retrieved July 20, 2023 from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>
- Wilkinson, J. (1991). The Ethics of Communication in Palliative Care. *PALLIATIVE MEDICINE*, 5(2), 130-137. <https://doi.org/10.1177/026921639100500207>

BAB 4

TINJAUAN SPIRITUAL TENTANG PERAWATAN PALIATIF

Pendahuluan

Buku ini berjudul **“Tinjauan Spiritual tentang Perawatan Paliatif”**, yang mencerminkan fokus utama pada pentingnya peran aspek spiritual dalam perawatan pasien yang menghadapi penyakit terminal. Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa keperawatan dan profesional dalam memahami serta mengintegrasikan pendekatan spiritual dalam praktik keperawatan paliatif.

Sebagai seorang Dosen keperawatan dengan pengalaman dalam bidang keperawatan paliatif dan spiritual, penulis memiliki motivasi untuk berbagi wawasan dan praktik terbaik yang telah dikembangkan. Dengan latar belakang pendidikan yang relevan dan pengalaman langsung dalam mendampingi pasien paliatif, buku ini disusun untuk menjadi panduan yang praktis dan aplikatif.

Tujuan utama dari buku ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa dan praktisi keperawatan tentang pendekatan spiritual dalam perawatan paliatif. Dengan membaca buku ini, pembaca diharapkan mampu memahami konsep spiritualitas dalam konteks keperawatan, mengidentifikasi kebutuhan spiritual pasien, merancang dan melaksanakan intervensi berbasis spiritual yang sesuai, serta mengevaluasi dampak dari pendekatan ini terhadap kualitas hidup pasien.

Buku ini ditujukan untuk mahasiswa keperawatan tingkat diploma dan sarjana, serta perawat profesional yang ingin meningkatkan kompetensinya dalam memberikan perawatan yang holistik dan berbasis spiritual. Struktur buku ini mencakup berbagai poin pembahasan yang dimulai dengan konsep dasar spiritualitas, teknik pengkajian kebutuhan spiritual, diagnose keperawatan berbasis spiritual, intervensi keperawatan berbasis spiritual, hingga evaluasi dan dokumentasi. Selain itu, buku ini juga menyediakan studi kasus nyata untuk membantu pembaca mengaplikasikan konsep dalam situasi klinis.

Untuk mendukung proses pembelajaran, buku ini dirancang dengan berbagai metode seperti teks naratif yang disertai penjelasan mendalam, ilustrasi, latihan soal, dan studi kasus. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran aktif

dan kolaboratif, yang mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan berdiskusi dalam mencari solusi.

Agar buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal, pembaca disarankan untuk membaca setiap poin pembahasan secara berurutan agar mendapatkan pemahaman yang terstruktur. Selain itu, mengerjakan latihan soal dapat membantu memperdalam pemahaman. Buku ini juga dapat dijadikan referensi dalam praktik klinis sehari-hari, khususnya dalam memberikan asuhan keperawatan berbasis spiritual.

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi tinjauan spiritual dalam perawatan paliatif untuk mendukung kesejahteraan pasien secara holistik.

Tujuan Instruksional Khusus:

1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep spiritualitas dalam konteks perawatan paliatif.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara kebutuhan spiritual dengan kualitas hidup pasien paliatif.
3. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian kebutuhan spiritual pasien dengan menggunakan alat yang sesuai.
4. Mahasiswa mampu merumuskan diagnosa keperawatan berbasis spiritual yang sesuai dengan nilai dan keyakinan pasien.
5. Mahasiswa mampu merumuskan rencana intervensi berbasis spiritual yang sesuai dengan nilai dan keyakinan pasien.
6. Mahasiswa mampu mengimplementasikan intervensi spiritual dalam perawatan pasien paliatif.
7. Mahasiswa mampu mengevaluasi dampak pendekatan spiritual terhadap kesejahteraan pasien.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

1. Mahasiswa memahami hubungan antara spiritualitas dan kesejahteraan pasien dalam perawatan paliatif.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori terkait kebutuhan spiritual pasien.

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian spiritual menggunakan alat yang sesuai (misalnya, FICA atau HOPE).
2. Mahasiswa mampu memberikan intervensi spiritual, seperti mendengarkan aktif, memberikan dukungan emosional, atau membantu pelaksanaan ritual keagamaan pasien.

Afektif:

1. Mahasiswa menunjukkan empati dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual pasien.
2. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan pasien dan keluarga mereka.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari konsep spiritualitas dalam perawatan paliatif, hubungan antara kebutuhan spiritual dan kualitas hidup pasien, pengkajian kebutuhan spiritual pasien, diagnosa keperawatan berbasis spiritual, perencanaan dan intervensi berbasis spiritual, implementasi dan evaluasi intervensi spiritual, serta dokumentasi intervensi spiritual.

A. Konsep Spiritualitas dalam Perawatan Paliatif

Spiritualitas merupakan dimensi universal yang mencakup kebutuhan manusia untuk menemukan makna, tujuan, dan koneksi dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan dimensi transendental. Dalam konteks perawatan paliatif, spiritualitas berfokus untuk membantu pasien memahami pengalaman hidup mereka, menghadapi penderitaan, dan menemukan kedamaian batin, terutama saat menghadapi penyakit terminal.

1. Elemen Penting dalam Spiritualitas

a. Makna dan Tujuan Hidup

Dalam perawatan paliatif, banyak pasien yang bertanya tentang tujuan hidup mereka di tengah penderitaan yang mereka alami. Pendekatan spiritual bertujuan untuk membantu pasien menemukan jawaban atas pertanyaan ini, yang sering kali bersifat personal dan unik (Goswami, 2016).

b. Koneksi dengan Orang Lain

Hubungan yang bermakna dengan keluarga, teman, atau tenaga kesehatan dapat memberikan dukungan emosional dan spiritual yang sangat dibutuhkan pasien (Best et al., 2023).

c. Dimensi Transendental

Banyak pasien yang menghadapi penyakit terminal mencari kedamaian melalui hubungan mereka dengan entitas yang lebih besar, seperti Tuhan atau alam semesta, tergantung pada keyakinan mereka (Chahrour et al., 2021).

Spiritualitas berbeda dari agama. Meskipun keduanya sering kali saling berkaitan, spiritualitas bersifat lebih universal, sedangkan agama melibatkan keyakinan, praktik, dan ritual yang lebih spesifik. Dalam perawatan paliatif, penting untuk menghormati perbedaan ini dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individu (Nissen et al., 2021).

2. Peran Spiritualitas dalam Perawatan Paliatif

a. Mengurangi Kecemasan dan Ketakutan

Banyak pasien yang merasa tenang setelah kebutuhan spiritual mereka dipenuhi. Misalnya, pasien yang merasa terhubung dengan Tuhan atau menemukan kedamaian melalui refleksi diri cenderung lebih mampu menghadapi akhir kehidupan mereka.

b. Meningkatkan Kesejahteraan Emosional

Spiritualitas dapat membantu pasien menerima kondisi mereka dengan lebih baik, mengurangi rasa putus asa, dan meningkatkan rasa syukur (Best et al., 2023).

c. Mendukung Proses Berduka

Spiritualitas juga dapat membantu keluarga pasien dalam proses berduka dengan memberikan harapan dan penghiburan.

B. Hubungan antara Kebutuhan Spiritual dan Kualitas Hidup Pasien

Kebutuhan spiritual adalah aspek penting yang sering kali diabaikan dalam perawatan kesehatan, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup pasien, terutama mereka yang berada dalam perawatan paliatif. Kebutuhan spiritual melibatkan kebutuhan untuk menemukan makna, tujuan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan hidup, termasuk penyakit terminal.

1. Dampak Kebutuhan Spiritual yang Tidak Terpenuhi

Jika kebutuhan spiritual tidak terpenuhi, pasien dapat mengalami peningkatan kecemasan, depresi, dan perasaan putus asa. Hal ini dapat memperburuk pengalaman pasien terhadap rasa sakit dan penderitaan mereka. Sebaliknya, ketika kebutuhan spiritual dipenuhi, pasien cenderung merasa lebih tenang, memiliki harapan, dan mampu menghadapi kondisi mereka dengan lebih baik (Best et al., 2023).

2. Peran Spiritualitas dalam Meningkatkan Kualitas Hidup

a. Mengurangi Stres Psikologis

Pemenuhan kebutuhan spiritual membantu mengurangi rasa takut terhadap kematian dan meningkatkan penerimaan terhadap kondisi terminal. Penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan dukungan spiritual yang baik memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih rendah (Goswami, 2016).

b. Meningkatkan Harapan

Spiritualitas dapat membantu pasien menemukan harapan baru, bahkan di tengah situasi sulit, melalui refleksi diri dan hubungan dengan sesuatu yang transendental.

c. Mendukung Hubungan Sosial

Hubungan spiritual sering kali memperkuat hubungan pasien dengan keluarga dan komunitas, menciptakan jaringan dukungan yang sangat dibutuhkan (Chahrour et al., 2021).

d. Meningkatkan Kepuasan Hidup

Pasien yang merasa kebutuhan spiritualnya dipenuhi sering melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap hidup mereka, meskipun menghadapi kondisi yang menantang (Best et al., 2023).

3. Kualitas Hidup dalam Perawatan Paliatif

Kualitas hidup pasien dalam perawatan paliatif tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual. Menurut World Health Organization (WHO), pendekatan holistik yang melibatkan pemenuhan kebutuhan spiritual adalah bagian integral dari perawatan paliatif yang komprehensif (Wong et al., 2019).

4. Strategi untuk Memenuhi Kebutuhan Spiritual:

a. Pengkajian Kebutuhan Spiritual

Menggunakan alat seperti FICA atau HOPE untuk mengevaluasi keyakinan, praktik, dan harapan spiritual pasien.

b. Pendekatan Person-Centered Care

Memberikan perawatan yang disesuaikan dengan nilai dan keyakinan individu pasien.

c. Melibatkan Tokoh Agama atau Konselor Spiritual

Ketika diperlukan, melibatkan tokoh agama atau konselor spiritual dapat membantu pasien merasa lebih didukung secara emosional dan spiritual.

d. Mendorong Refleksi Diri

Membantu pasien untuk merefleksikan pengalaman hidup mereka dan menemukan makna dalam situasi yang mereka hadapi.

C. Pengkajian Kebutuhan Spiritual Pasien

Berisi Materi Pengkajian kebutuhan spiritual adalah langkah awal yang penting dalam memberikan perawatan yang holistik. Proses ini bertujuan untuk memahami keyakinan, nilai, praktik, dan sumber daya spiritual pasien yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Pengkajian ini dilakukan dengan penuh empati dan sensitivitas budaya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien untuk berbagi.

1. Prinsip Dasar Pengkajian Kebutuhan Spiritual:

a. Person-Centered Care

Fokus pada kebutuhan dan preferensi individu pasien, memastikan bahwa pengkajian dilakukan tanpa memaksakan pandangan tertentu (Goswami, 2016).

b. Komunikasi Terbuka

Gunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong pasien berbagi pengalaman spiritual mereka.

c. Empati dan Non-Judgmental

Bersikap empatik dan tidak menghakimi untuk membangun kepercayaan dengan pasien (Chahrour et al., 2021).

2. Alat Pengkajian Kebutuhan Spiritual

a. FICA yang dinyatakan dalam penelitiannya Nissen et. al (2021):

- 1) Faith** (Keyakinan): Apa keyakinan pasien terkait spiritualitas atau agama?
- 2) Importance** (Kepentingan): Seberapa penting spiritualitas dalam kehidupan mereka, terutama terkait kesehatan?
- 3) Community** (Komunitas): Apakah pasien memiliki komunitas spiritual atau agama yang mendukung?
- 4) Address** (Pendekatan): Bagaimana kebutuhan spiritual mereka dapat diintegrasikan ke dalam perawatan kesehatan?

b. HOPE yang dinyatakan dalam penelitiannya Fopka et. al (2022)

- 1) Sources of Hope** (Sumber Harapan): Apa yang memberi pasien harapan dalam situasi sulit?
- 2) Organized Religion** (Agama Terorganisir): Apakah pasien terlibat dalam agama tertentu?
- 3) Personal Practices** (Praktik Pribadi): Apa bentuk ibadah atau meditasi yang dilakukan pasien?
- 4) Effects on Medical Care** (Pengaruh pada Perawatan): Bagaimana spiritualitas memengaruhi keputusan perawatan medis pasien?

3. Proses Pengkajian

- a. Observasi:** Amati bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan lingkungan pasien untuk petunjuk tentang kebutuhan spiritual mereka.
- b. Wawancara:** Gunakan alat seperti FICA atau HOPE untuk menggali lebih dalam tentang kepercayaan dan harapan pasien.
- c. Kolaborasi:** Libatkan keluarga, tokoh agama, atau konselor spiritual sesuai kebutuhan pasien.

4. Contoh Pertanyaan dalam Pengkajian

- a.** Apa yang memberi Anda kekuatan saat menghadapi situasi sulit?
- b.** Apakah ada praktik spiritual atau keagamaan yang ingin Anda lakukan selama perawatan?

- c. Bagaimana kami dapat mendukung Anda secara spiritual selama berada di rumah sakit?

5. Tantangan dalam Pengkajian

- a. **Sensitivitas Budaya:** Perbedaan budaya dapat memengaruhi cara pasien berbagi informasi spiritual.
- b. **Waktu yang Terbatas:** Pengkajian spiritual membutuhkan waktu, sehingga perawat perlu mengintegrasikannya dengan efisien ke dalam perawatan sehari-hari.
- c. **Ketidaktahuan atau Ketidaknyamanan:** Perawat yang tidak merasa percaya diri dalam melakukan pengkajian spiritual mungkin membutuhkan pelatihan lebih lanjut (Best et al., 2023).

6. Manfaat Pengkajian Kebutuhan Spiritual

- a. Membantu pasien menemukan harapan dan kedamaian.
- b. Memfasilitasi diskusi yang mendalam tentang keputusan akhir hayat.
- c. Meningkatkan kepuasan pasien terhadap perawatan yang diberikan (Goswami, 2016).

D. Diagnosa Keperawatan Berbasis Spiritual

Diagnosa keperawatan berbasis spiritual adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi respons pasien terhadap kebutuhan spiritual yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Diagnosa ini membantu perawat dalam merancang intervensi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien.

1. Jenis Diagnosa Keperawatan Berbasis Spiritual

- a. **Distress Spiritual:** Ditandai dengan rasa kehilangan makna, kecemasan tentang kehidupan setelah kematian, atau kesulitan dalam berhubungan dengan sesuatu yang transendental. Contohnya, pasien yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan saat menghadapi penyakit terminal (Goswami, 2016).
- b. **Kebutuhan Peningkatan Spiritualitas:** Pasien yang ingin memperdalam atau mengeksplorasi dimensi spiritual mereka untuk meningkatkan kualitas hidup, misalnya dengan mempelajari meditasi atau menghadiri ritual keagamaan (Best et al., 2023).
- c. **Risiko Gangguan Kesejahteraan Spiritual:** Pasien dengan kondisi yang berpotensi menurunkan kesejahteraan spiritual mereka, seperti isolasi sosial atau kehilangan sumber daya spiritual.

2. Komponen Diagnosa Keperawatan Berbasis Spiritual

- a. **Pengkajian:** Menggunakan alat seperti FICA atau HOPE untuk mengidentifikasi kebutuhan spiritual pasien.

- b. **Analisis Data:** Mengintegrasikan hasil pengkajian dengan kondisi pasien untuk merumuskan diagnosa.
- c. **Perumusan Diagnosa:** Menyusun diagnosa yang mencerminkan kebutuhan spiritual pasien.

3. Contoh Diagnosa Keperawatan Berbasis Spiritual

- a. Distress spiritual berhubungan dengan isolasi sosial, ditandai dengan perasaan kesepian dan kehilangan harapan.
- b. Risiko gangguan kesejahteraan spiritual berhubungan dengan kehilangan dukungan komunitas agama.
- c. Kebutuhan peningkatan spiritualitas berhubungan dengan keinginan untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan.

4. Strategi untuk Mengatasi Diagnosa Berbasis Spiritual

- a. **Intervensi Psikospiritual:** Melibatkan pasien dalam diskusi yang mendalam tentang harapan, ketakutan, dan keyakinan mereka.
- b. **Pendampingan Ritual:** Membantu pasien untuk melaksanakan ritual spiritual atau keagamaan yang penting bagi mereka.
- c. **Konseling Spiritual:** Melibatkan tokoh agama atau konselor spiritual untuk mendukung pasien.
- d. **Refleksi Diri:** Menggunakan teknik seperti jurnal atau meditasi untuk membantu pasien menemukan makna hidup mereka.

5. Manfaat Diagnosa Keperawatan Berbasis Spiritual:

- a. Membantu pasien menemukan kedamaian batin.
- b. Meningkatkan kualitas hidup dengan memenuhi kebutuhan spiritual.
- c. Mendukung keputusan perawatan yang sesuai dengan nilai-nilai spiritual pasien (Chahrour et al., 2021)

E. Perencanaan dan Intervensi Berbasis Spiritual

Berisi Materi Perencanaan dan intervensi berbasis spiritual merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kebutuhan spiritual pasien terpenuhi secara menyeluruh. Perencanaan yang baik membutuhkan pemahaman mendalam tentang hasil pengkajian kebutuhan spiritual pasien dan kolaborasi dengan pasien serta keluarga mereka.

1. Komponen Perencanaan Berbasis Siritual

- a. **Tujuan yang Jelas:** Tentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai, seperti membantu pasien menemukan kedamaian atau mendukung praktik spiritual tertentu.
- b. **Kolaborasi dengan Pasien:** Libatkan pasien dalam proses perencanaan untuk memastikan intervensi sesuai dengan nilai dan kepercayaan mereka.

- c. **Penggunaan Sumber Daya yang Tersedia:** Identifikasi sumber daya internal (seperti kekuatan spiritual pasien) dan eksternal (seperti konselor spiritual atau komunitas agama) yang dapat mendukung intervensi (Goswami, 2016).

2. Jenis Intervensi Berbasis Spiritual

a. Pendampingan Spiritual

- Mendengarkan aktif untuk memahami pengalaman spiritual pasien.
- Memberikan dukungan emosional selama proses refleksi diri.

b. Mendukung Praktik Spiritual

- Membantu pasien melaksanakan ritual keagamaan seperti doa, ibadah, atau meditasi.
- Menyediakan akses ke materi spiritual, seperti kitab suci, musik religius, atau alat bantu ibadah (Best et al., 2023).

c. Konseling Spiritual

- Menghubungkan pasien dengan tokoh agama atau konselor spiritual yang sesuai.
- Membantu pasien mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup dan kehidupan setelah kematian.

d. Refleksi dan Pencarian Makna

- Menggunakan teknik seperti menulis jurnal atau diskusi terarah untuk membantu pasien menemukan makna dalam pengalaman mereka.

3. Langkah Implementasi Intervensi Spiritual

- a. **Pengenalan Intervensi:** Jelaskan rencana intervensi kepada pasien dan keluarga, pastikan mereka merasa nyaman dengan langkah-langkah yang akan dilakukan.
- b. **Pelaksanaan Intervensi:** Terapkan intervensi yang telah direncanakan, dengan memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan pasien.
- c. **Pengawasan dan Dukungan Berkelanjutan:** Pantau respons pasien terhadap intervensi dan lakukan penyesuaian jika diperlukan.

4. Manfaat Intervensi Spiritual

- a. Membantu pasien menemukan harapan dan kedamaian batin.
- b. Mengurangi kecemasan dan rasa takut terkait kondisi terminal.
- c. Memperkuat hubungan antara pasien, keluarga, dan komunitas mereka.
- d. Meningkatkan kualitas hidup pasien dengan memenuhi kebutuhan spiritual mereka (Chahrour et al., 2021).

F. Implementasi dan Evaluasi Intervensi Spiritual

- 1. Implementasi Intervensi Spiritual:** Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah menerapkan intervensi spiritual sesuai dengan kebutuhan

pasien. Implementasi ini melibatkan penerapan strategi yang telah dirancang untuk mendukung kesejahteraan spiritual pasien. Beberapa langkah penting dalam implementasi meliputi:

a. Pengenalan Intervensi:

- Komunikasikan rencana intervensi kepada pasien dan keluarga dengan jelas.
- Pastikan semua pihak yang terlibat memahami tujuan intervensi.

b. Penciptaan Lingkungan yang Mendukung:

- Sediakan lingkungan yang nyaman dan bebas gangguan untuk melaksanakan intervensi.
- Pastikan privasi pasien terjaga selama proses berlangsung (Goswami, 2016)

c. Pelaksanaan Intervensi:

- Terapkan langkah-langkah intervensi seperti mendengarkan aktif, mendukung praktik spiritual, atau melibatkan konselor spiritual.
- Perhatikan kebutuhan khusus pasien, seperti keterbatasan fisik atau kognitif.

d. Kolaborasi Multidisiplin:

- Libatkan anggota tim kesehatan lain, seperti psikolog atau tokoh agama jika diperlukan.
- Koordinasikan langkah-langkah intervensi untuk memastikan pendekatan yang holistik (Best et al., 2023).

2. Evaluasi Intervensi Spiritual: Evaluasi adalah proses untuk menilai efektivitas intervensi spiritual yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus selama dan setelah implementasi untuk memastikan bahwa kebutuhan pasien terpenuhi.

a. Indikator Keberhasilan:

- Pasien menunjukkan peningkatan rasa damai dan penerimaan terhadap kondisinya.
- Pengurangan kecemasan, ketakutan, atau perasaan putus asa yang dirasakan pasien.
- Pasien merasa didukung dalam praktik spiritual atau keagamaan mereka (Chahrour et al., 2021).

b. Metode Evaluasi:

- **Observasi:** Amati perubahan dalam ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau perilaku pasien.
- **Wawancara:** Gunakan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pasien tentang pengalaman mereka.
- **Dokumentasi:** Catat respons pasien terhadap intervensi, serta perubahan dalam kebutuhan spiritual mereka.

c. Penyesuaian Intervensi:

- Berdasarkan hasil evaluasi, sesuaikan rencana intervensi untuk lebih memenuhi kebutuhan pasien.
- Diskusikan hasil evaluasi dengan pasien dan tim kesehatan untuk menentukan langkah selanjutnya.

3. Contoh Implementasi dan Evaluasi: Seorang pasien pria berusia 60 tahun dengan kanker paru-paru merasa cemas tentang akhir hidupnya. Setelah melakukan pengkajian, perawat merencanakan sesi doa bersama dengan pasien dan anggota keluarga. Setelah sesi, pasien melaporkan merasa lebih tenang dan terhubung dengan keluarganya. Evaluasi menunjukkan pengurangan tingkat kecemasan berdasarkan laporan pasien dan pengamatan perawat.

4. Manfaat Evaluasi yang Tepat:

- a. Memastikan kebutuhan spiritual pasien terpenuhi.
- b. Meningkatkan efektivitas intervensi melalui penyesuaian yang diperlukan.
- c. Memberikan dasar untuk praktik berbasis bukti dalam perawatan paliatif spiritual.

G. Dokumentasi Intervensi Spiritual.

Dokumentasi intervensi spiritual adalah proses pencatatan sistematis tentang pengkajian, implementasi, dan evaluasi intervensi spiritual yang dilakukan oleh perawat. Dokumentasi ini tidak hanya penting untuk memastikan kontinuitas perawatan, tetapi juga untuk memberikan bukti bahwa kebutuhan spiritual pasien telah dipenuhi secara profesional.

1. Tujuan Dokumentasi Intervensi Spiritual:

- a. **Memastikan Kontinuitas Perawatan:** Dokumentasi memungkinkan tenaga kesehatan lainnya memahami kebutuhan spiritual pasien dan melanjutkan intervensi yang relevan.
- b. **Menjadi Bukti Profesionalisme:** Catatan ini menunjukkan bahwa perawat telah memberikan perawatan berbasis holistik sesuai dengan standar praktik keperawatan (Goswami, 2016).
- c. **Mendukung Evaluasi dan Penyesuaian:** Dengan mencatat respons pasien terhadap intervensi, perawat dapat mengevaluasi efektivitas pendekatan yang telah dilakukan.

2. Komponen Penting dalam Dokumentasi:

- a. **Data Pengkajian:**
 - Informasi tentang keyakinan spiritual pasien, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia.
 - Hasil pengkajian menggunakan alat seperti FICA atau HOPE.
- b. **Rencana Intervensi:**

- Langkah-langkah intervensi yang telah dirancang berdasarkan kebutuhan pasien.

c. **Implementasi:**

- Detail tentang bagaimana intervensi dilakukan, termasuk siapa yang terlibat (misalnya, keluarga atau tokoh agama).

d. **Evaluasi:**

- Respon pasien terhadap intervensi, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual.
- Catatan tentang perubahan kebutuhan atau saran untuk penyesuaian rencana.

3. Contoh Dokumentasi:

a. **Tanggal:** 25 Januari 2025

b. **Pengkajian:**

Pasien merasa cemas tentang akhir hidupnya dan kehilangan hubungan dengan komunitas agamanya. Pasien menyatakan ingin berbicara dengan seorang pendeta.

c. **Intervensi:** Menghubungi pendeta sesuai permintaan pasien, menyediakan ruang tenang untuk diskusi, dan menemani pasien selama sesi berlangsung.

d. **Evaluasi:** Pasien melaporkan merasa lebih tenang dan mendapatkan penghiburan dari diskusi spiritual. Tidak ada tanda kecemasan yang signifikan setelah sesi.

4. Pedoman Dokumentasi yang Efektif:

a. **Objektif:** Hindari penilaian subjektif; catat fakta dan respon pasien.

b. **Kelengkapan:** Sertakan semua detail yang relevan, mulai dari pengkajian hingga evaluasi.

c. **Konsistensi:** Gunakan format standar yang diterapkan di fasilitas kesehatan.

d. **Kerahasiaan:** Pastikan dokumentasi dilakukan dengan menjaga privasi pasien sesuai dengan kode etik keperawatan (Best et al., 2023)

5. Manfaat Dokumentasi yang Baik:

a. Memudahkan koordinasi antarprofesi dalam memberikan perawatan.

- Menjadi bahan referensi untuk pelatihan atau penelitian terkait perawatan berbasis spiritual.
- Memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika dalam praktik keperawatan (Chahrour et al., 2021).

H. Latihan

Latihan Soal Pilihan Ganda:

1. Seorang pasien laki-laki berusia 68 tahun dengan kanker stadium akhir mengalami kecemasan yang meningkat. Ia merasa takut menghadapi kematian dan sering bertanya kepada perawat tentang makna hidupnya. Perawat menggunakan pendekatan spiritual untuk membantu pasien menghadapi situasi ini.

Intervensi apakah **yang paling tepat** untuk dilakukan oleh perawat?

- A. Memberikan sedasi ringan agar pasien bisa beristirahat dengan tenang
 - B. Menghindari pembicaraan mengenai kematian agar pasien tidak semakin cemas
 - C. Memfasilitasi pasien untuk berbicara dengan pemuka agama atau konselor spiritual
 - D. Menyarankan pasien untuk fokus pada kondisi medisnya saja
 - E. Mengarahkan pasien untuk menerima kenyataan tanpa membahas aspek spiritualnya
2. Seorang perempuan berusia 55 tahun yang menjalani perawatan paliatif untuk kanker ovarium mengatakan kepada perawat bahwa ia merasa kehilangan harapan dan tidak memiliki tujuan lagi. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai kehidupan setelah kematian.

Apa **diagnosa keperawatan yang paling tepat** untuk kondisi pasien ini?

- A. Distress spiritual
 - B. Risiko gangguan pola tidur
 - C. Defisit perawatan diri
 - D. Ansietas ringan
 - E. Gangguan proses berpikir
3. Pasien laki-laki 70 tahun yang menjalani perawatan paliatif mengatakan bahwa selama ini ia adalah orang yang religius, tetapi kini merasa ditinggalkan oleh Tuhan karena sakit yang dideritanya.

Apa tindakan **yang paling sesuai** yang dapat dilakukan oleh perawat?

- A. Mengajak pasien untuk lebih banyak membaca buku agama agar tidak merasa ditinggalkan
- B. Menghubungkan pasien dengan tokoh agama atau konselor spiritual jika pasien menginginkannya
- C. Memberitahu pasien bahwa penyakit adalah ujian dari Tuhan dan ia harus menerimanya dengan sabar

- D. Mengalihkan pembicaraan agar pasien tidak terus memikirkan hal tersebut
Menghentikan diskusi spiritual agar pasien fokus pada aspek medis pengobatan
4. Seorang pasien lanjut usia dengan penyakit gagal jantung kronis sering mengeluh merasa kesepian dan tidak memiliki siapa pun untuk berbagi cerita. Ia menunjukkan tanda-tanda depresi dan menarik diri dari interaksi sosial. Apa intervensi keperawatan **yang paling tepat** untuk mendukung aspek spiritual pasien ini?
- A. Menganjurkan pasien untuk lebih sering beristirahat dan mengurangi interaksi dengan orang lain
 - B. Mengatur sesi refleksi diri agar pasien dapat mencari makna dari kehidupannya
 - C. Mengajarkan pasien untuk tidak bergantung pada orang lain dalam menghadapi masalah
 - D. Mengalihkan pembicaraan ke aspek medis untuk mengurangi rasa sedih pasien
 - E. Memberikan penguatan bahwa kondisi yang dialami pasien adalah hal yang wajar pada usia tua
5. Pasien perempuan berusia 60 tahun yang menjalani perawatan paliatif mengungkapkan bahwa ia ingin menjalankan ritual keagamaannya sebelum kondisinya memburuk. Namun, ia mengalami keterbatasan fisik yang membuatnya sulit melakukan ibadah seperti biasa. Apa yang dapat dilakukan oleh perawat untuk **mendukung kebutuhan spiritual** pasien?
- A. Meminta pasien untuk beristirahat saja karena ibadah bisa dilakukan nanti
 - B. Menghubungi keluarga atau tokoh agama untuk membantu pasien melaksanakan ibadah
 - C. Menyarankan pasien untuk mengganti ibadahnya dengan aktivitas lain yang lebih ringan
 - D. Mengajarkan pasien untuk menerima kenyataan bahwa ia mungkin tidak bisa beribadah lagi
 - E. Menyarankan pasien untuk fokus pada pemulihan fisiknya terlebih dahulu
6. Seorang pasien yang baru didiagnosis dengan penyakit terminal merasa kehilangan harapan dan berkata kepada perawat bahwa hidupnya tidak lagi berarti. Apa **tindakan pertama** yang dapat dilakukan perawat dalam memberikan dukungan spiritual kepada pasien ini?

- A. Menyediakan waktu bagi pasien untuk berbicara tentang perasaannya dan mendengarkannya dengan empati
 - B. Mengajak pasien untuk segera berdamai dengan kenyataan agar ia tidak semakin terpuruk
 - C. Memberikan motivasi dengan mengatakan bahwa selalu ada harapan dalam setiap kondisi
 - D. Mengalihkan pembicaraan ke aspek medis untuk menghindari topik yang sulit
 - E. Meminta keluarga pasien untuk lebih sering mengunjunginya
7. Seorang pasien yang menjalani perawatan paliatif mengalami peningkatan kecemasan saat mendekati akhir hayatnya. Ia mengungkapkan bahwa ia takut terhadap kematian dan apa yang akan terjadi setelahnya.
Pendekatan apa **yang paling tepat** yang dapat dilakukan oleh perawat?
- A. Memberikan penjelasan bahwa kematian adalah proses alami yang tidak perlu ditakuti
 - B. Mendorong pasien untuk mengabaikan ketakutannya dan fokus pada hal lain
 - C. Memfasilitasi diskusi dengan pasien mengenai keyakinannya dan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan spiritualnya
 - D. Menyarankan pasien untuk berbicara dengan keluarganya tentang masalah ini
 - E. Memberikan obat penenang untuk mengurangi kecemasan pasien
8. Seorang pasien yang sedang menjalani terapi paliatif mengungkapkan bahwa ia ingin meminta maaf kepada keluarganya sebelum meninggal, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya.
Bagaimana perawat dapat membantu pasien dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya?
- A. Menyarankan pasien untuk menulis surat atau berbicara langsung kepada keluarganya
 - B. Mengalihkan pembicaraan ke aspek medis agar pasien tidak semakin cemas
 - C. Mengatakan kepada pasien bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk meminta maaf
 - D. Menyarankan pasien untuk fokus pada kesehatannya saja tanpa perlu membahas masalah masa lalu
 - E. Meminta keluarga pasien untuk memahami perasaan pasien tanpa harus berbicara langsung
9. Pasien dengan kanker stadium lanjut mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengan seseorang yang memahami perasaan dan keyakinannya dalam menghadapi akhir hayatnya.

Apa **tindakan yang paling sesuai** yang dapat dilakukan oleh perawat?

- A. Menghubungkan pasien dengan tokoh agama atau konselor spiritual yang sesuai dengan keyakinannya
- B. Menyarankan pasien untuk tidak terlalu banyak berpikir agar tidak semakin stres
- C. Mengalihkan perhatian pasien dengan aktivitas lain agar ia tidak memikirkan kematian
- D. Memberikan buku bacaan tentang kehidupan setelah mati agar pasien lebih tenang
- E. Memberikan pernyataan bahwa semua orang pada akhirnya akan menghadapi kematian

10. Pasien lansia yang menjalani perawatan paliatif menunjukkan penurunan motivasi untuk menjalani hari-harinya. Ia tidak memiliki harapan lagi dan merasa tidak berharga.

Apa intervensi **yang paling tepat** untuk mendukung kesejahteraan spiritual pasien?

- A. Mengajak pasien untuk berbicara tentang hal-hal yang membuatnya bahagia di masa lalu
- B. Memberitahu pasien bahwa perasaan tersebut adalah hal yang wajar di akhir kehidupan
- C. Menyarankan pasien untuk lebih banyak beristirahat dan mengurangi interaksi sosial
- D. Menyatakan bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan dan tidak perlu dikhawatirkan
- E. Mengingatkan pasien bahwa semua orang memiliki waktu yang terbatas di dunia

Latihan Kasus:

1. Kasus 1: Distress Spiritual pada Pasien Terminal

Skenario:

Seorang pria berusia 68 tahun didiagnosis dengan kanker paru stadium akhir dan sedang menjalani perawatan paliatif di rumah sakit. Sejak mengetahui kondisinya tidak dapat disembuhkan, pasien mengalami kecemasan dan merasa putus asa. Ia sering bertanya kepada perawat, "Mengapa saya harus mengalami ini?" dan "Apa yang akan terjadi setelah saya meninggal?". Ia juga menolak berbicara dengan keluarga dan menunjukkan tanda-tanda depresi.

Tugas Mahasiswa:

- A. Identifikasi masalah spiritual yang dihadapi oleh pasien.

- B. Jelaskan bagaimana perawat dapat mengidentifikasi distress spiritual pada pasien paliatif.
- C. Rancang rencana intervensi keperawatan untuk membantu pasien menghadapi kecemasan terkait akhir hidupnya.
- D. Berikan contoh teknik komunikasi terapeutik yang dapat digunakan dalam situasi ini.
- E. Jelaskan bagaimana evaluasi keberhasilan intervensi spiritual dilakukan.

2. Kasus 2: Kebutuhan Ibadah pada Pasien dengan Keterbatasan Fisik

Skenario:

Seorang wanita berusia 72 tahun dengan gagal ginjal terminal sedang menjalani perawatan paliatif di rumah. Ia adalah seorang yang religius dan ingin tetap melaksanakan ibadah hariannya. Namun, karena kondisi fisiknya yang semakin melemah, ia merasa sulit untuk melakukan ibadah seperti biasanya. Pasien mengungkapkan kesedihannya kepada perawat, "Saya merasa bersalah karena tidak bisa lagi melakukan ibadah seperti dulu."

Tugas Mahasiswa:

- A. Identifikasi kebutuhan spiritual pasien dalam situasi ini.
- B. Jelaskan bagaimana perawat dapat membantu pasien memenuhi kebutuhan ibadahnya.
- C. Buat rencana intervensi yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan spiritual pasien tanpa memperburuk kondisi fisiknya.
- D. Bagaimana peran keluarga dalam mendukung kebutuhan spiritual pasien? Berikan strategi keterlibatan keluarga.
- E. Susun evaluasi keberhasilan dari intervensi yang telah dilakukan.

3. Kasus 3: Pasien dengan Rasa Bersalah di Akhir Hidup

Skenario:

Seorang pria berusia 60 tahun dengan sirosis hati stadium akhir dirawat di rumah sakit dalam kondisi paliatif. Ia sering menangis dan menyatakan penyesalan atas banyak hal dalam hidupnya, terutama karena merasa tidak cukup baik terhadap keluarganya di masa lalu. Ia berkata kepada perawat, "Saya ingin meminta maaf, tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya takut keluarga saya tidak akan memaafkan saya."

Tugas Mahasiswa:

- A. Identifikasi masalah spiritual yang dialami pasien.
- B. Jelaskan pendekatan komunikasi terapeutik yang dapat digunakan untuk membantu pasien mengungkapkan perasaannya.
- C. Rancang intervensi keperawatan yang dapat membantu pasien dalam menyelesaikan konflik batinnya sebelum akhir hayatnya.

- D. Diskusikan bagaimana perawat dapat memfasilitasi rekonsiliasi pasien dengan keluarganya.
- E. Jelaskan metode evaluasi keberhasilan intervensi dalam membantu pasien mencapai kedamaian spiritual.

4. Kasus 4: Kesepian dan Kebutuhan Dukungan Sosial

Skenario:

Seorang wanita berusia 75 tahun dengan penyakit Alzheimer tahap lanjut menjalani perawatan paliatif di panti jompo. Ia tidak memiliki keluarga dekat yang sering mengunjunginya dan terlihat sering duduk sendirian tanpa banyak berinteraksi. Perawat yang bertugas memperhatikan bahwa pasien sering berbicara sendiri dan tampak gelisah di malam hari.

Tugas Mahasiswa:

- A. Identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesepian pada pasien paliatif.
- B. Jelaskan dampak kesepian terhadap kesejahteraan spiritual pasien.
- C. Rancang strategi intervensi keperawatan untuk meningkatkan dukungan sosial dan kesejahteraan spiritual pasien.
- D. Bagaimana perawat dapat mengoptimalkan peran komunitas atau relawan dalam mendukung pasien yang kesepian?
- E. Tentukan indikator keberhasilan dari intervensi yang telah diberikan.

5. Kasus 5: Pasien dengan Ketakutan Menghadapi Kematian

Skenario:

Seorang pria berusia 66 tahun dengan gagal jantung kongestif dirawat di rumah sakit untuk perawatan paliatif. Ia menunjukkan tanda-tanda kecemasan berat setiap kali mendengar bahwa kondisinya semakin memburuk. Ia sering mengatakan kepada perawat, "Saya takut mati. Apa yang akan terjadi kepada saya nanti?" Pasien juga mengalami gangguan tidur akibat kekhawatiran yang berlebihan.

Tugas Mahasiswa:

- A. Identifikasi tanda dan gejala ketakutan menghadapi kematian pada pasien paliatif.
- B. Jelaskan strategi komunikasi yang dapat membantu pasien mengelola ketakutannya.
- C. Susun intervensi keperawatan berbasis spiritual untuk membantu pasien menghadapi ketakutan menjelang akhir hidupnya.
- D. Bagaimana perawat dapat bekerja sama dengan keluarga dan tenaga spiritual dalam situasi ini?

- E. Tentukan metode evaluasi untuk menilai apakah pasien mengalami penurunan kecemasan setelah intervensi spiritual dilakukan

Kunci Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda

1. **Jawaban: C** - Memfasilitasi pasien untuk berbicara dengan pemuka agama atau konselor spiritual

Pembahasan:

Pasien yang mengalami kecemasan tentang kematian sering kali memerlukan dukungan spiritual untuk menemukan makna dalam hidup dan menerima kondisinya. Memfasilitasi pasien untuk berbicara dengan pemuka agama atau konselor spiritual dapat membantu mengatasi kecemasannya dengan memberikan bimbingan yang sesuai dengan keyakinannya. Sedasi (**A**) bukan solusi utama, menghindari pembicaraan (**B**) justru bisa membuat pasien merasa tidak dipahami, dan fokus hanya pada aspek medis (**D, E**) mengabaikan kebutuhan spiritual pasien.

2. **Jawaban: A** - Distress spiritual

Pembahasan:

Distress spiritual terjadi ketika pasien merasa kehilangan harapan dan tujuan hidup, serta mempertanyakan makna hidup dan kehidupan setelah mati. Pasien yang mengalami kondisi ini membutuhkan intervensi spiritual yang sesuai, seperti dukungan emosional, refleksi diri, atau konsultasi dengan pemuka agama. Pilihan lainnya, seperti gangguan pola tidur (**B**) atau defisit perawatan diri (**C**), tidak secara langsung mencerminkan permasalahan utama pasien, sementara ansietas ringan (**D**) dan gangguan proses berpikir (**E**) lebih berkaitan dengan gangguan psikologis daripada spiritual.

3. **Jawaban: B** - Menghubungkan pasien dengan tokoh agama atau konselor spiritual jika pasien menginginkannya

Pembahasan:

Ketika pasien merasa ditinggalkan oleh Tuhan, intervensi terbaik adalah menghubungkan mereka dengan sumber dukungan spiritual yang dapat membantu mereka menemukan kembali makna dan penghiburan. Mengajak pasien membaca buku agama (**A**) atau menyuruh mereka menerima penyakitnya (**C**) dapat membuat pasien merasa tidak didengar. Menghindari diskusi (**D, E**) tidak membantu pasien mengatasi perasaan spiritualnya.

4. **Jawaban: B** - Mengatur sesi refleksi diri agar pasien dapat mencari makna dari kehidupannya

Pembahasan:

Kesepian pada pasien paliatif sering kali memperburuk kondisi emosional dan spiritualnya. Dengan mendorong refleksi diri, pasien dapat menemukan makna dalam kehidupannya dan merasakan keberadaan orang-orang yang peduli padanya. Mengurangi interaksi (**A**), mengajarkan pasien untuk tidak bergantung (**C**), mengalihkan pembicaraan (**D**), atau mengatakan bahwa kesepian adalah hal wajar (**E**) bukanlah solusi yang mendukung kesejahteraan spiritual pasien.

5. **Jawaban: B** - Menghubungi keluarga atau tokoh agama untuk membantu pasien melaksanakan ibadah

Pembahasan:

Ketika pasien memiliki keterbatasan fisik dalam menjalankan ritual keagamaan, perawat harus mencari cara agar pasien tetap dapat memenuhi kebutuhannya. Menghubungi keluarga atau pemuka agama dapat menjadi solusi agar pasien tetap dapat beribadah. Meminta pasien untuk menunda ibadah (**A**) atau mengabaikannya (**C, D, E**) tidak memperhatikan aspek spiritual pasien, yang justru dapat memperburuk kondisi emosionalnya.

6. **Jawaban: A** - Menyediakan waktu bagi pasien untuk berbicara tentang perasaannya dan mendengarkannya dengan empati

Pembahasan:

Pasien yang baru didiagnosis dengan penyakit terminal sering mengalami kebingungan dan kehilangan harapan. Langkah pertama yang paling efektif adalah mendengarkan pasien dengan empati dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengungkapkan perasaannya. Mengajak pasien berdamai (**B**) tanpa membiarkan mereka mengekspresikan perasaan dapat terasa memaksa, memberikan motivasi tanpa mendengarkan (**C**) kurang efektif, sementara mengalihkan pembicaraan (**D**) dan meminta keluarga berkunjung (**E**) tidak menyelesaikan masalah spiritual pasien.

7. **Jawaban: C** - Memfasilitasi diskusi dengan pasien mengenai keyakinannya dan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan spiritualnya

Pembahasan:

Ketakutan terhadap kematian adalah hal yang wajar bagi pasien paliatif. Memfasilitasi diskusi mengenai keyakinan pasien dapat membantu mereka memahami dan menerima kondisi mereka dengan lebih baik. Menjelaskan bahwa kematian adalah hal alami (**A**) atau menyuruh pasien mengabaikan ketakutannya (**B**) tidak membantu mereka mengatasi kecemasan mereka. Menyarankan pasien berbicara dengan keluarga (**D**) atau memberikan obat penenang (**E**) hanya mengatasi kecemasan secara sementara tanpa menyentuh akar permasalahan spiritual.

8. **Jawaban: A** - Menyarankan pasien untuk menulis surat atau berbicara langsung kepada keluarganya

Pembahasan:

Pasien yang ingin meminta maaf sebelum meninggal mengalami kebutuhan spiritual yang mendalam. Menyarankan mereka untuk menulis surat atau berbicara langsung kepada keluarganya dapat membantu mereka merasa lebih tenang. Mengalihkan pembicaraan (**B**) atau mengatakan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan meminta maaf (**C**) justru menghambat pemenuhan kebutuhan spiritual pasien. Fokus hanya pada kesehatan pasien (**D**) atau meminta keluarga memahami perasaan pasien tanpa berbicara langsung (**E**) bukan solusi terbaik.

9. **Jawaban: A** - Menghubungkan pasien dengan tokoh agama atau konselor spiritual yang sesuai dengan keyakinannya

Pembahasan:

Ketika pasien ingin berbicara dengan seseorang yang memahami keyakinannya, perawat sebaiknya memfasilitasi pertemuan dengan pemuka agama atau konselor spiritual. Menyarankan pasien untuk tidak berpikir terlalu banyak (**B**) atau mengalihkan perhatian pasien (**C**) justru mengabaikan kebutuhannya. Memberikan buku bacaan (**D**) tidak selalu menjadi solusi yang efektif, sementara pernyataan bahwa semua orang akan meninggal (**E**) tidak memberikan dukungan emosional maupun spiritual yang dibutuhkan pasien.

10. **Jawaban: A** - Mengajak pasien untuk berbicara tentang hal-hal yang membuatnya bahagia di masa lalu

Pembahasan:

Ketika pasien menunjukkan kehilangan motivasi hidup, salah satu intervensi yang efektif adalah mengajak mereka berbicara tentang pengalaman yang membahagiakan di masa lalu. Hal ini dapat membantu mereka menemukan kembali makna hidupnya. Mengatakan bahwa perasaan ini wajar (**B**) atau menyarankan pasien untuk mengurangi interaksi sosial (**C**) hanya memperburuk kondisi pasien. Mengingatkan pasien bahwa kematian adalah hal alami (**D, E**) tidak memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya.

I. Rangkuman Materi

1. Tinjauan spiritual tentang perawatan paliatif

Perawatan paliatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Fokus utama dari pendekatan ini bukan hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Dalam

konteks ini, spiritualitas memiliki peran penting dalam membantu pasien menghadapi kondisi terminal, memberikan makna dalam kehidupan, serta mendukung mereka dalam menemukan ketenangan batin.

2. Konsep Spiritualitas dalam Perawatan Paliatif

Spiritualitas dalam perawatan paliatif bukan hanya berkaitan dengan agama, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas, seperti makna hidup, hubungan sosial, dan pencarian kedamaian batin. Setiap pasien memiliki pemahaman spiritualitas yang berbeda, tergantung pada nilai-nilai, kepercayaan, serta pengalaman hidup mereka. Beberapa pasien mungkin menemukan ketenangan melalui doa dan ibadah, sementara yang lain merasa lebih nyaman dengan refleksi diri atau dukungan sosial dari keluarga. Peran tenaga kesehatan dalam aspek ini adalah membantu pasien menemukan makna dalam pengalaman hidup mereka dan memberikan dukungan yang sesuai dengan keyakinan masing-masing.

3. Hubungan antara Kebutuhan Spiritual dan Kualitas Hidup Pasien

Kebutuhan spiritual pasien paliatif berkaitan erat dengan kesejahteraan emosional mereka. Ketika kebutuhan spiritual terpenuhi, pasien cenderung lebih mampu menghadapi rasa sakit dan ketidakpastian dengan lebih tenang. Sebaliknya, jika kebutuhan ini diabaikan, pasien dapat mengalami kecemasan, depresi, atau bahkan kehilangan harapan. Oleh karena itu, pendekatan holistik dalam perawatan paliatif harus mempertimbangkan aspek spiritual sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dukungan spiritual yang diberikan kepada pasien tidak hanya memperkuat ketahanan diri mereka dalam menghadapi kondisi terminal tetapi juga memberikan ketenangan bagi keluarga yang mendampingi mereka.

4. Pengkajian Kebutuhan Spiritual Pasien

Untuk memastikan bahwa aspek spiritual pasien terpenuhi, tenaga kesehatan perlu melakukan pengkajian yang mendalam. Pengkajian ini bertujuan untuk memahami keyakinan, nilai, serta harapan pasien dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Beberapa alat yang dapat digunakan dalam proses pengkajian ini adalah metode FICA (Faith, Importance, Community, Address) dan HOPE (Sources of Hope, Organized Religion, Personal Practices, Effects on Medical Care). Melalui wawancara dan observasi, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi kebutuhan spiritual pasien serta memberikan dukungan yang sesuai. Dalam beberapa kasus, kolaborasi dengan pemuka agama atau konselor spiritual juga diperlukan untuk membantu pasien mencapai ketenangan batin.

5. Diagnosa Keperawatan Berbasis Spiritual

Setelah pengkajian dilakukan, tenaga kesehatan dapat menetapkan diagnosa keperawatan berbasis spiritual. Salah satu diagnosa yang sering ditemukan dalam perawatan paliatif adalah distress spiritual, yaitu kondisi di mana pasien mengalami kebingungan, kehilangan makna hidup, atau merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Selain itu, beberapa pasien juga mengalami kebutuhan peningkatan spiritualitas, di mana mereka ingin lebih memperdalam keyakinannya sebagai mekanisme koping. Untuk menangani masalah ini, perawat harus merancang intervensi yang sesuai agar pasien dapat menemukan ketenangan dan mengatasi rasa putus asa.

6. Perencanaan dan Intervensi Berbasis Spiritual

Intervensi keperawatan berbasis spiritual memiliki tujuan utama untuk membantu pasien mencapai ketenangan batin dan menemukan makna dalam hidup mereka. Beberapa bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain adalah memberikan pendampingan spiritual, memfasilitasi praktik keagamaan pasien, serta memberikan kesempatan bagi pasien untuk berbicara tentang perasaan dan harapan mereka. Selain itu, refleksi diri juga menjadi bagian penting dari intervensi spiritual, di mana pasien diajak untuk mengenang perjalanan hidup mereka dan menemukan sisi positif dari pengalaman yang telah mereka lalui. Dalam proses ini, tenaga kesehatan harus menunjukkan empati dan sensitivitas yang tinggi agar pasien merasa didukung secara emosional dan spiritual.

7. Implementasi dan Evaluasi Intervensi Spiritual

Setelah intervensi spiritual diberikan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas intervensi tersebut. Keberhasilan intervensi dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti meningkatnya ketenangan pasien, berkurangnya kecemasan, serta adanya perasaan damai dalam menghadapi kematian. Evaluasi dapat dilakukan melalui observasi langsung terhadap perilaku pasien, wawancara mengenai pengalaman mereka setelah intervensi, serta pencatatan dalam dokumentasi medis. Apabila pasien masih menunjukkan tanda-tanda distress spiritual, maka tenaga kesehatan perlu menyesuaikan kembali intervensi yang diberikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasien.

8. Dokumentasi Intervensi Spiritual

Dokumentasi menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam perawatan spiritual. Setiap pengkajian, rencana intervensi, serta hasil evaluasi harus dicatat dengan jelas agar tim kesehatan lainnya dapat melanjutkan perawatan dengan pendekatan yang konsisten. Dokumentasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan spiritual pasien tetap menjadi bagian dari prioritas dalam perawatan paliatif. Sebagai contoh, catatan medis dapat mencantumkan kebutuhan pasien akan dukungan dari tokoh agama tertentu, respons pasien

terhadap sesi refleksi spiritual, atau perubahan yang dialami pasien setelah mendapatkan intervensi berbasis spiritual. Dengan adanya dokumentasi yang sistematis, perawatan spiritual dapat diberikan secara berkelanjutan dan efektif.

J. Glosarium

Perawatan Paliatif: Pendekatan medis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan melalui manajemen gejala, dukungan psikologis, sosial, dan spiritual.

Spiritualitas: Dimensi manusia yang berkaitan dengan makna hidup, tujuan eksistensial, hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan entitas yang lebih besar seperti Tuhan atau alam semesta.

Kebutuhan Spiritual: Aspek psikososial pasien yang mencakup pencarian makna hidup, harapan, serta koneksi dengan nilai dan keyakinan spiritual yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental.

Diagnosa Keperawatan Berbasis Spiritual: Identifikasi sistematis mengenai kondisi spiritual pasien, termasuk distress spiritual, kebutuhan peningkatan spiritualitas, atau risiko gangguan kesejahteraan spiritual.

Distress Spiritual: Keadaan emosional yang dialami pasien akibat kehilangan makna hidup, kebingungan spiritual, atau konflik keyakinan yang menyebabkan kecemasan atau putus asa.

Intervensi Berbasis Spiritual: Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mendukung kesejahteraan spiritual pasien, seperti pendampingan spiritual, fasilitasi ibadah, refleksi diri, dan konseling spiritual.

Pendampingan Spiritual: Proses pemberian dukungan emosional dan spiritual kepada pasien melalui komunikasi terapeutik, mendengarkan aktif, serta membantu pasien dalam menghadapi tantangan hidupnya.

Refleksi Diri: Proses introspeksi yang dilakukan oleh pasien untuk menemukan makna dalam pengalaman hidupnya, sering kali didukung oleh perawat melalui diskusi atau jurnal spiritual.

Komunikasi Terapeutik: Pendekatan komunikasi yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk membangun hubungan empatik dengan pasien guna membantu mereka mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapan.

FICA: Model pengkajian spiritual yang mencakup:

- **Faith (Keyakinan):** Keyakinan spiritual atau agama pasien.
- **Importance (Kepentingan):** Seberapa penting spiritualitas bagi pasien.
- **Community (Komunitas):** Dukungan sosial atau komunitas keagamaan pasien.
- **Address (Pendekatan):** Cara mengintegrasikan spiritualitas dalam perawatan medis.

HOPE: Alat pengkajian kebutuhan spiritual yang meliputi:

- **Sources of Hope (Sumber Harapan)**
- **Organized Religion (Agama Terorganisir)**
- **Personal Practices (Praktik Pribadi)**
- **Effects on Medical Care (Pengaruh pada Perawatan Medis)**

Person-Centered Care: Pendekatan perawatan yang menempatkan kebutuhan dan preferensi individu pasien sebagai fokus utama dalam pengambilan keputusan medis dan intervensi kesehatan.

Transendensi: Dimensi spiritual yang berhubungan dengan pengalaman melampaui kehidupan material, sering kali terkait dengan keyakinan terhadap Tuhan atau makna yang lebih besar dalam hidup.

Kualitas Hidup: Konsep yang mencakup kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual seseorang dalam menghadapi kondisi medis tertentu.

Kecemasan Eksistensial: Perasaan takut atau cemas yang dialami pasien terkait dengan makna kehidupan, ketidakpastian masa depan, dan proses kematian.

Konseling Spiritual: Proses pendampingan oleh tenaga profesional atau tokoh agama untuk membantu pasien dalam mengatasi masalah spiritual dan mencapai ketenangan batin.

Ritual Keagamaan: Praktik ibadah yang dilakukan oleh pasien sesuai dengan keyakinannya, seperti doa, meditasi, atau pembacaan kitab suci.

Penyediaan Lingkungan yang Mendukung: Upaya tenaga kesehatan dalam menciptakan suasana yang tenang dan nyaman untuk mendukung pemenuhan kebutuhan spiritual pasien.

Evaluasi Intervensi Spiritual: Proses menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual pasien, dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dokumentasi Spiritual: Pencatatan sistematis mengenai pengkajian, rencana intervensi, pelaksanaan, dan evaluasi dukungan spiritual pasien sebagai bagian dari perawatan holistik

K. Daftar Pustaka

-
- Best, M., Vivat, B., & Gijsberts, M. (2023). Spiritual Care in Palliative Care. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel14030320>.
- Goswami, S. (2016). Making Health Care Whole: Integrating Spirituality into Health Care. *Journal of psychosocial research*, 11, 507.
- Nissen, R., Viftrup, D., & Hvidt, N. (2021). The Process of Spiritual Care. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.674453>.
- Chahrour, W., Hvidt, N., Hvidt, E., & Viftrup, D. (2021). Learning to care for the spirit

- of dying patients: the impact of spiritual care training in a hospice-setting. *BMC Palliative Care*, 20. <https://doi.org/10.1186/s12904-021-00804-4>.
- Wong, J., Blake, C., Swami, N., Pope, A., Hannon, B., Rodin, G., Le, L., & Zimmermann, C. (2019). Understanding of palliative care among members of the public.. *Journal of Clinical Oncology*. https://doi.org/10.1200/jco.2019.37.31_suppl.71.
- Fopka-Kowalczyk, M., Machul, M., & Dobrowolska, B. (2022). Research Protocol of the Polish Adaptation and Validation of HOPE Scale: Qualitative Measurement of Patients' Spiritual Needs.. *Journal of palliative medicine*. <https://doi.org/10.1089/jpm.2021.0530>.

BAB 5

MANAJEMEN NYERI

Tujuan Intruksional:

Tujuan intruksional pada materi ini yaitu:

1. Menjelaskan pengertian nyeri
2. Menjelaskan klasifikasi nyeri
3. Menjelaskan nyeri pada pasien paliatif
4. Menjelaskan manajemen farmakologi nyeri
5. Menjelaskan manajemen non farmakologi nyeri

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pengertian nyeri
2. Menjelaskan klasifikasi nyeri
3. Menjelaskan nyeri pada pasien paliatif
4. Menjelaskan manajemen farmakologi nyeri
5. Menjelaskan manajemen non farmakologi nyeri

Pendahuluan:

Nyeri merupakan sumber utama ketakutan dalam perawatan akhir hayat. Penanganan nyeri pada pasien paliatif menjadi tantangan dengan prioritas tinggi bagi para profesional dalam perawatan paliatif. Pada tinjauan sistematis dan meta analisis mengenai prevalensi nyeri pada pasien paliatif menyimpulkan belum ada kemajuan besar yang dicapai dalam pengelolaan nyeri dalam 50 tahun terakhir, sehingga pedoman penanganan nyeri pada pasien paliatif sangat dibutuhkan karena mempengaruhi dalam mengelola pasien.

Nyeri merupakan salah satu gejala yang sering dijumpai pada pasien paliatif. Nyeri dapat disebabkan adanya metastasis, prosedur tindakan diagnostik dan komplikasi terapi. Nyeri pada pasien dengan keganasan disebabkan karena massa tumor yang bertambah besar akan menekan saraf, tulang dan organ lain yang ada di sekitarnya. Persepsi nyeri pada setiap individu bersifat kompleks dan dikendalikan oleh berbagai variabel. Penatalaksanaan nyeri merupakan salah satu bagian dari perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas hidup pasien, menghilangkan gejala melalui identifikasi dini dan pengkajian secara komprehensif. Perawatan paliatif dapat diberikan saat awal mulai di diagnosis penyakit pada pasien. Penanganan nyeri yang adekuat dan efektif memberikan pasien merasa nyaman sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien, mobilisasi lebih dini, pemulihan lebih cepat dan akan mengurangi biaya perawatan.

Materi mengenai konsep manajemen nyeri dalam perawatan paliatif ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen nyeri dalam perawatan paliatif sehingga dapat menerapkan secara nyata pada asuhan keperawatan pada pasien paliatif. Materi ini ditujukan kepada mahasiswa keperawatan dan perawat yang melakukan perawatan paliatif pada pasien paliatif agar dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai manajemen nyeri dalam perawatan paliatif.

A. Definisi Nyeri

Nyeri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang dirasakan tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan yang nyata atau potensial (WHO, 2020; Mahmud et al, 2023). Nyeri merupakan gejala atau keluhan yang paling sering ditakuti pada pasien paliatif. Tingkat keparahan nyeri seringkali tidak berkorelasi dengan sifat atau derajat cedera jaringan. Nyeri merupakan persepsi bersifat individual mengenai fenomena yang mencakup proses psikologis dan emosional serta impuls nosiseptif dan non-nosiseptif yang terhubung dengan penurunan sistem aktivasi penghambat nyeri (Inchingolo et al, 2024).

Suwondo, Meliala, Sudadi (2017) menyatakan nyeri adalah rasa tidak menyenangkan disebabkan karena adanya perlukaan dalam tubuh. Nyeri juga dianggap sebagai racun dalam tubuh karena terjadi akibat adanya kerusakan jaringan atau saraf dari berbagai mediator nyeri. Nyeri dapat berperan sebagai penunjang diagnostik karena dengan adanya nyeri pada daerah tertentu, pasien dapat mengetahui proses yang terjadi, contohnya : nyeri yang dirasakan oleh seseorang pada daerah perut kanan bawah, kemungkinan pasien menderita radang usus buntu. Nyeri juga sebagai mekanisme proteksi, sensasi nyeri memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu trauma atau penyebab nyeri sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan jaringan tubuh (Sudarsa, 2020).

B. Klasifikasi Nyeri

Bauldoff & Priscilla (2019) menyatakan bahwa nyeri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan pada tempat, sifat, berat ringannya nyeri, dan waktu lamanya serangan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nyeri berdasarkan tempatnya:
 - a. *Pheriperal pain*, yaitu nyeri yang terasa pada permukaan tubuh misalnya pada kulit, mukosa.
 - b. *Deep pain*, yaitu nyeri yang tersa pada permukaan tubuh yang lebih dalam atau pada organ-organ tubuh visceral.
 - c. *Referred pain*, yaitu nyeri dalam yang disebabkan karena penyakit organ/struktur dalam tubuh yang ditransmisikan ke bagian tubuh di daerah yang berbeda, bukan daerah asal nyeri.
 - d. *Central pain*, yaitu nyeri yang terjadi karena pemasangan pada sistem saraf pusat, spinal cord, batang otak, talamus.
2. Nyeri berdasarkan sifatnya :

- a. *Incedental pain*, yaitu nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu menghilang.
 - b. *Steady pain*, yaitu nyeri yang timbul akan menetap serta dirasakan dalam waktu yang lama.
 - c. *Paroxymal pain*, yaitu nyeri yang dirasakan berintensitas tinggi dan kuat sekali. Nyeri tersebut biasanya menetap $\pm 10-15$ menit, lalu menghilang, kemudian timbul lagi.
3. Nyeri berdasarkan berat ringannya :
 - a. Nyeri ringan, yaitu nyeri dengan intensitas rendah.
 - b. Nyeri sedang, yaitu nyeri yang menimbulkan reaksi.
 - c. Nyeri berat, yaitu nyeri dengan intensitas yang tinggi.
 4. Nyeri berdasarkan waktu lamanya serangan :
 - a. Nyeri akut, yaitu nyeri yang dirasakan dalam waktu yang singkat dan berakhir kurang dari enam bulan, sumber dan daerah nyeri diketahui dengan jelas.
 - b. Nyeri kronis, yaitu nyeri yang dirasakan lebih dari enam bulan. Nyeri kronis ini polanya beragam dan berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

C. Pengkajian Nyeri

Ferrell (2008) menyatakan pengkajian nyeri dasar merupakan tugas sederhana namun sering terlewatkan dalam perawatan kesehatan. Banyak penelitian menyimpulkan bahwa kegagalan penyedia layanan kesehatan untuk mengkaji nyeri dan kemudian menerima dan menindaklanjuti laporan nyeri pasien merupakan penyebab paling umum nyeri yang tidak kunjung reda dan penderitaan yang tidak perlu.

Pengkajian nyeri merupakan fondasi yang mendasari pengobatan nyeri. Pengkajian nyeri dilakukan secara komprehensif, multidimensi berdasarkan laporan pasien sendiri karena nyeri bersifat kompleks dan memiliki hambatan sehingga praktis digunakan. Program perawatan paliatif Hospice telah mengadopsi format OPQRSTUV untuk memandu penyedia layanan dalam mengumpulkan informasi relevan secara sistematis saat melakukan pengkajian nyeri.

Tabel 5.1: Pengkajian nyeri menggunakan OPQRSTUV:

O	Onset	Kapan nyeri tersebut mulai? Berapa lama nyeri tersebut berlangsung? Seberapa sering nyeri tersebut terjadi? Tanyakan kepada pasien tentang awal mula nyeri. Apakah nyeri tersebut baru, nyeri yang sudah berlangsung lama, atau nyeri lama yang telah berubah? Tanyakan tentang frekuensinya (intermiten atau
---	-------	--

		persisten). Variasi dan ritme nyeri membantu mengidentifikasi jenis nyeri yang dialami pasien
P	Provoking/Palliating	Apa yang meredakan atau memperparah rasa sakit? Jika pasien telah merasakan sakit dalam jangka waktu yang lama, mereka mungkin tahu obat/perawatan apa yang telah membantu di masa lalu. Pasien juga akan tahu apa yang memperparah rasa sakit. Rasa sakit parah yang terputus-putus yang berhubungan dengan suatu aktivitas. Rasa sakit mereda ketika aktivitas berhenti = rasa sakit insidental yang mungkin memerlukan penggunaan opioid kerja pendek dan modifikasi aktivitas
Q	Quality	Minta pasien untuk menggambarkan rasa sakitnya dengan kata-kata mereka sendiri-ingatlah untuk tidak mengatakan kata-kata yang tidak jelas. Kualifikasi atau deskripsi rasa sakit membantu meningkatkan pemahaman kita tentang jenis rasa sakit yang dialami pasien serta kemungkinan penyebab yang mendasari rasa sakit dan memiliki implikasi langsung pada jenis perawatan yang dibutuhkan. Misalnya, rasa sakit yang digambarkan seperti terbakar, tertusuk, "kesemutan" biasanya bersifat neuropatik
R	Region/Radition	Dimana letak nyeri dan apakah nyeri berpindah ke tempat lain? Hal ini dapat dilakukan dengan meminta pasien menandai lokasi nyeri menggunakan peta tubuh atau menunjuk area tubuhnya. Jika nyeri terdapat lebih dari satu, huruf dapat digunakan untuk membedakan lokasi yang berbeda. Anak panah juga dapat digunakan untuk menunjukkan nyeri yang menjalar. Menentukan lokasi nyeri secara tepat membantu menentukan jenis dan sifat nyeri yang dialami pasien. Misalnya, nyeri yang tidak terlokalisasi dengan baik dan dalam mungkin bersifat visceral
S	Severity	Minta pasien untuk menilai rasa sakit mereka menggunakan skala nyeri. Ada banyak skala termasuk kata-kata deskriptif, warna, angka dan wajah. Penilaian harus dari 0 (tidak nyeri) hingga 10 (nyeri terburuk yang dapat dibayangkan). Gunakan skala yang paling tepat untuk individu tersebut. Minta pasien menilai intensitas nyeri untuk nyeri saat ini, nyeri terburuk, nyeri terbaik, dan tingkat nyeri yang dapat diterima

	Symptoms	(tujuan mereka). Penilaian nyeri awal membantu menentukan pengobatan dengan mengklasifikasikan nyeri sebagai nyeri ringan 1-3/10, sedang 4-7/10, atau berat 8-10/10. Setelah pengobatan dimulai, penilaian nyeri yang berkelanjutan membantu pasien dan pengasuh melacak dan mengevaluasi efektivitas pengobatan Tanyakan apakah ada gejala lain yang menyertai nyeri? Misal mual, dispnea
T	Treatment	Tanyakan kepada pasien berobat/perawatan apa yang telah dicoba dimasa lalu-apa yang berhasil dan apa yang tidak? Obat/perawatan apa yang sedang mereka gunakan saat ini? Dosis, rute? Apakah obat/perawatan tersebut berhasil? Mengetahui apa yang telah dicoba di masa lalu mempercepat pengambilan keputusan tentang cara mengobati nyeri saat ini
U	Understanding	Bagaimana pemahaman/persepsi pasien terhadap nyeri. Ingat semua faktor nyeri total – intelektual, emosional, interpersonal, finansial, spiritual, birokrasi, dan fisik. Bagaimana tingkat pengetahuan, sistem kepercayaan, pandangan pasien terhadap dirinya sendiri? Apa yang pasien rasakan sebagai penyebab nyeri? Apa strategi penanganan yang biasa yang dilakukan individu/keluarga? Bagaimana nyeri mempengaruhi kehidupan sehari-hari? Tanyakan apa yang dapat kami lakukan untuk membantu anda mengatasi nyeri?
V	Values	Apa tujuan anda untuk gejala ini? Apa tujuan kenyamanan atau tingkat yang dapat diterima untuk gejala ini (pada skala 0-10 dengan 0 berarti tidak ada dan 10 berarti kemungkinan terburuk)? Apakah ada pandangan atau perasaan lain tentang gejala ini yang penting bagi anda atau keluarga anda ?

D. Manajemen Farmakologi Nyeri

World Health Organization (WHO) analgesic ladder mengusungkan untuk memberikan pereda nyeri bagi pasien kanker. WHO analgesic ladder adalah bagian dari program perawatan paliatif dan nyeri kanker WHO bertujuan untuk meningkatkan strategi manajemen nyeri kanker melalui kampanye edukasi,

menciptakan strategi bersama, dan mengembangkan jaringan dukungan global. WHO analgesic ladder memberikan strategi pendekatan paliatif yang sederhana untuk mengurangi morbiditas terkait nyeri sekitar 70%-80% pasien. Ada tiga langkah yang dilakukan yaitu:

1. Nyeri ringan: analgesik non-opioid seperti obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) atau asetaminofen dengan atau tanpa adjuvan
2. Nyeri Sedang: opioid lemah (hidrokodon, kodein, tramadol) dengan atau tanpa analgesik non-opioid dan dengan atau tanpa adjuvan
3. Nyeri berat dan terus-menerus: opioid poten (morfin, metadon, fentanil, oksikodon, buprenorfin, tapentadol, Hidromorfon, oksimorfon) dengan atau tanpa analgesik non-opioid, dan dengan atau tanpa adjuvan.

Adjuvan mengacu pada sekumpulan besar obat yang termasuk dalam kelas yang berbeda

E. Manajemen Non Farmakologi Nyeri

Manajemen nyeri merupakan aktivitas keperawatan yang terdiri dari komponen dasar proses keperawatan : pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi bagi pasien yang mengalami nyeri. Manajemen nyeri mencakup pengkajian dan pemberian bantuan yang tepat bagi pasien yang mengalami nyeri. Perawat merupakan profesional yang lebih dekat dengan pasien dibandingkan dengan profesional lainnya dan mencurahkan sebagian besar waktu untuk merawat pasien. Perawat memainkan peran penting dan memiliki tanggung jawab untuk mengkaji dan mengelola nyeri pasien. Manajemen nyeri non farmakologi tidak menggantikan farmakologi tetapi melengkapi pengobatan. Strategi manajemen non farmakologi bermanfaat untuk mengelola nyeri ringan hingga sedang. Manajemen non farmakologi digunakan bersama dengan farmakologi untuk mengendalikan nyeri intensitas sedang hingga tinggi dan manajemen non farmakologi sendiri dapat digunakan pada intensitas rendah (Tsegaye et al, 2023).

Ada berbagai praktik manajemen non farmakologi nyeri yang dapat diterapkan perawat dalam menangani nyeri. Metode fisik seperti massage, pembatasan gerakan/istirahat, reposisi, dan aplikasi dingin dan panas memiliki efek penghilang rasa sakit yang penting. Terapi perilaku kognitif dan psikologis meliputi relaksasi, edukasi pasien, teknik pernapasan, dan distraksi perhatian adalah praktik manajemen non farmakologi nyeri yang penting. Praktek non farmakologi nyeri lainnya meliputi dukungan/keyakinan emosional, sentuhan, dan menciptakan lingkungan yang nyaman. Manajemen non farmakologi nyeri penting karena dapat meningkatkan kenyamanan dan dapat digunakan pasien untuk mengendalikan rasa

sakit jika pasien diberikan informasi atau edikasu yang tepat. Metode ini juga memiliki keunggulan dibandingkan pengobatan konvensional nyeri yang menangani aspek kognitif, afektid, dan sosial budaya (Tsegaye et al, 2023).

F. Latihan

Latihan dibuat dalam bentuk Pilihan Ganda dan Essay sebagai berikut:

Pilihan Ganda

1. Tanda dan gejala nyeri akut kecuali?'
 - A. Sulit tidur
 - B. Frekuensi nadi meningkat
 - C. Tidak mampu menuntaskan aktivitas
 - D. Bersikap protektif
 - E. Gelisah
2. Nyeri neuropatik adalah jenis nyeri yang disebabkan oleh gangguan primer pada sistem saraf tepi adalah?'
 - A. Nyeri neurogenik
 - B. Nyeri Nosisseptif
 - C. Nyeri akut
 - D. Nyeri kronis
 - E. Nyeri maligna
3. Biasanya nyeri terjadi karena berkembangnya penyakit yang dapat mengancam jiwa atau berkaitan dengan terapi. Misalnya nyeri kanker?'
 - A. Nyeri neurogenik
 - B. Nyeri Nosisseptif
 - C. Nyeri akut
 - D. Nyeri kronis
 - E. Nyeri maligna
4. Informasi tentang sumber nyeri dan pengobatan yang dapat meringankan dan meningkatkan nyeri adalah?'
 - A. Provocates/palliates
 - B. Quality
 - C. Region
 - D. Severity
 - E. Time
5. Mengkaji lokasi nyeri yang dirasakan pasien serta arah penyebaran nyeri yang dirasakan. Untuk melokalisasikan nyeri lebih spesifik, perawat dapat melacak daerah nyeri dari titik yang paling nyeri ?'
 - A. Provocates/palliates

- B. Quality
- C. Region
- D. Severity
- E. Time

Essay

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nyeri?
2. Jelaskan penyebab nyeri?
3. Jelaskan pengkajian nyeri?
4. Jelaskan manajemen farmakologi nyeri?
5. Jelaskan manajemen non farmakologi nyeri?

Kunci Jawaban

1. C
2. E
3. A
4. C
5. C

G. Rangkuman Materi

Nyeri merupakan gejala atau keluhan yang paling sering ditakuti pada pasien paliatif. Tingkat keparahan nyeri seringkali tidak berkorelasi dengan sifat atau derajat cedera jaringan. Nyeri merupakan persepsi bersifat individual mengenai fenomena yang mencakup proses psikologis dan emosional serta impuls nosiseptif dan non-nosiseptif yang terhubung dengan penurunan sistem aktivasi penghambat nyeri. Ada berbagai praktik manajemen non farmakologi nyeri yang dapat diterapkan perawat dalam menangani nyeri.

H. Glosarium

WHO : World Health Organization

NSAID : Non Steroid Anti Inflammatory Drugs

I. Daftar Pustaka

Bauldoff, Gerene LeMone, Priscilla., Burke, & Karen. M., (2019). Buku Ajar. Keperawatan Medikal Bedah. Jakarta: EGC

Ferrell, Betty.(2008).Pain Assessment in Palliative Care. Northern Health : Regional Palliative Care Services

- Inchingolo, A. M., Dipalma, G., Inchingolo, A. D., Palumbo, I., Guglielmo, M., Morolla, R., Mancini, A., & Inchingolo, F. (2024). Advancing Postoperative Pain Management in Oral Cancer Patients: A Systematic Review. *Pharmaceuticals*, 17(4), 542. <https://doi.org/10.3390/ph17040542>
- Mahmud, Sudadi, & Ristianto, M. B. (2023). Manajemen Nyeri pada Pasien Kanker Payudara Stadium Paliatif dengan Cancer Pain. *Jurnal Komplikasi Anestesi*, 10(2), 24-32. <https://doi.org/10.22146/jka.v10i2.8302>
- Sudarsa, I Wayan. (Ed.) (2020). *Perawatan komprehensif paliatif*. Airlangga University Press.
- Suwondo, Bambang S, Meliala L, Sudadi.(2017). Buku Ajar Nyeri. Yogyakarta: Perkumpulan Nyeri Indonesia
- Tsegaye, D., Yazew, A., Gedfew, M., Yilak, G., & Yalew, Z. M. (2023). Non-Pharmacological Pain Management Practice and Associated Factors Among Nurses Working at Comprehensive Specialized Hospitals. *SAGE open nursing*, 9, 23779608231158979. <https://doi.org/10.1177/23779608231158979>
- World Health Organisation. (2020). Guidelines on the management of chronic pain in children. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240017870>

BAB 6

PATOFISIOLOGI BERBAGAI PENYAKIT KRONIK DAN TERMINAL

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu mengaplikasikan prinsip dasar patofisiologi, manajemen, dan terapi paliatif dalam pengelolaan pasien penyakit kronik dan terminal secara profesional, etis, dan humanis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, patofisiologi, serta prinsip pengelolaan penyakit kronik dan terminal, serta mengintegrasikan pendekatan multidisiplin dalam memberikan pelayanan paliatif yang efektif.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan definisi, karakteristik, dan contoh penyakit kronik dan terminal.
2. Menjelaskan mekanisme patofisiologi umum pada penyakit kronik, seperti inflamasi kronik, gangguan metabolisme, serta peran faktor genetik dan epigenetik.
3. Menjelaskan patofisiologi penyakit kronik pada sistem kardiovaskular (gagal jantung kronik) dan sistem respirasi (penyakit paru obstruktif kronik/PPOK).
4. Menguraikan mekanisme progresi dan komplikasi utama pada penyakit terminal dengan fokus pada kanker stadium lanjut.
5. Menguraikan prinsip dan pendekatan manajemen serta terapi paliatif yang komprehensif pada pasien penyakit terminal.
6. Mengidentifikasi aspek-aspek etis dan hukum dalam pengambilan keputusan perawatan akhir kehidupan pasien terminal.

Pendahuluan

Penyakit kronik dan terminal merupakan dua kondisi kesehatan yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan pasien dan keluarganya. Penyakit kronik umumnya

berlangsung dalam waktu lama dengan progresivitas lambat namun pasti, sedangkan penyakit terminal merupakan fase akhir dari suatu penyakit yang ditandai dengan prognosis buruk dan harapan hidup yang sangat terbatas. Keduanya memerlukan pendekatan pengelolaan kesehatan yang komprehensif, melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pemahaman mengenai konsep dasar, mekanisme patofisiologi, serta prinsip pengelolaan kedua jenis penyakit ini menjadi landasan penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal.

A. Konsep Dasar Penyakit Kronik dan Terminal

1. Definisi Penyakit Kronik

Penyakit kronik adalah gangguan kesehatan yang memiliki durasi panjang, secara umum berlangsung lebih dari 3 bulan, bahkan sering kali bertahun-tahun hingga seumur hidup. Penyakit kronik cenderung memiliki progresivitas yang lambat tetapi menetap atau memburuk seiring waktu. Penyakit ini umumnya tidak dapat disembuhkan secara total, tetapi dapat dikendalikan melalui berbagai terapi dan pendekatan manajemen kesehatan yang komprehensif.

Beberapa ciri utama penyakit kronik meliputi:

- **Progresivitas Lambat**

Penyakit ini berkembang secara perlahan, kadang-kadang sulit dideteksi pada tahap awal. Perkembangan gejala biasanya terjadi secara bertahap, mulai dari ringan hingga mencapai tingkat berat atau parah.

- **Durasi Lama**

Penyakit kronik memerlukan perhatian dan manajemen medis yang berkelanjutan. Pasien akan menghadapi kondisi ini sepanjang hidup, dengan masa-masa eksaserbasi (perburukan) dan remisi (stabil atau perbaikan gejala).

- **Tidak Dapat Disembuhkan Total**

Umumnya, penyakit kronik tidak memiliki obat yang sepenuhnya menghilangkan penyakit tersebut, tetapi dapat dikelola agar pasien dapat mencapai kualitas hidup optimal. Fokus pengobatan terletak pada manajemen gejala dan pencegahan komplikasi.

Contoh penyakit kronik yang sering dijumpai antara lain diabetes mellitus, hipertensi, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), gagal ginjal kronik, penyakit jantung kronik, dan artritis reumatoid.

2. Definisi Penyakit Terminal

Penyakit terminal merupakan kondisi medis yang sudah mencapai tahap lanjut atau akhir, ditandai oleh prognosis yang buruk dengan perkiraan harapan hidup yang sangat terbatas, biasanya kurang dari 6 bulan. Pasien dengan penyakit terminal tidak lagi merespons terapi kuratif (penyembuhan total), sehingga pendekatan pengobatan beralih pada tujuan paliatif, yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien dengan cara mengurangi penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Beberapa ciri khas penyakit terminal adalah:

- **Prognosis Buruk**

Penyakit terminal memiliki prognosis yang buruk dengan estimasi harapan hidup yang sangat terbatas. Pasien pada tahap ini biasanya telah mengalami kegagalan multi-organ, metastasis luas (dalam kasus kanker), atau penurunan fungsi vital yang signifikan.

- **Ketergantungan pada Perawatan Paliatif**

Pasien penyakit terminal biasanya memerlukan dukungan perawatan paliatif intensif untuk mengelola gejala seperti nyeri hebat, sesak napas, mual-muntah, kelelahan ekstrem, hingga gejala emosional seperti kecemasan dan depresi.

- **Kebutuhan Perawatan Multidisiplin**

Perawatan paliatif melibatkan tim yang terdiri dari dokter, perawat, psikolog, tenaga spiritual, ahli nutrisi, dan pekerja sosial. Tujuan kolaborasi ini adalah untuk menciptakan suasana yang nyaman serta mendukung pasien dan keluarganya menghadapi akhir kehidupan dengan bermartabat.

Contoh penyakit terminal yang umum meliputi kanker stadium akhir, penyakit jantung terminal (gagal jantung stadium IV), penyakit ginjal terminal (end-stage renal disease), AIDS stadium akhir, serta penyakit neurodegeneratif seperti Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).

3. Karakteristik Umum Penyakit Kronik dan Terminal

Baik penyakit kronik maupun terminal memiliki karakteristik umum yang menentukan pendekatan dalam perawatannya:

- a. Bersifat Progresif**

Penyakit ini akan memburuk seiring berjalannya waktu, meskipun kecepatannya bervariasi antar individu. Progresivitas ini menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan penyakit, mengingat pasien akan menghadapi perubahan yang berkelanjutan dalam kondisi fisik dan psikologisnya.

- b. Memerlukan Manajemen Berkelanjutan**

Penyakit kronik maupun terminal memerlukan intervensi kesehatan yang berkelanjutan. Pasien biasanya membutuhkan terapi rutin, pemeriksaan berkala, serta edukasi tentang manajemen penyakit secara mandiri. Strategi manajemen melibatkan kombinasi obat-obatan, diet khusus, aktivitas fisik, terapi rehabilitatif, dan dukungan psikososial.

- c. Berdampak pada Kualitas Hidup Pasien dan Keluarga**

Penyakit kronik dan terminal memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup pasien maupun keluarga yang merawat. Dampak ini meliputi aspek fisik (nyeri, kelelahan), psikologis (depresi, kecemasan, rasa putus asa), sosial (isolasi sosial, stigma penyakit), dan ekonomi (beban biaya perawatan yang tinggi).

- d. Pendekatan Multidisiplin dalam Pengelolaan**

Manajemen penyakit kronik dan terminal tidak dapat diserahkan kepada satu profesi kesehatan saja. Pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai profesional, seperti dokter spesialis, perawat, ahli gizi, fisioterapis, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan lainnya, sangat diperlukan untuk mencapai hasil optimal dalam mengelola penyakit serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pendekatan ini bertujuan untuk:

- Menyusun rencana perawatan yang komprehensif.
- Mengelola gejala penyakit secara optimal.
- Memberikan dukungan psikososial, edukasi kesehatan, serta pendampingan spiritual sesuai kebutuhan pasien.
- Mengoptimalkan fungsi fisik dan mental pasien sebaik mungkin dalam keterbatasan kondisinya.

B. Mekanisme Patofisiologi Umum pada Penyakit Kronik

1. Proses Inflamasi Kronik

Inflamasi kronik merupakan suatu respons inflamasi yang berlangsung dalam jangka waktu lama, seringkali berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Proses inflamasi kronik berbeda dari inflamasi akut yang berlangsung cepat dengan tanda-tanda jelas seperti kemerahan, nyeri, panas, dan bengkak. Inflamasi kronik cenderung berlangsung tanpa gejala mencolok pada awalnya, tetapi menyebabkan kerusakan jaringan secara perlahan dan progresif.

Secara mendetail, mekanisme inflamasi kronik melibatkan:

a. Aktivasi Sistem Imun Berkelanjutan

- Sel imun seperti limfosit, makrofag, monosit, dan neutrofil secara terus-menerus diaktifkan dan terakumulasi dalam jaringan.
- Sel-sel imun tersebut memproduksi sitokin inflamasi (misalnya TNF- α , IL-1, IL-6), kemokin, prostaglandin, dan leukotrien secara terus-menerus, mempertahankan respons inflamasi.

b. Pelepasan Sitokin Inflamasi

- Sitokin inflamasi seperti tumor necrosis factor alpha (TNF- α), interleukin-1 (IL-1), dan interleukin-6 (IL-6) merupakan mediator utama dalam inflamasi kronik.
- Sitokin ini memicu perubahan jaringan, meningkatkan permeabilitas vaskular, merangsang proliferasi jaringan abnormal, serta memicu aktivasi sistem imun yang berlebihan.

c. Stres Oksidatif

- Dalam inflamasi kronik terjadi peningkatan produksi Reactive Oxygen Species (ROS) oleh sel imun dan sel jaringan yang rusak.

- Stres oksidatif yang berlebihan dapat merusak membran sel, DNA, dan protein, yang kemudian menyebabkan gangguan fungsi seluler, apoptosis (kematian sel terprogram), dan akhirnya kerusakan jaringan yang luas.

d. Kerusakan Jaringan Progresif

- Akumulasi mediator inflamasi dan stres oksidatif yang berlangsung lama menyebabkan fibrosis jaringan, nekrosis, dan pembentukan jaringan parut permanen.
- Proses ini menyebabkan kehilangan fungsi jaringan atau organ secara bertahap, seperti yang terjadi pada fibrosis paru, gagal jantung kronik, dan sirosis hati.

Contoh penyakit yang disebabkan oleh inflamasi kronik antara lain adalah rheumatoid arthritis, penyakit Crohn, diabetes mellitus tipe 2, penyakit kardiovaskular kronik, serta penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).

2. Peran Gangguan Metabolisme

Gangguan metabolisme merupakan penyimpangan dalam proses biokimia tubuh yang berdampak luas pada sistem fisiologis, menciptakan kondisi yang mendukung timbulnya penyakit kronik.

Mekanisme gangguan metabolisme meliputi:

a. Resistensi Insulin

- Resistensi insulin terjadi ketika sel-sel tubuh (khususnya otot, hati, dan jaringan adiposa) menjadi kurang sensitif terhadap hormon insulin.
- Kondisi ini menyebabkan pankreas harus memproduksi lebih banyak insulin (hiperinsulinemia) yang lama kelamaan mempercepat penurunan fungsi sel beta pankreas.
- Resistensi insulin menjadi dasar terjadinya diabetes mellitus tipe 2, obesitas sentral, sindrom metabolik, serta penyakit jantung koroner.

b. Gangguan Metabolisme Lipid (Dislipidemia)

- Dislipidemia merupakan kondisi ketidakseimbangan lipid darah, seperti peningkatan kadar kolesterol LDL (low-density lipoprotein), trigliserida tinggi, serta kadar HDL (high-density lipoprotein) rendah.
- Kondisi ini meningkatkan risiko aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular kronik seperti penyakit jantung koroner dan stroke.
- Dislipidemia juga berhubungan erat dengan inflamasi kronik melalui akumulasi LDL teroksidasi yang memicu reaksi inflamasi pada dinding arteri.

c. Gangguan Homeostasis Hormonal

- Ketidakseimbangan hormon seperti hormon tiroid, kortisol, hormon seks (estrogen, progesteron, testosteron), serta hormon stres lainnya dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh secara kronis.

- Misalnya, hipertiroidisme atau hipotiroidisme kronik menyebabkan gangguan metabolik yang luas, seperti perubahan berat badan, gangguan fungsi jantung, dan osteoporosis kronik.

Gangguan metabolisme secara umum menjadi dasar timbulnya kondisi kronik seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung koroner, obesitas kronik, dan gangguan hormonal lainnya.

3. Peran Faktor Genetik dan Epigenetik

Faktor genetik dan epigenetik memiliki peran penting dalam perkembangan penyakit kronik dengan mekanisme berikut:

a. Predisposisi Genetik

- Beberapa penyakit kronik sangat dipengaruhi oleh faktor genetik yang diwariskan dari keluarga. Individu dengan riwayat keluarga penyakit kronik tertentu cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum.
- Contoh penyakit dengan predisposisi genetik kuat seperti diabetes mellitus tipe 2, hipertensi esensial, penyakit jantung koroner, serta penyakit autoimun seperti lupus eritematosus sistemik dan rheumatoid arthritis.

b. Perubahan Ekspresi Gen (Epigenetik)

- Epigenetik merujuk pada perubahan ekspresi gen yang tidak melibatkan perubahan pada sekuens DNA, tetapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pola makan, stres psikologis, paparan toksin, aktivitas fisik, dan infeksi kronik.
- Mekanisme epigenetik meliputi metilasi DNA, modifikasi histon, dan pengaruh mikroRNA yang secara signifikan mengubah ekspresi gen, mempengaruhi fungsi seluler, dan meningkatkan risiko penyakit kronik seperti kanker, obesitas, diabetes, dan gangguan neurodegeneratif.
- Misalnya, pola makan tinggi lemak dan gula dapat memicu perubahan epigenetik yang menyebabkan resistensi insulin dan inflamasi kronik pada diabetes mellitus tipe 2.

c. Interaksi Gen-Lingkungan

- Penyakit kronik sering kali merupakan hasil interaksi kompleks antara genetik dan faktor lingkungan. Lingkungan memicu ekspresi gen tertentu yang mempercepat progresi penyakit kronik.
- Misalnya, merokok atau paparan asap rokok meningkatkan risiko PPOK dan kanker paru melalui perubahan ekspresi gen yang mengatur inflamasi dan proliferasi sel.

Contoh penyakit dengan peran kuat epigenetik meliputi diabetes tipe 2, kanker berbagai jenis, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, serta penyakit autoimun.

C. Patofisiologi Penyakit Kronik Sistem Kardiovaskular dan Respirasi

1. Patofisiologi Penyakit Kardiovaskular Kronik (Gagal Jantung Kronik)

Gagal jantung kronik merupakan kondisi progresif di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efisien sesuai kebutuhan tubuh. Kondisi ini terjadi akibat berbagai mekanisme patofisiologis yang melibatkan disfungsi ventrikel, remodeling jantung, inflamasi kronik, gangguan neurohormonal, dan perubahan struktural pembuluh darah.

a. Disfungsi Ventrikel Progresif

1) Disfungsi ventrikel merupakan inti dari gagal jantung kronik, yang terdiri atas:

- **Disfungsi sistolik**, di mana kontraksi ventrikel kiri melemah sehingga kemampuan pompa jantung menurun (fraksi ejeksi berkurang).
- **Disfungsi diastolik**, yaitu gangguan relaksasi ventrikel kiri yang menyebabkan gangguan pengisian darah ke jantung dan peningkatan tekanan diastolik.

2) Penurunan fungsi ventrikel secara progresif menyebabkan tubuh tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup, menghasilkan gejala seperti sesak napas, kelelahan, dan edema perifer.

b. Remodeling Jantung

1) Remodeling jantung merupakan proses adaptasi patologis berupa perubahan struktur dan fungsi jantung sebagai respons terhadap stres kronik (misalnya hipertensi kronik, infark miokard kronik, atau valvular heart disease).

2) Remodeling meliputi:

- **Hipertrofi (penebalan)** dinding ventrikel kiri sebagai kompensasi terhadap peningkatan beban kerja.
- **Dilatasi ventrikel** akibat kelebihan volume yang berkelanjutan sehingga ventrikel membesar dan semakin lemah.
- **Fibrosis miokardium**, yaitu peningkatan jaringan parut yang menurunkan fleksibilitas dan kontraktilitas otot jantung.

c. Inflamasi Kronik

1) Inflamasi kronik yang berlangsung lama pada jaringan miokardium berperan besar dalam progresivitas gagal jantung.

2) Mediator inflamasi seperti TNF- α , IL-6, dan CRP (C-reactive protein) menyebabkan stres oksidatif, apoptosis sel otot jantung, serta fibrosis yang mempercepat remodeling jantung dan disfungsi ventrikel.

d. Gangguan Sistem Neurohormonal

- 1) Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAAS) yang teraktivasi secara berlebihan merupakan mekanisme kompensasi tubuh pada gagal jantung kronik yang akhirnya bersifat maladaptif.
 - 2) Aktivasi RAAS secara kronik menyebabkan:
 - Retensi natrium dan air berlebih, sehingga meningkatkan preload (volume darah yang kembali ke jantung).
 - Vasokonstriksi pembuluh darah sistemik meningkatkan afterload (beban jantung untuk memompa darah).
 - Remodeling patologis melalui aksi angiotensin II dan aldosteron yang memicu fibrosis dan hipertrofi miokard.
 - 3) Selain RAAS, aktivasi kronik sistem saraf simpatik juga memperburuk disfungsi jantung dengan meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan resistensi pembuluh darah.
- e. Perubahan Struktur Pembuluh Darah
- 1) Pembuluh darah mengalami perubahan struktural akibat hipertensi kronik, inflamasi, aterosklerosis, dan stres oksidatif yang menyebabkan:
 - Penebalan dinding arteri (aterosklerosis dan arteriosklerosis).
 - Hilangnya elastisitas arteri.
 - Peningkatan resistensi vaskular perifer, memperberat kerja jantung, dan mempercepat terjadinya gagal jantung.

2. Patofisiologi Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)

PPOK adalah penyakit inflamasi kronik paru yang ditandai oleh obstruksi saluran napas persisten dan progresif serta kerusakan struktur parenkim paru. Patofisiologinya melibatkan beberapa komponen utama seperti inflamasi kronik, obstruksi saluran napas, emfisema, bronkitis kronik, serta gangguan pertukaran gas.

a. Inflamasi Kronik pada Bronkus dan Parenkim Paru

- 1) Paparan kronik terhadap partikel iritan seperti asap rokok, polutan udara, dan bahan kimia toksik menyebabkan inflamasi kronik pada saluran napas.
- 2) Inflamasi ini melibatkan aktivasi neutrofil, makrofag, limfosit, dan pelepasan mediator inflamasi seperti IL-8, TNF- α , leukotrien, dan ROS (Reactive Oxygen Species).
- 3) Inflamasi kronik menyebabkan kerusakan jaringan epitel saluran napas dan parenkim paru secara progresif dan ireversibel.

b. Obstruksi Saluran Napas Progresif

- 1) Obstruksi saluran napas terjadi akibat beberapa proses:
 - Hiperplasia dan hipertrofi kelenjar mukosa menyebabkan produksi lendir berlebih.
 - Edema mukosa yang menyebabkan penyempitan saluran napas.
 - Fibrosis bronkiolus, yaitu penebalan dinding bronkiolus akibat deposisi jaringan ikat fibrotik.
 - Bronkospasme kronik akibat peningkatan reaktivitas otot polos saluran napas.

- 2) Obstruksi ini menimbulkan gejala sesak napas kronik yang semakin berat, batuk kronik dengan produksi dahak, dan infeksi saluran napas berulang.
- c. Emfisema Paru
- 1) Emfisema ditandai oleh kerusakan permanen alveoli dan jaringan elastis paru, menghasilkan pembesaran ruang udara distal yang tidak efektif dalam pertukaran gas.
 - 2) Kerusakan jaringan paru akibat aktivitas protease berlebihan (seperti elastase dari neutrofil) yang tidak seimbang dengan antiprotease (seperti alpha-1-antitrypsin).
 - 3) Hilangnya elastisitas jaringan paru menyebabkan paru-paru kehilangan kemampuan retraksi elastisnya, menjadikan ekspirasi (menghembuskan napas) sulit, sehingga udara terjebak (air trapping).
- d. Bronkitis Kronik
- 1) Bronkitis kronik merupakan inflamasi kronik bronkus yang menyebabkan produksi lendir berlebih dan gangguan clearance mukosiliar.
 - 2) Pasien mengalami batuk produktif kronik minimal tiga bulan dalam dua tahun berturut-turut.
 - 3) Infeksi saluran napas berulang sering memperberat inflamasi kronik yang telah berlangsung, mempercepat kerusakan bronkus, dan meningkatkan progresivitas PPOK.
- e. Gangguan Pertukaran Gas
- 1) Akibat emfisema dan obstruksi saluran napas, kapasitas paru untuk melakukan pertukaran gas oksigen-karbon dioksida sangat berkurang.
 - 2) Terjadi mismatch ventilasi-perfusi (V/Q mismatch), di mana udara tidak mencapai daerah paru yang mendapat perfusi darah, menyebabkan hipoksia kronik (kekurangan oksigen).
 - 3) Hipoksia kronik memperberat hipertensi pulmonal dan dapat menyebabkan gagal jantung kanan (cor pulmonale) sebagai komplikasi.

D. Patofisiologi Penyakit Terminal (Fokus Kanker Stadium Lanjut)

1. Mekanisme Progresi Kanker Menuju Stadium Terminal

Kanker stadium lanjut atau terminal adalah kondisi di mana kanker telah menyebar luas ke berbagai organ tubuh, tidak lagi dapat disembuhkan, dan memiliki prognosis buruk. Mekanisme progresi kanker hingga tahap terminal melibatkan beberapa aspek penting berikut:

a. Metastasis Luas

- 1) Metastasis adalah penyebaran sel kanker dari lokasi primer ke organ atau jaringan lain melalui aliran darah, limfe, atau penyebaran langsung.
- 2) Proses metastasis dimulai dengan:

- **Infiltrasi jaringan sekitar:** Sel kanker menembus membran basal dan matriks ekstraseluler.
 - **Masuk ke pembuluh darah dan limfatik (intravasi):** Sel kanker memasuki pembuluh darah atau sistem limfatik untuk menyebar.
 - **Perjalanan dan ekstrasvasasi:** Sel kanker mencapai organ yang jauh, keluar dari pembuluh darah, dan menempel di jaringan target.
 - **Kolonisasi dan proliferasi:** Sel kanker berkembang biak di lokasi baru, membentuk tumor sekunder (metastasis).
- 3) Metastasis luas menyebabkan kerusakan berbagai organ penting seperti paru-paru, hati, tulang, otak, yang mengganggu fungsi vital dan menandai stadium terminal kanker.
- b. Gangguan Sistem Imun
- 1) Kanker stadium lanjut menyebabkan supresi sistem imun, baik secara langsung oleh sel kanker maupun oleh efek terapi yang agresif.
 - 2) Sel kanker mengeluarkan zat imunosupresif seperti TGF- β (Transforming Growth Factor-beta), IL-10, dan PD-L1 (Programmed Death-Ligand 1) yang menghambat aktivitas limfosit T dan NK cells.
 - 3) Gangguan sistem imun mempercepat penyebaran kanker, meningkatkan risiko infeksi berat yang sulit dikontrol, serta mempercepat progresi penyakit ke tahap terminal.
- c. Invasi Jaringan Sehat
- 1) Kanker stadium lanjut ditandai invasi aktif sel kanker terhadap jaringan sehat di sekitarnya, mengakibatkan kerusakan jaringan luas.
 - 2) Sel kanker menghasilkan enzim proteolitik seperti metaloproteinase matriks (MMPs) yang menghancurkan jaringan normal, pembuluh darah, saraf, dan struktur pendukung.
 - 3) Invasi jaringan mengakibatkan nyeri kronik, disfungsi organ, perdarahan masif, dan komplikasi serius lainnya.
- d. Disfungsi Organ Multipel
- 1) Akibat metastasis luas dan invasi jaringan, pasien kanker stadium terminal mengalami kegagalan fungsi multipel organ (multiple organ dysfunction syndrome).
 - 2) Gangguan fungsi organ yang umum meliputi:
 - **Gangguan fungsi hati:** jaundice, gangguan koagulasi, ensefalopati.
 - **Gangguan fungsi paru-paru:** gagal napas, efusi pleura.
 - **Gangguan fungsi ginjal:** gagal ginjal akut, gangguan elektrolit.

- **Gangguan fungsi otak:** perubahan kesadaran, kejang, delirium.
- 3) Disfungsi multipel organ merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien kanker stadium terminal.

2. Komplikasi Utama yang Mempercepat Status Terminal Pasien Kanker

Pasien kanker stadium lanjut mengalami komplikasi berat yang memperburuk prognosis dan mempercepat progresi menuju status terminal:

a. Nyeri Kronik Berat

- Nyeri kronik terjadi akibat infiltrasi jaringan oleh tumor, metastasis ke tulang atau saraf, serta inflamasi kronik.
- Nyeri kronik pada kanker menurunkan kualitas hidup secara signifikan, menyebabkan gangguan tidur, depresi, kecemasan, serta keterbatasan aktivitas fisik dan sosial.

b. Kakeksia (Penurunan Berat Badan Parah)

- Kakeksia merupakan sindrom katabolik dengan penurunan berat badan ekstrem, atrofi otot, anoreksia, anemia, serta inflamasi kronik.
- Kakeksia disebabkan oleh sitokin inflamasi (TNF- α , IL-6, IL-1) yang meningkatkan metabolisme tubuh, merangsang degradasi otot (proteolisis), dan menekan nafsu makan secara drastis.
- Kondisi ini mempercepat kemunduran fisik, menurunkan toleransi terhadap terapi, serta meningkatkan risiko infeksi dan komplikasi.

c. Kelelahan Berat (Fatigue)

- Fatigue kanker adalah perasaan lelah ekstrem yang tidak berkurang dengan istirahat, disebabkan oleh inflamasi kronik, anemia, hipoksia, malnutrisi, gangguan metabolik, serta dampak psikologis kanker.
- Fatigue menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, depresi, kehilangan motivasi, serta berkurangnya interaksi sosial.

d. Gangguan Psikososial

- Pasien kanker terminal mengalami tekanan psikologis hebat seperti depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, takut menghadapi kematian, dan isolasi sosial.
- Gangguan ini memperburuk kondisi fisik, mempercepat deteriorasi kesehatan, serta mengganggu kemampuan pasien dalam mengelola gejala fisik.

3. Gambaran Patofisiologi Nyeri pada Kanker Terminal

Nyeri pada kanker terminal adalah manifestasi kompleks yang melibatkan beberapa mekanisme patofisiologi yang berbeda, yaitu nyeri nosiseptif, nyeri neuropatik, dan nyeri campuran:

a. Nyeri Nosiseptif

- 1) Nyeri nosiseptif disebabkan oleh kerusakan jaringan (infiltrasi tumor, destruksi jaringan normal).
- 2) Nyeri ini timbul akibat stimulasi reseptor nyeri (nosiseptor) oleh zat inflamasi (prostaglandin, substansi P, bradikinin, serotonin) yang dilepaskan akibat kerusakan jaringan.
- 3) Nyeri nosiseptif sering terasa tajam, tumpul, berdenyut, dan terlokalisasi jelas.

b. Nyeri Neuropatik

- 1) Nyeri neuropatik muncul akibat kerusakan langsung atau infiltrasi sel kanker terhadap saraf perifer maupun sistem saraf pusat.
- 2) Gangguan saraf menyebabkan sensasi nyeri khas seperti rasa terbakar, kesemutan, rasa tersengat listrik, serta hipersensitivitas terhadap rangsangan ringan (allodynia).
- 3) Nyeri neuropatik sulit dikontrol dengan analgesik biasa, membutuhkan terapi spesifik seperti antikonvulsan atau antidepresan trisiklik.

c. Nyeri Campuran (Mixed Pain)

- 1) Nyeri campuran adalah kombinasi dari nyeri nosiseptif dan neuropatik, yang sering dijumpai pada kanker stadium terminal akibat invasi jaringan, inflamasi, serta kompresi saraf oleh metastasis.
- 2) Nyeri ini kompleks dan sangat sulit dikontrol, membutuhkan pendekatan multidisiplin dalam manajemennya.

E. Pendekatan Manajemen dan Terapi Paliatif pada Penyakit Terminal

1. Prinsip Terapi Paliatif

Terapi paliatif adalah pendekatan perawatan medis yang bertujuan utama meningkatkan kualitas hidup pasien yang menghadapi penyakit terminal. Prinsip-prinsip utama terapi paliatif meliputi:

a. Pengendalian Nyeri

Nyeri merupakan gejala utama yang sering dialami pasien terminal, terutama pada pasien kanker stadium lanjut. Prinsip utama manajemen nyeri dalam terapi paliatif melibatkan:

- 1) Pendekatan bertingkat (WHO analgesic ladder), yaitu:

- **Nyeri ringan:** diberikan analgesik non-opioid (parasetamol, NSAID).
 - **Nyeri sedang:** kombinasi analgesik opioid ringan (kodein, tramadol) dengan non-opioid.
 - **Nyeri berat:** penggunaan analgesik opioid kuat (morfin, fentanyl, oksikodon).
- 2) Pemberian analgesik secara teratur, bukan berdasarkan "as needed," untuk mencegah breakthrough pain (nyeri mendadak yang hebat).
 - 3) Evaluasi nyeri secara berkala dengan skala nyeri (Visual Analog Scale/VAS, Numeric Rating Scale/NRS), serta penyesuaian dosis analgesik berdasarkan respons pasien.
- b. Manajemen Gejala Fisik Lainnya
- Pasien terminal sering mengalami berbagai gejala fisik yang mengganggu kualitas hidup seperti sesak napas, mual, muntah, anoreksia, kelelahan berat, konstipasi, dan insomnia. Strategi manajemen meliputi:
- 1) Sesak napas (Dispnea):
Pemberian oksigen tambahan, obat bronkodilator, opioid dosis rendah untuk mengurangi sensasi sesak, serta teknik pernapasan seperti latihan pernapasan dalam (deep breathing).
 - 2) Mual dan Muntah:
Obat antiemetik (metoklopramid, ondansetron, dexamethasone), serta intervensi non-farmakologis seperti diet kecil sering, makanan ringan, dan teknik relaksasi.
 - 3) Kelelahan (Fatigue):
Pengaturan aktivitas harian, terapi okupasi, olahraga ringan yang disesuaikan, perbaikan nutrisi, dan pengelolaan anemia.
 - 4) Konstipasi:
Penggunaan obat pencabar rutin (laksatif), hidrasi yang cukup, serta diet tinggi serat.
- c. Dukungan Psikologis dan Spiritual
- Pasien dengan penyakit terminal mengalami beban psikologis dan spiritual yang signifikan. Dukungan ini meliputi:
- 1) Dukungan psikologis: pemberian konseling psikologis untuk mengatasi kecemasan, depresi, ketakutan menghadapi kematian, dan masalah hubungan keluarga.
 - 2) Terapi spiritual: bantuan tenaga spiritual (pemuka agama, chaplain) untuk membantu pasien dalam menemukan makna hidup, menghadapi akhir

kehidupan secara damai, serta menyelesaikan konflik spiritual atau eksistensial yang dihadapi pasien.

2. Pendekatan Multidisiplin dalam Pelayanan Paliatif

Terapi paliatif tidak hanya fokus pada aspek medis saja, melainkan juga mencakup seluruh aspek kehidupan pasien. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan multidisiplin sangat esensial, yang terdiri dari berbagai tenaga profesional berikut:

a. Tenaga Medis

Dokter spesialis paliatif dan dokter spesialis terkait (onkologi, penyakit dalam, neurologi) bekerja untuk merancang rencana pengobatan yang optimal, mengatur pengendalian nyeri dan gejala, serta memantau respons terapi secara berkala.

b. Perawat Paliatif

Berperan dalam manajemen gejala harian, membantu pasien dalam perawatan dasar, edukasi pasien dan keluarga mengenai manajemen gejala, serta memberikan kenyamanan dan empati yang mendalam terhadap kondisi pasien.

c. Psikolog dan Konselor

Menyediakan dukungan emosional, terapi psikologis untuk menangani stres, kecemasan, dan depresi yang dialami pasien dan keluarga.

d. Ahli Gizi

Memberikan rekomendasi nutrisi optimal sesuai kondisi pasien, manajemen anoreksia atau kakeksia, serta intervensi nutrisi spesifik untuk meningkatkan kenyamanan pasien.

e. Tenaga Spiritual (Pemuka Agama, Chaplain)

Membantu pasien menyelesaikan masalah spiritual, menghadapi akhir kehidupan secara tenang, serta mendampingi pasien dan keluarga dalam proses spiritual, sesuai keyakinan masing-masing.

f. Pekerja Sosial

Menyediakan dukungan sosial, membantu pasien dan keluarga dalam akses layanan sosial, mendukung dalam penyelesaian administrasi keuangan dan legal, serta membantu memfasilitasi komunikasi keluarga dengan tim medis.

g. Keluarga dan Dukungan Sosial

Peran keluarga sangat vital dalam membantu pasien menghadapi akhir kehidupannya, termasuk dalam aspek perawatan sehari-hari, pemberian dukungan emosional, serta membantu dalam pengambilan keputusan medis.

Pendekatan tim multidisiplin memastikan pelayanan paliatif yang holistik, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan kompleks pasien terminal dan keluarganya.

3. Pertimbangan Etis dan Hukum dalam Pengambilan Keputusan Akhir Kehidupan

Manajemen penyakit terminal melibatkan isu-isu etis dan hukum yang kompleks. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah:

a. Informed Consent

Prinsip dasar informed consent memastikan pasien (atau keluarga yang sah secara hukum) memahami sepenuhnya kondisi medis, pilihan terapi yang tersedia, manfaat dan risiko setiap keputusan, sehingga pasien dapat membuat keputusan medis yang sadar dan sukarela.

b. Penghentian Terapi Aktif (Withdrawal of Treatment)

Secara etis dibenarkan untuk menghentikan atau tidak memulai terapi yang dianggap tidak efektif (futile), yang justru memperpanjang penderitaan pasien tanpa memberikan manfaat nyata (misalnya penghentian ventilasi mekanis, dialisis, atau kemoterapi agresif pada kondisi terminal).

c. Do-Not-Resuscitate (DNR)

DNR adalah keputusan pasien (atau keluarga yang berwenang) untuk tidak melakukan tindakan resusitasi kardiopulmonal (CPR) jika terjadi henti jantung atau pernapasan, mengingat tindakan tersebut mungkin tidak bermanfaat pada pasien terminal, bahkan mungkin memperpanjang penderitaan.

d. Advance Care Planning (ACP)

ACP adalah proses diskusi mendalam antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan mengenai preferensi pasien tentang perawatan akhir kehidupan, mencakup keinginan tentang intervensi medis, pengelolaan gejala, serta tempat perawatan (rumah, rumah sakit, hospice).

Hasil ACP biasanya dituangkan dalam dokumen tertulis (advance directives) yang bersifat mengikat secara moral dan hukum.

e. Pertimbangan Etis dalam Komunikasi

Komunikasi terbuka, jujur, empatik, dan jelas antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarga sangat penting dalam pengambilan keputusan akhir kehidupan. Informasi harus diberikan dengan cara yang penuh empati, memperhatikan kondisi emosional pasien dan keluarganya.

F. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

Soal 1

Bapak Ahmad (65 tahun) telah didiagnosis dengan diabetes mellitus tipe 2 selama 10 tahun terakhir. Beliau menjalani terapi rutin dan edukasi pengelolaan mandiri, namun kondisi gula darahnya masih fluktuatif. Pernyataan berikut yang paling tepat mengenai penyakit Bapak Ahmad adalah:

- A. Merupakan kondisi yang sepenuhnya dapat disembuhkan jika ditangani secara ketat.
- B. Penyakit ini tidak progresif dan hanya membutuhkan perhatian sementara.
- C. Penyakit kronik dengan progresivitas lambat yang membutuhkan manajemen berkelanjutan.
- D. Kondisi yang akan sembuh total dalam waktu kurang dari tiga bulan.
- E. Merupakan penyakit terminal yang membutuhkan perawatan paliatif.

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronik yang tidak dapat disembuhkan secara total, memiliki progresivitas lambat, dan membutuhkan manajemen berkelanjutan sepanjang hidup pasien.

Soal 2

Ibu Wati (55 tahun) menderita kanker payudara stadium akhir yang telah bermetastasis ke paru-paru dan tulang. Dokter menjelaskan bahwa pengobatan sekarang lebih diarahkan pada tujuan paliatif. Karakteristik penyakit terminal pada kasus Ibu Wati adalah:

- A. Bisa disembuhkan total dengan terapi intensif.
- B. Tidak memerlukan dukungan multidisiplin.
- C. Memiliki prognosis baik dengan harapan hidup lebih dari 1 tahun.
- D. Perlu perawatan paliatif intensif dengan prognosis buruk.
- E. Penyakit bersifat ringan dan tidak progresif.

Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Kanker stadium terminal seperti kasus Ibu Wati memiliki prognosis buruk, harapan hidup terbatas (kurang dari 6 bulan), dan membutuhkan perawatan paliatif intensif untuk mengelola gejala fisik, emosional, dan spiritual.

Soal 3

Bapak Surya (60 tahun) dirawat dengan diagnosis gagal jantung kronik yang semakin memburuk selama beberapa tahun terakhir. Salah satu mekanisme patofisiologi utama dari gagal jantung kronik adalah:

- A. Inflamasi akut yang cepat sembuh.
- B. Tidak melibatkan sistem neurohormonal.
- C. Remodeling jantung dan aktivasi sistem neurohormonal.
- D. Proses non-progresif yang stabil.
- E. Kerusakan jaringan ringan yang dapat sembuh total.

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Patofisiologi gagal jantung kronik melibatkan remodeling jantung yang patologis serta aktivasi kronik sistem neurohormonal seperti RAAS, menyebabkan disfungsi progresif jantung.

Soal 4

Ny. Ani (68 tahun) telah lama menderita PPOK. Ia sering mengalami sesak napas, batuk berdahak, dan infeksi paru yang berulang. Mekanisme patofisiologi utama PPOK yang dialami Ny. Ani adalah:

- A. Inflamasi akut pada saluran napas.
- B. Kerusakan reversibel jaringan paru yang sembuh total.
- C. Emfisema dan bronkitis kronik dengan obstruksi progresif.
- D. Tidak adanya gangguan pertukaran gas.
- E. Penyakit non-inflamasi yang tidak progresif.

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

PPOK ditandai oleh obstruksi saluran napas progresif akibat inflamasi kronik, emfisema, dan bronkitis kronik yang menyebabkan gangguan pertukaran gas yang permanen.

Soal 5

Pak Budi (70 tahun) mengalami kanker stadium terminal dengan nyeri hebat akibat metastasis tulang belakang. Nyeri yang dialami Pak Budi termasuk jenis nyeri berikut, kecuali:

- A. Nyeri neuropatik akibat infiltrasi saraf.
- B. Nyeri nosiseptif akibat destruksi jaringan.
- C. Nyeri campuran akibat infiltrasi saraf dan jaringan.
- D. Nyeri akut ringan yang sembuh sendiri tanpa pengobatan.

E. Nyeri kronik yang sulit dikontrol.

Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Nyeri pada kanker terminal sering melibatkan nyeri nosiseptif, neuropatik, atau campuran yang bersifat kronik, berat, dan sulit dikontrol, bukan nyeri akut ringan yang sembuh tanpa pengobatan.

G. Rangkuman Materi

Penyakit kronik merupakan gangguan kesehatan dengan durasi panjang, memiliki progresivitas lambat, tidak dapat disembuhkan total tetapi dapat dikendalikan dengan pendekatan manajemen komprehensif. Penyakit terminal merupakan kondisi tahap akhir dengan prognosis buruk dan harapan hidup sangat terbatas, memerlukan perawatan paliatif yang intensif dan multidisiplin. Karakteristik umum penyakit kronik dan terminal meliputi progresivitas, kebutuhan manajemen kesehatan berkelanjutan, dampak signifikan terhadap kualitas hidup pasien serta keluarga, serta perlunya pendekatan multidisiplin dalam pengelolaan.

Patofisiologi penyakit kronik melibatkan mekanisme inflamasi kronik, gangguan metabolisme seperti resistensi insulin dan dislipidemia, serta peran faktor genetik dan epigenetik. Penyakit kardiovaskular kronik seperti gagal jantung, dan penyakit respirasi kronik seperti PPOK, melibatkan inflamasi kronik, remodeling jaringan, serta perubahan struktural yang mengurangi fungsi organ secara progresif. Pada penyakit terminal, khususnya kanker stadium lanjut, mekanisme patofisiologi mencakup metastasis luas, invasi jaringan sehat, gangguan sistem imun, serta disfungsi multipel organ yang memicu komplikasi seperti nyeri hebat, kakeksia, fatigue, dan gangguan psikososial.

Manajemen penyakit terminal berfokus pada terapi paliatif untuk mengelola nyeri dan gejala fisik lainnya serta memberikan dukungan psikologis, sosial, dan spiritual melalui pendekatan multidisiplin. Aspek etis dan hukum seperti informed consent, penghentian terapi aktif, DNR, serta advance care planning sangat penting dalam pengambilan keputusan akhir kehidupan untuk memastikan perawatan yang sesuai dengan keinginan pasien serta keluarga, dengan pendekatan komunikasi yang empatik dan terbuka.

H. Glosarium

Penyakit Kronik: Penyakit yang berlangsung lama, progresif lambat, dan tidak dapat disembuhkan total tetapi dapat dikendalikan.

Penyakit Terminal: Kondisi tahap akhir dengan prognosis buruk, harapan hidup terbatas (<6 bulan), memerlukan perawatan paliatif.

Perawatan Paliatif: Pendekatan perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien terminal dengan mengurangi penderitaan fisik, emosional, sosial, dan spiritual.

Prognosis: Prediksi atau perkiraan perkembangan penyakit dan harapan hidup pasien.

Inflamasi Kronik: Peradangan berkepanjangan yang menyebabkan kerusakan jaringan secara perlahan.

Resistensi Insulin: Kondisi sel tubuh kurang sensitif terhadap insulin, menyebabkan gangguan metabolisme seperti diabetes mellitus tipe 2.

Remodeling Jantung: Perubahan struktur dan fungsi jantung akibat stres kronik, berkontribusi pada progresivitas gagal jantung.

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK): Penyakit inflamasi kronik paru yang menyebabkan obstruksi saluran napas dan gangguan pertukaran gas progresif.

Metastasis: Penyebaran sel kanker ke organ lain, menandai stadium lanjut kanker.

Kakeksia: Penurunan berat badan ekstrem akibat inflamasi kronik atau kanker stadium lanjut.

Fatigue: Kelelahan ekstrem yang tidak berkurang dengan istirahat, sering dialami pasien terminal.

Nyeri Neuropatik: Nyeri akibat gangguan atau kerusakan saraf, sulit dikontrol.

Advance Care Planning (ACP): Diskusi antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan mengenai perawatan akhir kehidupan secara tertulis.

Do-Not-Resuscitate (DNR): Keputusan untuk tidak melakukan resusitasi pada pasien terminal yang mengalami henti jantung atau pernapasan.

Multidisiplin: Pendekatan perawatan yang melibatkan berbagai profesi kesehatan untuk hasil optimal.

I. Daftar Pustaka

- American Cancer Society. (2021). Advanced cancer: Treatment and management. Retrieved from <https://www.cancer.org/treatment/end-of-life-care/advanced-cancer.html>
- American Heart Association. (2021). Heart failure pathophysiology. Retrieved from <https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure>
- Chandra, R., Zhou, H., & Li, J. (2021). Chronic inflammation and oxidative stress in cardiovascular diseases: Molecular mechanisms and therapeutic implications. *Antioxidants*, 10(8), 1263. <https://doi.org/10.3390/antiox10081263>
- Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). (2023). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Retrieved from <https://goldcopd.org/gold-reports/>
- Jonscher, K. R., & Belury, M. A. (2022). Nutrition and epigenetics: Interactions with chronic diseases. *Annual Review of Nutrition*, 42, 245–269. <https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-052020-041951>
- Koene, R. J., Prizment, A. E., Blaes, A., & Konety, S. H. (2016). Shared risk factors in cardiovascular disease and cancer. *Circulation*, 133(11), 1104–1114. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020406>
- National Cancer Institute. (2023). Understanding cancer metastasis. Retrieved from <https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what-is-cancer/metastatic-cancer>
- National Institute on Aging. (2022). End-of-life care for people with terminal illness. Retrieved from <https://www.nia.nih.gov/health/end-life-care-people-terminal-illness>
- World Health Organization. (2020). Palliative care. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>
- Yadav, U. N., Rayamajhee, B., Mistry, S. K., Parsekar, S. S., & Mishra, S. K. (2020). A systematic review and meta-analysis of chronic disease management interventions and their effectiveness. *BMC Public Health*, 20(1), 673. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08867-1>
- Zhao, Y., Forst, C. V., & Sayegh, C. E. (2021). Genetic predisposition and epigenetic changes in chronic inflammatory diseases. *Cells*, 10(8), 1888. <https://doi.org/10.3390/cells10081888>

BAB 7

PENGKAJIAN FISIK DAN PSIKOLOGIS

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu melaksanakan pengkajian fisik dan psikologis secara integratif, holistik, serta profesional dalam praktik klinik dengan mempertimbangkan prinsip etika, legal, serta kebutuhan spesifik pasien berdasarkan usia dan kondisinya.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pengkajian fisik dan psikologis, mengaplikasikan berbagai teknik dan metode pengkajian yang tepat, serta merancang intervensi kesehatan secara holistik berdasarkan hasil pengkajian yang komprehensif dan integratif.

SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan definisi, tujuan, dan pentingnya pengkajian kesehatan secara fisik dan psikologis dalam pelayanan kesehatan.
2. Mengaplikasikan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik secara efektif dalam proses pengkajian fisik dan psikologis.
3. Melaksanakan pendekatan holistik dalam pengkajian pasien yang mencakup aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual.
4. Menjelaskan hubungan erat antara kesehatan fisik dan psikologis serta pentingnya integrasi pengkajian keduanya dalam praktik klinik.
5. Menguasai teknik dasar pengkajian fisik, mencakup inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi secara sistematis dan akurat.
6. Melakukan wawancara klinis, observasi perilaku, serta menggunakan alat ukur psikologis yang valid dalam pengkajian psikologis.
7. Menyusun rencana intervensi kesehatan yang integratif berdasarkan hasil pengkajian fisik dan psikologis yang komprehensif.
8. Menerapkan pertimbangan etis dan legal dalam setiap tahap pengkajian kesehatan sesuai standar praktik profesional.

9. Menyesuaikan teknik pengkajian khusus berdasarkan kelompok umur dan kondisi khusus pasien, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, lansia, ibu hamil, dan pasien terminal.
10. Mendokumentasikan hasil pengkajian secara sistematis, jelas, akurat, dan legal untuk mendukung kesinambungan perawatan dan evaluasi efektivitas intervensi.

Pendahuluan

Pengkajian fisik dan psikologis merupakan langkah awal dan krusial dalam proses pelayanan kesehatan yang bertujuan mengidentifikasi kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Pengkajian fisik dilakukan untuk mendeteksi kelainan fisiologis melalui metode inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, sementara pengkajian psikologis bertujuan menilai kondisi mental, emosional, dan perilaku pasien. Keterampilan komunikasi terapeutik dan pendekatan holistik merupakan prinsip utama yang mendukung proses pengkajian, memastikan intervensi medis atau keperawatan dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan pasien. Integrasi kedua aspek pengkajian ini menjadi penting karena adanya hubungan erat antara kondisi fisik dan psikologis yang saling mempengaruhi, khususnya dalam pengelolaan penyakit kronis, gangguan mental, maupun kondisi kesehatan yang kompleks.

A. Konsep Dasar Pengkajian Fisik dan Psikologis

1. Definisi dan Tujuan Pengkajian

a. Pengertian Pengkajian Kesehatan

Pengkajian kesehatan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam proses pelayanan kesehatan. Secara definitif, pengkajian kesehatan adalah proses sistematis yang dilakukan tenaga kesehatan dalam mengumpulkan, memvalidasi, menganalisis, serta mendokumentasikan informasi atau data terkait status kesehatan pasien. Data ini mencakup riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, penilaian kondisi psikologis, sosial, dan spiritual pasien, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan pasien, risiko kesehatan yang dihadapi, serta masalah kesehatan yang aktual atau potensial.

Proses pengkajian ini berperan sebagai dasar untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi intervensi medis maupun keperawatan. Dengan kata lain, pengkajian kesehatan merupakan fondasi dalam praktik pelayanan kesehatan yang berfokus pada individu secara komprehensif.

b. Tujuan Pengkajian Fisik dan Psikologis

Tujuan utama pengkajian kesehatan dibagi menjadi dua aspek, yaitu fisik dan psikologis:

- **Pengkajian Fisik** bertujuan untuk mendeteksi kelainan atau gangguan fisiologis yang dialami oleh pasien. Hal ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap fungsi tubuh, termasuk organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, sistem saraf, muskuloskeletal, sistem pencernaan, dan sebagainya. Pengkajian fisik ini penting untuk mengetahui status kesehatan fisik secara objektif dan akurat, yang akan membantu dalam membuat diagnosis medis yang tepat dan intervensi yang relevan.
- **Pengkajian Psikologis** bertujuan untuk menilai status mental, emosional, serta perilaku pasien. Aspek psikologis sangat penting karena mempengaruhi persepsi pasien terhadap penyakitnya, kepatuhan terhadap pengobatan, proses penyembuhan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Penilaian psikologis ini mencakup kondisi seperti kecemasan, depresi, stres, kemampuan coping, persepsi pasien terhadap penyakitnya, serta risiko perilaku maladaptif seperti bunuh diri atau agresivitas.

2. Prinsip Umum Pengkajian

a. Keterampilan Komunikasi Terapeutik

Dalam melaksanakan pengkajian fisik maupun psikologis, kemampuan tenaga kesehatan dalam menggunakan komunikasi terapeutik sangat vital. Komunikasi terapeutik adalah bentuk komunikasi profesional yang ditujukan untuk membantu pasien mengungkapkan keluhan, perasaan, serta pikirannya dengan nyaman dan terbuka. Prinsip-prinsip komunikasi terapeutik meliputi:

- **Empati:** Kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami perasaan dan pengalaman pasien, sekaligus menunjukkan pemahaman tersebut secara verbal maupun non-verbal.
- **Aktif Mendengarkan:** Keterampilan dalam memperhatikan dan merespons secara aktif apa yang disampaikan pasien untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan akurat dan relevan.
- **Kejelasan dan Kejujuran:** Memberikan informasi secara jelas, jujur, dan dapat dipercaya agar pasien merasa nyaman dalam berkomunikasi.
- **Non-judgemental:** Bersikap tidak menghakimi terhadap keluhan atau kondisi pasien, sehingga pasien lebih terbuka dalam menyampaikan berbagai informasi penting.

b. Pendekatan Holistik

Pendekatan holistik dalam pengkajian kesehatan menekankan pada pentingnya menilai pasien secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek fisik, tetapi juga aspek mental, emosional, sosial, dan spiritual. Prinsip pendekatan holistik ini mencakup:

- **Fisik:** Melibatkan evaluasi fungsi tubuh, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan organ-organ tubuh, serta identifikasi masalah fisik secara umum.
- **Mental dan emosional:** Mengevaluasi kondisi mental, emosi, kognisi, persepsi, suasana hati, serta mekanisme adaptasi atau coping pasien.
- **Sosial:** Melibatkan penilaian terhadap dukungan keluarga dan sosial, hubungan interpersonal pasien, kondisi ekonomi, serta pengaruh lingkungan sosial terhadap kesehatan.
- **Spiritual:** Penilaian keyakinan, nilai, praktik spiritual atau religius yang dapat mempengaruhi persepsi pasien terhadap penyakit, penyembuhan, serta penerimaan terhadap intervensi medis.

Pendekatan holistik ini memastikan bahwa perencanaan intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan unik masing-masing pasien secara komprehensif.

3. Pentingnya Integrasi Pengkajian Fisik dan Psikologis

a. Kaitan Erat Antara Kesehatan Fisik dan Psikologis

Integrasi antara pengkajian fisik dan psikologis penting karena keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam kondisi kesehatan pasien. Kesehatan fisik yang terganggu secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi psikologis pasien, misalnya pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes atau gagal jantung cenderung mengalami kecemasan atau depresi. Sebaliknya, gangguan psikologis seperti depresi atau kecemasan dapat memperburuk gejala fisik dan memperlambat proses penyembuhan.

Pemahaman tentang hubungan timbal balik ini sangat penting agar tenaga kesehatan mampu merencanakan intervensi secara efektif, dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara simultan.

b. Studi Kasus Pentingnya Integrasi Pengkajian

Sebagai contoh, pasien dengan diabetes mellitus tidak hanya mengalami gangguan pada fisiknya (misalnya gangguan penglihatan, neuropati perifer, luka yang sulit sembuh), tetapi juga rentan terhadap gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan akibat penyakit kronis yang diderita. Apabila pengkajian fisik saja yang dilakukan tanpa pengkajian psikologis, kemungkinan besar perawatan akan kurang efektif karena aspek psikologis yang turut memperburuk kondisi fisik tidak teratasi.

Dalam studi kasus seperti ini, integrasi antara pengkajian fisik dan psikologis sangat dibutuhkan untuk memastikan intervensi holistik, seperti pemberian terapi fisik, pengobatan medis, edukasi pengelolaan diabetes, konseling psikologis, serta dukungan sosial, sehingga tercapai hasil yang optimal dalam peningkatan kualitas hidup pasien.

B. Teknik dan Metode dalam Pengkajian Fisik

Dalam pengkajian fisik, tenaga kesehatan menggunakan berbagai teknik pemeriksaan untuk mendapatkan data objektif yang akurat tentang kondisi fisiologis pasien. Pengkajian fisik yang efektif membutuhkan ketelitian, keterampilan klinis, serta penggunaan teknik-teknik standar yang tepat. Berikut penjelasan lengkap mengenai teknik dan metode pengkajian fisik yang digunakan secara umum dalam pelayanan kesehatan.

1. Teknik Dasar Pengkajian

Teknik dasar pengkajian fisik terdiri dari empat metode utama yang umum digunakan: inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Setiap teknik memiliki tujuan, metode, dan penggunaannya yang khas.

a. Inspeksi

Inspeksi adalah metode pengkajian dengan melakukan observasi visual secara teliti terhadap kondisi tubuh pasien. Tujuan inspeksi adalah mengidentifikasi perubahan yang tampak secara fisik, termasuk:

- **Warna Kulit:** Pemeriksaan terhadap warna kulit dapat menunjukkan kondisi kesehatan tertentu seperti sianosis (warna kebiruan akibat kurang oksigen), ikterus (warna kekuningan karena gangguan hati), pucat (anemia atau syok), serta kemerahan (inflamasi atau infeksi).
- **Postur Tubuh:** Penilaian postur tubuh mencakup bentuk tubuh, posisi duduk atau berdiri, simetri tubuh, dan adanya kelainan seperti skoliosis atau kifosis yang dapat mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan.
- **Ekspresi Wajah:** Ekspresi wajah pasien dapat memberikan informasi penting tentang kondisi psikologis, tingkat nyeri, kecemasan, ataupun kondisi emosional lainnya.
- **Keadaan Umum:** Meliputi status gizi, penampilan umum, tingkat kesadaran (apakah pasien sadar penuh, mengantuk, atau tidak responsif), serta tanda-tanda gangguan kesehatan yang umum tampak, seperti sesak napas, tremor, atau lemah.

Dalam inspeksi, tenaga kesehatan membutuhkan pencahayaan yang baik, pemeriksaan secara sistematis dari kepala hingga kaki, serta dokumentasi yang jelas tentang apa yang dilihat.

b. Palpasi

Palpasi merupakan pemeriksaan dengan menggunakan sentuhan atau tekanan ringan menggunakan tangan atau jari untuk menilai berbagai aspek tubuh pasien seperti tekstur, suhu, kelembutan, adanya benjolan, pembengkakan, dan getaran.

- **Tekstur dan Konsistensi:** Palpasi digunakan untuk merasakan tekstur kulit dan jaringan, seperti kasar, halus, atau keras yang dapat menunjukkan adanya kelainan jaringan.
- **Suhu Tubuh:** Pemeriksaan ini menggunakan punggung tangan untuk mendeteksi area tubuh yang hangat (infeksi atau inflamasi) atau dingin (kurangnya aliran darah).
- **Kelembutan atau Nyeri:** Menekan lembut area tertentu untuk mendeteksi adanya nyeri tekan yang mungkin menandakan inflamasi atau infeksi.
- **Pembengkakan atau Massa:** Meraba untuk mengidentifikasi adanya massa abnormal, seperti tumor atau pembengkakan akibat edema atau peradangan.

Palpasi dilakukan dengan hati-hati dan sistematis, dimulai dari sentuhan ringan ke tekanan yang lebih dalam tergantung pada tujuan pemeriksaan.

c. Perkusi

Perkusi merupakan teknik pemeriksaan dengan mengetuk bagian tubuh tertentu menggunakan jari tangan untuk mengevaluasi kondisi organ-organ dalam tubuh berdasarkan suara yang dihasilkan.

Tujuan perkusi antara lain untuk:

- **Menentukan Ukuran dan Batas Organ:** Misalnya batas paru-paru atau hati untuk mendeteksi pembesaran atau penyusutan organ.
- **Menilai Konsistensi Organ:** Menentukan apakah organ tersebut padat, berisi cairan, atau berisi udara.
- **Mendeteksi Adanya Cairan atau Udara Abnormal:** Misalnya cairan pada rongga abdomen (asites), udara pada rongga pleura (pneumotoraks), atau udara di usus yang meningkat (ileus).

Jenis suara perkusi:

- **Timpani:** Suara seperti drum, menunjukkan rongga berisi udara (misalnya pada abdomen).
- **Resonan:** Suara normal paru-paru yang sehat.
- **Hipersonan:** Suara yang lebih keras dan panjang, menandakan udara berlebihan seperti emfisema.
- **Redup (dullness):** Mengindikasikan organ padat atau cairan, seperti perkusi di atas hati atau paru-paru dengan pneumonia.
- **Flat:** Suara sangat redup seperti pada otot atau tulang.

d. Auskultasi

Auskultasi adalah teknik mendengarkan suara tubuh pasien menggunakan alat bantu stetoskop untuk menilai fungsi organ-organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan.

- **Suara Jantung:** Meliputi frekuensi, ritme, adanya bunyi tambahan seperti murmur, yang dapat menunjukkan kelainan jantung seperti gangguan katup atau gagal jantung.
- **Suara Paru-paru:** Untuk mendeteksi bunyi napas normal atau abnormal, seperti ronki, mengi (wheezing), atau krepitasi yang menunjukkan gangguan seperti asma, bronkitis, atau pneumonia.
- **Suara Abdomen:** Menilai bising usus untuk mendeteksi fungsi gastrointestinal. Bising usus berkurang dapat menandakan obstruksi usus, sedangkan bising meningkat bisa menunjukkan gangguan pencernaan seperti diare atau iritasi usus.

Teknik auskultasi membutuhkan lingkungan yang tenang, penempatan stetoskop yang tepat, serta kemampuan mendengarkan dan menginterpretasi suara tubuh secara akurat.

2. Metode Dokumentasi Hasil Pengkajian Fisik

Dokumentasi adalah bagian penting dari pengkajian fisik karena memberikan rekam medis yang jelas, tepat, dan akurat untuk mendukung kesinambungan perawatan pasien.

a. Prinsip Dokumentasi Pengkajian Fisik

Dokumentasi hasil pengkajian fisik harus mengikuti prinsip dasar berikut:

- **Jelas:** Data yang ditulis harus mudah dipahami, tanpa ambigu atau istilah yang samar.
- **Singkat:** Informasi disampaikan secara ringkas namun lengkap, tanpa menghilangkan detail yang penting.
- **Akurat:** Data harus faktual dan objektif, didasarkan pada pengamatan langsung dan pengukuran yang valid.
- **Sistematis:** Informasi disusun berdasarkan sistem tubuh atau format tertentu yang memudahkan analisis klinis dan pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan.

b. Contoh Dokumentasi Pengkajian Fisik

Berikut contoh dokumentasi hasil pengkajian fisik yang lengkap, jelas, dan sistematis:

Tabel 7.1: contoh dokumentasi hasil pengkajian fisik

Tanggal: 20 Mei 2025, Jam 08.00 WIB Kesadaran: Pasien sadar penuh (Compos Mentis), kooperatif. Vital Sign: TD 120/80 mmHg, Nadi 78 x/menit teratur, Respirasi 18 x/menit teratur, Suhu 36,8 °C. Kepala: Normosefal, tidak ada deformitas, rambut bersih. Mata: Sklera putih, konjungtiva tidak anemis, pupil isokor, refleks cahaya (+). Kulit: Warna normal, hangat saat palpasi, elastisitas kulit baik, tidak ada luka atau lesi. Paru-Paru: Simetris saat bernapas, suara vesikuler (+) bilateral, tidak ada suara tambahan. Jantung: Bunyi jantung S1S2 reguler, tidak ada murmur. Abdomen: Lunak, tidak nyeri tekan, bising usus normal (+). Ekstremitas: Tidak ada edema, kekuatan otot simetris dan normal bilateral. Catatan: Pasien tidak mengeluhkan nyeri atau ketidaknyamanan selama pemeriksaan.
--

C. Pengkajian Psikologis: Metode dan Implementasi

Pengkajian psikologis merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi psikologis pasien, termasuk aspek emosional, mental, sosial, dan perilaku. Pengkajian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif kondisi psikologis pasien guna merancang intervensi yang tepat dan efektif. Berikut uraian secara mendalam untuk masing-masing sub-point:

1. Prinsip dan Teknik Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik adalah dasar dari pengkajian psikologis yang efektif, bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menggali informasi mendalam dari pasien.

a. Empati

Empati adalah kemampuan tenaga kesehatan untuk merasakan dan memahami kondisi psikologis pasien dari perspektif pasien sendiri. Empati melibatkan aspek:

- **Pemahaman Emosional:** Berusaha merasakan apa yang dialami pasien tanpa terbawa emosi negatif.
- **Ekspresi Empati:** Menunjukkan kepedulian melalui bahasa tubuh (misalnya kontak mata, mengangguk, ekspresi wajah simpatik) dan kata-kata yang menunjukkan dukungan.
- **Validasi Emosi:** Mengakui dan menerima perasaan pasien sebagai sesuatu yang wajar dan penting.

Contoh kalimat empati:

"Saya memahami perasaan Ibu pasti berat menghadapi kondisi ini, saya di sini untuk mendengarkan dan mendukung Ibu."

b. Mendengarkan Aktif

Mendengarkan aktif adalah keterampilan untuk mendengarkan dengan sepenuhnya, tidak sekedar mendengar ucapan pasien, namun juga menangkap emosi, kebutuhan, serta pesan tersembunyi.

- **Konsentrasi Penuh:** Fokus perhatian penuh pada pasien tanpa distraksi.
- **Memberikan Respons yang Tepat:** Menggunakan isyarat verbal seperti "iya", "saya mengerti", atau bertanya secara terbuka untuk menunjukkan perhatian.
- **Parafrase dan Refleksi:** Mengulang atau menyimpulkan perkataan pasien agar memastikan bahwa tenaga kesehatan memahami dengan benar apa yang diutarakan pasien.

Contoh kalimat mendengarkan aktif:

"Yang saya tangkap dari penjelasan Bapak adalah Bapak merasa sangat cemas akhir-akhir ini karena kondisi kesehatan Bapak, apakah betul begitu?"

c. Memberikan Respons yang Tepat

Respons yang tepat adalah tanggapan yang relevan, sesuai dengan kebutuhan emosional pasien, serta membantu pasien merasa nyaman dalam berbagi informasi pribadi.

- **Respons Klarifikasi:** Memastikan informasi yang diberikan pasien jelas dan dipahami dengan baik.
- **Respons Supportif:** Memberikan dorongan dan dukungan emosional agar pasien merasa lebih nyaman dan aman.
- **Respons Edukatif:** Memberikan informasi yang relevan secara jelas dan tepat guna menurunkan kecemasan atau kebingungan pasien.

Contoh kalimat respons tepat:

"Saya sangat menghargai keberanian Ibu bercerita mengenai perasaan ini. Mari kita diskusikan lebih lanjut bagaimana kita bisa mengelola kondisi ini bersama."

2. Metode dalam Pengkajian Psikologis

Metode pengkajian psikologis mencakup beberapa pendekatan penting untuk mengumpulkan data secara valid dan komprehensif.

a. Wawancara Klinis

Wawancara klinis adalah metode pengumpulan informasi utama dalam pengkajian psikologis, yang dilakukan melalui percakapan terstruktur atau semi-terstruktur.

1) **Wawancara Terstruktur:**

- Menggunakan panduan atau checklist pertanyaan baku untuk memastikan semua aspek psikologis penting ditanyakan.
- Digunakan ketika diagnosis spesifik atau klarifikasi kondisi diperlukan (contoh: wawancara diagnostik gangguan mental seperti MINI, SCID).

2) **Wawancara Semi-Terstruktur:**

- Lebih fleksibel, menggunakan panduan umum namun memungkinkan eksplorasi mendalam sesuai respons pasien.
- Memungkinkan tenaga kesehatan mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan pengalaman pasien secara lebih rinci dan mendalam.

Contoh pertanyaan dalam wawancara semi-terstruktur:

- "Bisakah Ibu ceritakan tentang hal-hal yang membuat Ibu merasa cemas akhir-akhir ini?"

- “Apakah Bapak pernah merasa sedih atau putus asa yang berlangsung terus-menerus selama beberapa minggu terakhir?”

b. Observasi Perilaku

Observasi perilaku adalah metode untuk mengidentifikasi pola perilaku pasien melalui pengamatan secara langsung terhadap perilaku verbal maupun non-verbal pasien.

- 1) **Perilaku Verbal:** Meliputi nada suara, pola bicara (terlalu cepat, lambat, atau terputus-putus), serta isi pembicaraan.
- 2) **Perilaku Non-verbal:** Meliputi ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, postur tubuh, tremor, atau tanda-tanda ketidaknyamanan, kecemasan, atau depresi.

Contoh observasi:

Pasien tampak gelisah, sering menggerakkan tangan, berkeringat, dan berbicara dengan terbata-bata selama wawancara menunjukkan tanda kecemasan.

c. Penggunaan Alat Ukur Psikologis

Alat ukur psikologis merupakan instrumen standar yang digunakan untuk mengukur aspek psikologis tertentu secara objektif, seperti tingkat kecemasan, depresi, stres, fungsi kognitif, dan kondisi psikologis lainnya.

Contoh alat ukur psikologis:

- **Inventarisasi Kecemasan:** Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7).
- **Inventarisasi Depresi:** Beck Depression Inventory (BDI), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS).
- **Inventarisasi Stres:** Perceived Stress Scale (PSS).
- **Tes Fungsi Kognitif:** Mini-Mental State Examination (MMSE), Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

Penggunaan alat ukur ini penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil pengkajian.

3. Analisis dan Interpretasi Hasil Pengkajian Psikologis

Tahap akhir pengkajian psikologis melibatkan proses analisis dan interpretasi data untuk memahami secara komprehensif kondisi mental, emosional, dan perilaku pasien serta menyusun intervensi yang efektif.

- a. Identifikasi Kondisi Mental dan Emosional serta Implikasinya pada Kesehatan Fisik

- Menganalisis hasil wawancara, observasi, serta alat ukur psikologis untuk mengidentifikasi gangguan seperti kecemasan, depresi, stres, gangguan kognitif, atau gangguan mental lainnya.
 - Memahami bagaimana kondisi psikologis pasien berdampak pada aspek kesehatan fisik, seperti pasien dengan kecemasan tinggi yang mengalami gejala somatik seperti nyeri perut atau sesak napas.
- b. Penyusunan Intervensi Berdasarkan Hasil Pengkajian Psikologis
- Menyusun rencana intervensi berdasarkan data pengkajian, baik intervensi secara individual seperti konseling, psikoterapi, atau intervensi kelompok seperti terapi kelompok.
 - Melakukan rujukan ke spesialis psikolog atau psikiater jika kondisi psikologis pasien memerlukan intervensi khusus.
 - Menyusun edukasi kesehatan mental untuk pasien dan keluarga, agar lebih memahami kondisi psikologis serta mendukung proses pengobatan dan pemulihan pasien.

Contoh intervensi:

Pasien dengan tingkat kecemasan tinggi diberikan intervensi berupa teknik relaksasi progresif, konseling kognitif-perilaku, dan edukasi untuk mengelola kecemasan sehari-hari.

D. Integrasi dan Aplikasi Pengkajian Fisik dan Psikologis dalam Praktik Klinik

Integrasi pengkajian fisik dan psikologis dalam praktik klinik adalah pendekatan holistik yang memastikan kondisi pasien dievaluasi secara menyeluruh, baik aspek fisik maupun psikologis, guna memberikan intervensi yang optimal serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

1. Studi Kasus Integratif

Studi kasus integratif merupakan ilustrasi yang menunjukkan pentingnya menilai kondisi fisik dan psikologis pasien secara bersamaan dalam rangka membuat diagnosis, intervensi, dan perawatan yang lebih efektif serta holistik.

Ilustrasi Studi Kasus: Pasien Diabetes Mellitus dengan Kecemasan Tinggi

Profil Pasien:

- Nama: Ny. A
- Usia: 55 tahun
- Diagnosis medis: Diabetes Mellitus tipe 2, hipertensi
- Riwayat medis: Diabetes selama 10 tahun, mengalami neuropati perifer, hipertensi kronis terkontrol.

- Keluhan utama: Nyeri kronis di tungkai, sulit tidur, sering merasa cemas berlebihan, dan mudah lelah.

Pengkajian Fisik:

- Tanda-tanda vital: Tekanan darah 145/90 mmHg, denyut nadi 95 x/menit, suhu tubuh 37°C.
- Inspeksi: Ekspresi wajah tampak cemas, gerakan tubuh gelisah, kondisi kulit kering dengan luka kecil pada kaki kanan.
- Palpasi: Nyeri tekan dan kesemutan pada kedua tungkai bawah, suhu kulit normal.
- Perkusi dan auskultasi: Tidak ditemukan kelainan signifikan pada organ abdomen, paru-paru dan jantung dalam batas normal.

Pengkajian Psikologis:

- Wawancara klinis: Pasien melaporkan sering merasa cemas, sulit tidur, khawatir terhadap komplikasi diabetes seperti amputasi kaki, dan merasa putus asa.
- Observasi perilaku: Gelisah, sulit mempertahankan kontak mata, suara gemetar saat menjelaskan keluhan.
- Alat ukur psikologis: Pasien menunjukkan tingkat kecemasan tinggi (hasil GAD-7 skor 18), dan gejala depresi ringan hingga sedang (hasil BDI skor 15).

Integrasi Data:

- Pasien memiliki keluhan fisik berupa nyeri kronis terkait neuropati perifer akibat diabetes, dan masalah psikologis berupa kecemasan tinggi serta depresi ringan akibat kekhawatiran akan komplikasi diabetes.
- Kondisi psikologis memperparah persepsi nyeri dan ketidaknyamanan fisik, memperburuk kualitas tidur, serta menurunkan kepatuhan dalam pengelolaan diabetes.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengkajian fisik yang dilengkapi pengkajian psikologis agar diagnosis menjadi lebih akurat dan intervensi dapat dilakukan secara tepat, baik secara fisik maupun psikologis.

2. Intervensi Berdasarkan Pengkajian Integratif

Intervensi klinis berdasarkan hasil integrasi pengkajian fisik dan psikologis mencakup rencana tindakan yang secara bersamaan mengatasi kondisi fisik serta masalah psikologis pasien.

Contoh Intervensi yang Dirancang untuk Pasien dalam Kasus di Atas:

a. Intervensi Fisik:

- Pengelolaan nyeri melalui pemberian analgesik ringan yang tepat untuk neuropati perifer, seperti gabapentin, dengan dosis yang disesuaikan.

- Perawatan luka secara intensif untuk mencegah komplikasi serius pada kaki.
- Edukasi tentang pengendalian gula darah yang efektif dengan diet, olahraga ringan, dan kepatuhan terapi farmakologi (misalnya insulin atau obat hipoglikemik oral).
- Rujukan ke fisioterapi untuk latihan ringan yang membantu memperbaiki sirkulasi dan mengurangi rasa nyeri.

b. Intervensi Psikologis:

- Psikoedukasi mengenai diabetes dan manajemen kecemasan, untuk mengurangi persepsi ketakutan pasien terhadap komplikasi.
- Pelatihan teknik relaksasi progresif, meditasi mindfulness, dan teknik pernapasan dalam untuk menurunkan tingkat kecemasan.
- Konseling reguler (psikoterapi kognitif perilaku/CBT) untuk membantu pasien mengubah pola pikir negatif tentang diabetes dan mengurangi gejala depresi.
- Rujukan kepada psikolog klinis atau psikiater bila diperlukan terapi tambahan seperti farmakoterapi anti-depresan atau anti-kecemasan.

Dengan melakukan intervensi secara simultan (fisik dan psikologis), kondisi pasien akan membaik secara holistik, serta meningkatkan kualitas hidup dan kepatuhan pasien terhadap perawatan.

3. Pengelolaan dan Pendokumentasian Terintegrasi

Pengelolaan dan dokumentasi yang terintegrasi bertujuan agar setiap tindakan yang diberikan kepada pasien tercatat secara sistematis, jelas, dan lengkap, sehingga evaluasi dapat dilakukan dengan baik untuk menilai efektivitas intervensi.

a. Strategi Mendokumentasikan Hasil Pengkajian secara Holistik dalam Rekam Medis:

- 1) Gunakan **format SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan)** secara integratif:
 - **Subjective (S):** Keluhan pasien (fisik dan psikologis), termasuk emosi, pikiran, dan perasaan yang dilaporkan secara langsung oleh pasien.
 - **Objective (O):** Data hasil pemeriksaan fisik (tanda vital, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi) serta hasil observasi perilaku dan pengukuran psikologis (GAD-7, BDI, dll).
 - **Assessment (A):** Analisis kondisi kesehatan pasien yang menggabungkan data fisik dan psikologis, mencakup diagnosis medis serta diagnosis keperawatan dan psikologis.

- **Plan (P):** Rencana intervensi fisik dan psikologis, termasuk jadwal pelaksanaan dan evaluasi hasil intervensi.

Contoh dokumentasi integratif:

S: Pasien mengeluh nyeri berat pada tungkai bawah serta merasa sangat cemas terhadap komplikasi diabetes. Sulit tidur selama 3 minggu terakhir.

O: TD 145/90 mmHg, Nadi 95 x/mnt, ekspresi cemas, GAD-7 skor 18, BDI skor 15, luka kecil di kaki kanan, neuropati perifer.

A: Nyeri neuropati perifer terkait diabetes mellitus tipe 2; kecemasan tinggi dan depresi ringan.

P: Terapi analgesik (gabapentin 300 mg/hari), edukasi diabetes, teknik relaksasi dan CBT selama 4 sesi, evaluasi ulang kondisi dalam 1 minggu.

b. Evaluasi Efektivitas Intervensi Berdasarkan Dokumentasi Pengkajian:

Evaluasi dilakukan secara berkala dengan mengacu pada data dokumentasi yang sudah ada, untuk menilai efektivitas intervensi dan perawatan:

- **Evaluasi Nyeri:** Penurunan skor nyeri, observasi fisik kondisi luka, dan gejala neuropati.
- **Evaluasi Psikologis:** Penurunan skor kecemasan (GAD-7) dan depresi (BDI), laporan pasien terkait kualitas tidur dan rasa nyaman.
- **Evaluasi Kepatuhan Pasien:** Kepatuhan terhadap rekomendasi pengobatan, kontrol gula darah, serta partisipasi pasien dalam sesi terapi psikologis.

Dengan evaluasi rutin yang terdokumentasi secara integratif, tenaga kesehatan dapat memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan efektif, responsif terhadap perubahan kondisi pasien, serta memungkinkan penyesuaian perawatan secara tepat waktu.

E. Pengkajian Khusus dan Pertimbangan Etis serta Legal dalam Pengkajian

Pengkajian khusus serta pertimbangan etika dan legal merupakan aspek penting yang harus dipahami tenaga kesehatan agar proses pengkajian berjalan optimal, bertanggung jawab, serta sesuai dengan standar praktik profesional dan hukum yang berlaku.

1. Pengkajian Khusus Berdasarkan Kelompok Umur dan Kondisi Pasien

Pengkajian kesehatan harus disesuaikan dengan karakteristik khusus pasien berdasarkan kelompok usia dan kondisi tertentu untuk mendapatkan hasil yang akurat dan relevan.

a. Anak-Anak

- 1) **Pendekatan:** Gunakan teknik komunikasi ramah anak, permainan sederhana, dan alat bantu visual yang menarik perhatian anak.
 - 2) **Pengkajian fisik:** Observasi tumbuh-kembang, teknik pemeriksaan yang lembut agar anak nyaman.
 - 3) **Psikologis:** Evaluasi kondisi emosional anak melalui aktivitas bermain, menggambar, atau bercerita.
- b. Remaja
- 1) **Pendekatan:** Privasi dan rasa hormat sangat penting; gunakan komunikasi yang tidak menghakimi agar remaja merasa aman.
 - 2) **Pengkajian fisik:** Pemeriksaan sensitivitas fisik dengan menghormati privasi, terutama terkait kesehatan reproduksi.
 - 3) **Psikologis:** Identifikasi risiko perilaku remaja (kesehatan mental, kecanduan, seksualitas, gangguan makan, bullying) melalui wawancara terbuka dan alat ukur khusus.
- c. Dewasa
- 1) **Pendekatan:** Komunikasi langsung, jelas, informatif dengan penekanan pada kemitraan dan keterlibatan aktif pasien.
 - 2) **Pengkajian fisik:** Evaluasi menyeluruh kondisi sistem tubuh yang relevan dengan keluhan pasien.
 - 3) **Psikologis:** Penilaian kecemasan, stres, depresi, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
- d. Lansia
- 1) **Pendekatan:** Berkomunikasi dengan lambat, jelas, gunakan alat bantu visual atau pendengaran jika diperlukan.
 - 2) **Pengkajian fisik:** Fokus pada penurunan fungsi fisiologis (pendengaran, penglihatan, mobilitas, kognitif, risiko jatuh).
 - 3) **Psikologis:** Evaluasi fungsi kognitif (demensia), kondisi emosional (isolasi sosial, depresi), serta dukungan sosial.
- e. Kelompok Khusus (Ibu Hamil dan Pasien Terminal)
- 1) **Ibu Hamil:**
 - Fisik: Pemeriksaan antenatal rutin, evaluasi perkembangan janin, kesehatan ibu (tekanan darah, proteinuria, edema).
 - Psikologis: Evaluasi stres kehamilan, dukungan sosial, depresi prenatal, kecemasan menjelang persalinan.
 - 2) **Pasien Terminal:**

- Fisik: Fokus pada kenyamanan fisik, pengendalian nyeri, manajemen gejala fisik seperti mual, sesak napas, insomnia.
- Psikologis: Pengkajian mendalam tentang aspek emosional, spiritual, kebutuhan psikososial pasien dan keluarga terkait akhir kehidupan.

2. Aspek Etika dalam Pengkajian

Pengkajian kesehatan memerlukan pemahaman tentang prinsip etika yang harus selalu dipatuhi oleh tenaga kesehatan:

a. Otonomi Pasien

- Menghormati hak pasien untuk membuat keputusan atas kesehatannya.
- Memberikan informasi yang jelas sehingga pasien dapat membuat keputusan yang informatif dan mandiri.

b. Privasi dan Kerahasiaan

- Menjaga privasi pasien selama pengkajian dengan menyediakan ruang privat.
- Menjaga kerahasiaan data kesehatan pasien, tidak membocorkan informasi kepada pihak lain tanpa izin pasien.

c. Informed Consent

- Memastikan pasien memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai prosedur pengkajian.
- Meminta persetujuan secara tertulis atau verbal setelah pasien memahami sepenuhnya tujuan, risiko, dan manfaat pengkajian.

d. Prinsip Beneficence dan Non-maleficence

- Beneficence (berbuat baik): Melaksanakan pengkajian yang memberi manfaat nyata bagi pasien.
- Non-maleficence (tidak merugikan): Memastikan pengkajian dilakukan tanpa menimbulkan bahaya atau ketidaknyamanan yang tidak perlu.

3. Pertimbangan Legal dalam Pengkajian

Pemahaman aspek legal dalam pengkajian kesehatan membantu tenaga kesehatan menghindari risiko hukum dan malpraktik medis.

a. Kewajiban Hukum dalam Pengkajian

- Melaksanakan pengkajian sesuai kompetensi, standar prosedur operasional (SPO), dan standar profesi yang berlaku.
- Kewajiban menjaga data rekam medis pasien sebagai dokumen hukum yang sah, akurat, dan lengkap.

b. Dokumentasi yang Legal

- Setiap hasil pengkajian wajib didokumentasikan secara jelas, terstruktur, lengkap, dan bertanggung jawab dalam rekam medis pasien.
 - Rekam medis merupakan bukti hukum penting bila terjadi gugatan atau audit medis.
- c. Menghindari Malpraktik dan Kelalaian
- Memastikan kompetensi profesional dalam melakukan pengkajian, menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien.
 - Mengikuti panduan klinis, etika profesi, dan regulasi kesehatan untuk meminimalisasi risiko kesalahan medis.

4. Kompetensi Profesional dan Pengembangan Diri dalam Pengkajian

Kompetensi profesional merupakan dasar kualitas pelayanan pengkajian kesehatan, oleh karena itu penting bagi tenaga kesehatan untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan dan refleksi diri.

- a. Pentingnya Pelatihan Berkelanjutan
- Pelatihan reguler memperbarui pengetahuan terkini tentang teknik pengkajian fisik dan psikologis.
 - Mengikuti workshop, seminar, atau pendidikan lanjutan tentang metode terbaru dalam pengkajian, sehingga tenaga kesehatan selalu kompeten sesuai standar mutakhir.
- b. Strategi Refleksi Diri
- Refleksi diri secara rutin membantu tenaga kesehatan mengevaluasi kemampuan, kelebihan, dan kekurangan dalam praktik pengkajian.
 - Mempertahankan jurnal refleksi pribadi, mencatat tantangan dalam praktik, serta langkah-langkah untuk mengatasinya.
- c. Supervisi Klinis
- Supervisi klinis dengan mentor atau senior berpengalaman untuk mendapatkan masukan konstruktif tentang keterampilan pengkajian.
 - Membantu mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan keterampilan atau pengetahuan tambahan.
- d. Evaluasi dan Pengukuran Kompetensi
- Melaksanakan evaluasi kompetensi reguler secara formal maupun informal.
 - Menggunakan feedback dari pasien, rekan kerja, serta hasil audit klinis sebagai sarana meningkatkan kompetensi.

F. Latihan Soal

Soal Pilihan Ganda

Kasus 1

Seorang pasien laki-laki (40 tahun) masuk rumah sakit dengan keluhan nyeri dada dan sesak napas. Perawat ingin melakukan pengkajian kesehatan awal. Manakah tujuan utama dari pengkajian fisik dalam kasus ini?

- A. Mengidentifikasi riwayat penyakit sebelumnya
- B. Mengevaluasi secara objektif kelainan fisiologis pasien
- C. Mengukur kemampuan coping pasien terhadap nyeri
- D. Menilai dampak psikologis dari nyeri dada
- E. Mengidentifikasi persepsi pasien terhadap penyakit

Kunci jawaban: B

Rasional:

Tujuan utama pengkajian fisik adalah untuk mengevaluasi secara objektif kelainan fisiologis yang dialami oleh pasien. Dalam kasus ini, kelainan fisiologis seperti gangguan pada sistem kardiorespirasi harus segera dideteksi agar dapat diberikan intervensi medis yang tepat.

Kasus 2

Pasien perempuan (30 tahun) dirawat karena serangan panik yang berulang. Saat pengkajian, pasien terlihat gelisah, berkeringat, dan sering menghindari kontak mata. Teknik komunikasi terapeutik manakah yang paling tepat diterapkan perawat?

- A. Menggunakan komunikasi yang formal dan langsung
- B. Memberikan nasihat dengan tegas untuk menghentikan perilaku cemas
- C. Meminta pasien tenang agar pemeriksaan selesai lebih cepat
- D. Menunjukkan empati dan mendengarkan secara aktif
- E. Meminta pasien menjelaskan gejalanya secara ringkas

Kunci jawaban: D

Rasional:

Teknik komunikasi terapeutik yang paling tepat dalam kondisi ini adalah menunjukkan empati dan mendengarkan aktif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga pasien merasa nyaman dan aman dalam menyampaikan masalah psikologisnya.

Kasus 3

Seorang pasien lansia (70 tahun) dengan riwayat hipertensi datang ke klinik dengan keluhan sakit kepala hebat dan sulit tidur sejak seminggu terakhir. Saat melakukan inspeksi, tanda apakah yang menunjukkan pasien mungkin mengalami gangguan serius pada sistem kardio-vaskular?

- A. Kulit pucat dan bibir sianosis
- B. Postur tubuh membungkuk
- C. Ekspresi wajah tampak cemas
- D. Adanya tremor pada ekstremitas atas
- E. Penampilan umum tampak lelah

Kunci jawaban: A

Rasional:

Kulit pucat dan bibir sianosis merupakan tanda objektif penting yang menunjukkan adanya gangguan sirkulasi darah atau kekurangan oksigen akibat gangguan sistem kardio-vaskular yang serius, seperti gagal jantung atau gangguan vaskuler lainnya.

Kasus 4

Pasien perempuan (50 tahun) menderita diabetes mellitus tipe 2 selama 8 tahun. Pasien melaporkan rasa kesemutan dan nyeri hebat pada kedua tungkai serta sering merasa cemas dan takut terjadi komplikasi amputasi. Apa intervensi yang paling tepat dilakukan oleh perawat berdasarkan pengkajian integratif?

- A. Fokus pada pemberian analgesik untuk mengurangi nyeri saja
- B. Mengedukasi pasien tentang manajemen gula darah tanpa memperhatikan kecemasan pasien
- C. Merujuk pasien hanya kepada psikiater
- D. Memberikan intervensi fisik (analgesik, perawatan luka) serta psikologis (relaksasi, konseling) secara simultan
- E. Menyarankan pasien agar rutin kontrol tanpa intervensi tambahan

Kunci jawaban: D

Rasional:

Intervensi paling tepat adalah memberikan intervensi fisik (untuk mengurangi nyeri neuropati perifer akibat diabetes) bersamaan dengan intervensi psikologis (mengatasi kecemasan dan ketakutan pasien terhadap komplikasi) secara simultan. Pendekatan integratif ini memastikan perawatan holistik dan meningkatkan efektivitas pengobatan.

Kasus 5

Seorang perawat melakukan pengkajian psikologis terhadap pasien remaja (16 tahun) yang mengalami perubahan perilaku dan terlihat menyendiri. Pasien sulit diajak berkomunikasi secara langsung. Metode pengkajian psikologis apa yang paling tepat digunakan oleh perawat dalam kondisi ini?

- A. Observasi perilaku secara langsung dan wawancara semi-terstruktur
- B. Wawancara terstruktur yang ketat dengan pertanyaan tertutup

- C. Tes laboratorium untuk menilai kondisi kesehatan fisik
- D. Pemeriksaan fisik lengkap secara langsung tanpa wawancara
- E. Meminta orang tua menjawab semua pertanyaan pengkajian

Kunci jawaban: A

Rasional:

Dalam kondisi pasien remaja yang tertutup dan sulit diajak berbicara secara langsung, observasi perilaku dan wawancara semi-terstruktur paling tepat digunakan. Metode ini memungkinkan eksplorasi mendalam dengan pendekatan fleksibel, serta mengidentifikasi pola perilaku verbal dan non-verbal secara lebih efektif.

G. Rangkuman Materi

Pengkajian fisik dan psikologis merupakan komponen inti dalam pelayanan kesehatan, yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan pasien. Pengkajian fisik bertujuan mendeteksi kelainan fisiologis melalui teknik pemeriksaan seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, sementara pengkajian psikologis bertujuan menilai status mental, emosional, dan perilaku pasien melalui wawancara klinis, observasi perilaku, serta penggunaan alat ukur psikologis.

Keterampilan komunikasi terapeutik dan pendekatan holistik menjadi prinsip dasar yang mendukung efektifnya proses pengkajian. Komunikasi terapeutik melibatkan empati, mendengarkan aktif, kejelasan, kejujuran, serta sikap tidak menghakimi, sehingga pasien merasa nyaman dalam berbagi informasi. Pendekatan holistik memastikan bahwa aspek fisik, mental, emosional, sosial, serta spiritual pasien dikaji secara terpadu untuk merumuskan intervensi yang tepat.

Integrasi pengkajian fisik dan psikologis sangat penting dalam praktik klinik, mengingat adanya hubungan erat dan timbal balik antara kedua aspek ini. Pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes mellitus menunjukkan bahwa gangguan fisik dapat memperburuk kondisi psikologis dan sebaliknya. Oleh karena itu, perawatan yang integratif—menggabungkan intervensi medis, fisik, serta psikologis—merupakan pendekatan terbaik untuk mencapai hasil terapi yang optimal.

Selain itu, pengkajian khusus berdasarkan karakteristik pasien seperti usia (anak-anak, remaja, dewasa, lansia) maupun kondisi khusus (ibu hamil dan pasien terminal), perlu disesuaikan untuk mendapatkan hasil yang valid dan relevan. Aspek etika seperti menghormati otonomi pasien, privasi, kerahasiaan, dan informed consent, serta aspek legal seperti dokumentasi rekam medis dan kewajiban hukum tenaga kesehatan, menjadi pertimbangan penting dalam praktik pengkajian.

Terakhir, kompetensi profesional harus senantiasa dikembangkan melalui pelatihan berkelanjutan, refleksi diri, supervisi klinis, serta evaluasi berkala, sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan layanan pengkajian yang profesional, efektif, aman secara etis dan legal, serta optimal dalam memenuhi kebutuhan pasien secara holistik.

H. Glosarium

Pengkajian Kesehatan

Proses sistematis dalam mengumpulkan, memvalidasi, menganalisis, dan mendokumentasikan data status kesehatan pasien untuk merencanakan intervensi medis atau keperawatan.

Pengkajian Fisik

Pemeriksaan objektif untuk mendeteksi kelainan atau gangguan fisiologis melalui metode inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

Pengkajian Psikologis

Evaluasi kondisi mental, emosional, dan perilaku pasien untuk mengidentifikasi kondisi seperti kecemasan, depresi, stres, kemampuan coping, serta risiko perilaku maladaptif.

Komunikasi Terapeutik

Teknik komunikasi profesional yang membantu pasien mengungkapkan perasaan dan pikiran secara nyaman, mencakup empati, mendengarkan aktif, kejelasan, kejujuran, serta sikap tidak menghakimi.

Pendekatan Holistik

Pendekatan yang menilai pasien secara menyeluruh meliputi aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual, untuk merancang intervensi yang sesuai kebutuhan pasien secara komprehensif.

Inspeksi

Observasi visual terhadap kondisi fisik pasien seperti warna kulit, postur tubuh, ekspresi wajah, serta keadaan umum pasien.

Palpasi

Pemeriksaan melalui perabaan untuk mengevaluasi tekstur, suhu tubuh, kelembutan, pembengkakan, atau massa abnormal.

Perkusi

Teknik pemeriksaan dengan mengetuk tubuh untuk menentukan ukuran, batas, dan konsistensi organ dalam, serta mendeteksi cairan atau udara abnormal.

Auskultasi

Teknik mendengarkan suara tubuh menggunakan stetoskop untuk mengevaluasi fungsi organ seperti jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan.

Integrasi Pengkajian

Kombinasi pengkajian fisik dan psikologis untuk memahami hubungan timbal balik antara kondisi fisiologis dan psikologis pasien, guna merancang intervensi holistik.

Informed Consent

Persetujuan pasien yang diperoleh setelah pasien mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tujuan, manfaat, dan risiko dari tindakan medis atau pemeriksaan kesehatan.

Beneficence dan Non-maleficence

Prinsip etika dasar yang mengharuskan tenaga kesehatan melakukan tindakan yang memberi manfaat nyata (beneficence) serta menghindari tindakan yang merugikan pasien (non-maleficence).

Rekam Medis

Dokumentasi resmi yang berisi informasi kesehatan pasien, hasil pemeriksaan fisik dan psikologis, serta intervensi yang dilakukan, berfungsi sebagai bukti hukum dan sarana kesinambungan perawatan.

I. Daftar Pustaka

- Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Flynn Makic, M. B., Martinez-Kratz, M. R., & Zanotti, M. (2020). *Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based Guide to Planning Care* (12th ed.). Elsevier.
- Bickley, L. S., & Szilagyi, P. G. (2020). *Bates' Guide to Physical Examination and History Taking* (13th ed.). Wolters Kluwer.
- Brown, D., Edwards, H., Buckley, T., & Aitken, R. L. (2021). *Lewis's Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems* (5th ed.). Elsevier.
- Choi, E. P. H., Hui, B. P. H., & Wan, E. Y. F. (2020). Depression and anxiety in patients with chronic diseases: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(18), 6674. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186674>
- Davis, S. L., & Nicoll, L. H. (2020). *Contemporary Nursing: Issues, Trends, & Management* (9th ed.). Elsevier.
- Forbes, H., Watt, E., & Jarvis, C. (2020). *Jarvis's Physical Examination and Health Assessment* (3rd Australian and New Zealand ed.). Elsevier Australia.
- Gulanick, M., & Myers, J. L. (2021). *Nursing Care Plans: Diagnoses, Interventions, and Outcomes* (10th ed.). Elsevier.
- Keeley, P., Wolf, Z., Regul, L., & Jadwin, A. (2021). Effective therapeutic communication in nursing practice: A literature review. *Journal of Nursing Scholarship*, 53(6), 705-715. <https://doi.org/10.1111/jnu.12680>

- Kourakos, M., & Fradelos, E. (2020). Holistic nursing assessment: The importance of evaluating patients holistically. *International Journal of Caring Sciences*, 13(1), 556-561.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Rhoads, J., & Jensen, M. M. (2020). *Advanced Health Assessment and Diagnostic Reasoning* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Videbeck, S. L. (2020). *Psychiatric-Mental Health Nursing* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Yoost, B., & Crawford, L. (2020). *Fundamentals of Nursing: Active Learning for Collaborative Practice* (3rd ed.). Elsevier.
- Zaccagnini, M., & Pechacek, J. M. (2021). *The Doctor of Nursing Practice Essentials: A New Model for Advanced Practice Nursing* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.

PROFIL PENULIS



Dewi Nur Sukma Purqoti, S.Kep., Ners., M.Kep. Lahir di Dusun Pancordao, Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 Mei 1987, Lulus D3 Keperawatan pada tahun 2008 di AKPER Yarsi Mataram yang saat ini menjadi STIKES YARSI Mataram, sebelum melanjutkan studi profesi Ners dan lulus pada tahun 2013 di STIKES Yarsi Mataram, ia pernah bekerja sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram dari tahun 2008-2010 dan pada tahun 2017 ia sukses menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) keperawatan peminatan keperawatan medikal bedah di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan judul thesis pengaruh Konseling Spiritual Terhadap kemampuan adaptasi psikologis pasien stroke. Dari tahun 2018 ia fokus meneliti tentang kasus-kasus paliatif. Dia juga aktif dalam organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Himpunan Perawat Holistik Indonesia (HPHI) NTB. Selain itu ia pun aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang dosen.

Email Penulis: purqotidewi87@gmail.com



Christina Yeni Kustanti, S.Kep., Ns., M.Nur., M.Pall.C., Ph.D Lahir di Yogyakarta, 29 Januari 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 di Akademi Keperawatan Bethesda Yakkum Yogyakarta pada 1999. S1 dan Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Charles Darwin University dan Flinders University, Australia di tahun 2010 dan 2013. Stud S3 diselesaikan pada 2023 di Taipei Medical University, Taiwan. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta sejak tahun 2003. Penulis

aktif dalam berbagai kegiatan Tri-dharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi artikel, pengelola jurnal (nasional/internasional), reviewer jurnal (nasional/internasional), ketua LPPM, narasumber seminar/pelatihan, penulis buku, serta *founder* untuk BerCa.my.id, sebuah *website* untuk dukungan *bereavement* secara virtual. Karya ilmiah penulis banyak berhubungan dengan perawatan paliatif, khususnya *bereavement care*, menggunakan berbagai pendekatan penelitian seperti kualitatif, *literature review*, dan meta-analysis. Penulis juga aktif sebagai pengurus himpunan perawat onkologi (HIMPONI) dan perawat paliatif (INPANA). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yeni@stikesbethesda.ac.id

PROFIL PENULIS



Ana Fadilah, lahir di Surabaya pada 15 Mei 1976, merupakan seorang akademisi dan praktisi keperawatan dengan pengalaman yang luas di bidangnya. Saat ini, beliau adalah staf pengajar tetap di ITEKES Cendekia Utama Kudus. Latar belakang pendidikan Ana Fadilah mencerminkan komitmennya terhadap pengembangan keilmuan di bidang keperawatan. Beliau menyelesaikan Diploma III Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun 1999, melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Ners di Universitas

Airlangga Surabaya pada tahun 2002, dan memperoleh gelar Magister Manajemen Keperawatan dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2016.

Sebagai seorang profesional, Ana Fadilah memiliki pengalaman kerja yang kaya di dunia keperawatan. Beliau pernah bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dengan penugasan di Bangsal Interna (2006–2007), Instalasi Gawat Darurat (2007), serta menjabat sebagai Kepala Bidang Keperawatan (2007–2010). Selain itu, beliau juga mengemban tanggung jawab sebagai Clinical Instructor pada periode yang sama.

Dalam dunia pendidikan, Ana Fadilah pernah menjadi pengajar di AKPER PEMDA Lamongan (2008–2009) dan STIKES Muhammadiyah Lamongan (2007–2010). Sejak tahun 2015, beliau bergabung sebagai Dosen tetap di ITEKES Cendekia Utama Kudus, di mana beliau terus berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dan pelatihan tenaga keperawatan.

Saat ini, Ana Fadilah sedang menempuh pendidikan lanjut di National Taipei University of Nursing and Health Sciences untuk meraih gelar Doktor (Ph.D.). Sebagai kandidat doktor, beliau fokus pada penelitian di bidang pelayanan perawatan paliatif, yang menjadi salah satu kontribusi signifikan bagi pengembangan praktik keperawatan di Indonesia dan internasional. Dengan dedikasi dan pengalaman yang luas, Ana Fadilah terus berupaya memberikan dampak positif bagi profesi keperawatan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ana.fadilah15@gmail.com

Motto: "Living your life well"

PROFIL PENULIS



Ns. Syafrina Arbaani Djuria, S.Kep., M.Kep Lahir di Pangkalpinang, 05 September 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Pendidikan Profesi Ners di kampus yang sama, dan melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan Peminatan Onkologi pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 **sebagai asdos di UMY, kemudian berpindah di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang selama 8,5 tahun.** Saat ini penulis bekerja di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengampu mata kuliah keperawatan paliatif, konsep dasar keperawatan, keperawatan dasar, dll. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pelatihan, GPMPP Fakultas, auditor, dll. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syafrina@untirta.ac.id
Motto: "Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain"



Sri Hartini.,S.Kep.,Ners.,M.Kes Lahir di Demak, 01 Maret 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII keperawatan ASIH Husada Semarang Tahun 2000, S1 Keperawatan STIKES Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2004, program profesi Ners STIKES Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2005 . Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan di Universitas Diponegoro Semarang dan lulus pada tahun 2011. Bekerja sebagai dosen pada tahun 2005 Di STIKES Cendekia Utama Kudus yang saat ini sudah menjadi ITEKES Cendekia utama kudus sampai sekarang. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Program Studi Sarjana keperawatan dan Program Profesi Ners Di ITEKES Cendekia utama kudus mengampu mata kuliah Keperawatan paliatif, keperawatan anak, Keperawatan Dasar, Metodologi penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hartinisumarto78@gmail.com
Motto: "Belajar, Berbagi, Berarti"

PROFIL PENULIS



Hetti Marlina Pakpahan, SKM, S.Kep, Ns, M.Kep

Riwayat Pendidikan:

Menyelesaikan Pendidikan DIII Keperawatan di Fakultas Non Gelar Kesehatan Universitas Darma Agung lulus pada tahun 1988.

Penulis melanjutkan pendidikan S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Sumatera Utara

Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Bidan Program B di Akademi Keperawatan Wijaya Kusuma Lulus pada tahun 2006.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Darma Agung lulus pada tahun 2009.

Penulis melanjutkan pendidikan Profesi Ners di STIKes Sumatera Utara lulus pada tahun 2012. Sejak tahun 1996 penulis bekerja sebagai perawat di RSUD Harna Medan sampai tahun 2001. Dan tahun 2001 sd sekarang menjadi Dosen Profesional di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Darma Agung. Penulis memiliki kepakaran dalam Bidang Maternitas dan Manajemen Keperawatan.

Penulis dapat dihubungi melalui E_mail : hettiskepns@yahoo.co.id

Pesan untuk para pembaca

“gunakan waktu untuk berkarya”

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Paliatif menyajikan penjelasan komprehensif tentang pendekatan dan prinsip-prinsip penting dalam perawatan paliatif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronik maupun terminal. Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan memahami secara mendalam berbagai aspek penting seperti manajemen gejala, komunikasi terapeutik, spiritualitas pasien, serta penanganan nyeri yang efektif. Setiap bab menyajikan materi secara terstruktur, dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman, dan glosarium untuk memperkuat pemahaman.

Di dalam buku ini, pembaca juga akan menemukan pembahasan mendetail mengenai patofisiologi penyakit kronik dan terminal, dengan fokus pada penyakit sistem kardiovaskular, respirasi, dan kanker stadium lanjut. Selain itu, konsep komunikasi dan pendekatan spiritual dalam perawatan paliatif juga dikupas secara mendalam untuk membekali perawat dalam menghadapi berbagai tantangan emosional dan spiritual pasien serta keluarganya. Dengan demikian, buku ini mampu menjadi acuan penting dalam memberikan pelayanan yang holistik dan humanis.

Tidak kalah penting, buku ini menyoroti integrasi pengkajian fisik dan psikologis dalam praktik klinis yang sangat krusial dalam menentukan intervensi keperawatan paliatif yang tepat. Materi disajikan secara praktis dan aplikatif, sehingga perawat mampu menerapkan langsung di lapangan untuk mendukung pasien dalam mencapai kenyamanan dan kualitas hidup terbaik di masa-masa kritis mereka. Buku ini merupakan panduan esensial bagi para praktisi keperawatan yang berkomitmen dalam memberikan asuhan paliatif yang empatik, efektif, dan profesional.

Buku Ajar Keperawatan Paliatif menyajikan penjelasan komprehensif tentang pendekatan dan prinsip-prinsip penting dalam perawatan paliatif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronik maupun terminal. Buku ini dirancang untuk membantu mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan memahami secara mendalam berbagai aspek penting seperti manajemen gejala, komunikasi terapeutik, spiritualitas pasien, serta penanganan nyeri yang efektif. Setiap bab menyajikan materi secara terstruktur, dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman, dan glosarium untuk memperkuat pemahaman. Di dalam buku ini, pembaca juga akan menemukan pembahasan mendetail mengenai patofisiologi penyakit kronik dan terminal, dengan fokus pada penyakit sistem kardiovaskular, respirasi, dan kanker stadium lanjut. Selain itu, konsep komunikasi dan pendekatan spiritual dalam perawatan paliatif juga dikupas secara mendalam untuk membekali perawat dalam menghadapi berbagai tantangan emosional dan spiritual pasien serta keluarganya. Dengan demikian, buku ini mampu menjadi acuan penting dalam memberikan pelayanan yang holistik dan humanis. Tidak kalah penting, buku ini menyoroti integrasi pengkajian fisik dan psikologis dalam praktik klinis yang sangat krusial dalam menentukan intervensi keperawatan paliatif yang tepat. Materi disajikan secara praktis dan aplikatif, sehingga perawat mampu menerapkan langsung di lapangan untuk mendukung pasien dalam mencapai kenyamanan dan kualitas hidup terbaik di masa-masa kritis mereka. Buku ini merupakan panduan esensial bagi para praktisi keperawatan yang berkomitmen dalam memberikan asuhan paliatif yang empatik, efektif, dan profesional.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

